

Buku Ajar

KEPERAWATAN GERONTIK

Heri Triwibowo • Lola Illona Elfani Kausar • Deni Metri
Anik Supriani • Dely Maria P • Daning Widi Istianti
Ali Syahbana



BUKU AJAR

KEPERAWATAN GERONTIK

Penulis:

Heri Triwibowo, S.KM., S.Kep., Ns., M.Kes.
Lola Illona Elfani Kausar, S.Kep., Ns., M.Kep.
Ns Deni Metri, S.Kep., M.Kes.
Anik Supriani, S.Kep., Ns., M.Kes.
Ns. Dely Maria P, M.Kep., Sp.Kep.Kom.
Daning Widi Istianti, S.Kep., Ns., MSN.
Ali Syahbana, S.Kep., Ners., M.Kes.



BUKU AJAR KEPERAWATAN GERONTIK

Penulis: Heri Triwibowo, S.KM., S.Kep., Ns., M.Kes.

Lola Illona Elfani Kausar, S.Kep., Ns., M.Kep.

Ns Deni Metri, S.Kep., M.Kes.

Anik Supriani, S.Kep., Ns., M.Kes.

Ns.Dely Maria P, M.Kep., Sp.Kep.Kom.

Daning Widi Istianti, S.Kep., Ns., MSN.

Ali Syahbana, S.Kep., Ners., M.Kes.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-7426-28-4

Cetakan Pertama : Oktober, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Berkat kasih dan pertolongan-Nya, Buku Ajar Keperawatan Gerontik ini dapat tersusun dan diselesaikan dengan baik. Penyusunan buku ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan bahan ajar yang komprehensif, mutakhir, dan kontekstual dalam bidang keperawatan gerontik, seiring dengan meningkatnya populasi lanjut usia di Indonesia maupun dunia.

Fenomena aging population telah menjadi tantangan besar di bidang kesehatan. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk lansia yang terus meningkat dihadapkan pada berbagai permasalahan kompleks yang berkaitan dengan kesehatan fisik, psikologis, sosial, maupun spiritual lansia. Kondisi tersebut menuntut tenaga keperawatan untuk memiliki kompetensi yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga humanistik, empatik, dan berbasis bukti ilmiah (evidence-based nursing). Oleh karena itu, pembelajaran keperawatan gerontik menjadi salah satu fondasi penting dalam pendidikan tinggi keperawatan.

Buku ajar ini disusun dengan tujuan untuk memberikan panduan belajar yang sistematis dan terintegrasi bagi mahasiswa keperawatan, khususnya dalam memahami konsep dasar, teori, dan penerapan praktik keperawatan pada lansia. Isi buku ini mencakup berbagai topik yang meliputi konsep proses penuaan, perubahan anatomi dan fisiologi pada lansia, masalah-masalah kesehatan yang umum terjadi, peran dan tanggung jawab perawat dalam asuhan keperawatan gerontik, hingga pendekatan komunikasi terapeutik, etika, dan spiritualitas dalam memberikan asuhan keperawatan.

Selain itu, buku ini juga mengintegrasikan hasil-hasil penelitian terkini serta pedoman dari organisasi profesi seperti Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), World Health Organization (WHO), dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dengan demikian, buku ini diharapkan mampu memperkaya pengetahuan mahasiswa dan menjadi acuan dalam praktik keperawatan berbasis bukti serta kebijakan kesehatan nasional.

Dalam penyusunannya, penulis berupaya menggunakan bahasa yang mudah dipahami tanpa mengurangi kedalaman ilmiah materi. Setiap bab disusun secara sistematis agar pembaca dapat mengikuti alur berpikir secara logis, mulai dari konsep dasar hingga penerapan klinis. Buku ini juga dilengkapi dengan contoh kasus, refleksi

klinis, serta latihan soal yang dapat membantu mahasiswa dalam mengasah kemampuan analisis, berpikir kritis, dan pengambilan keputusan keperawatan.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran, kritik, dan masukan yang membangun sangat diharapkan dari para pembaca, dosen, mahasiswa, dan praktisi keperawatan demi penyempurnaan isi dan penyajian buku ini pada edisi-edisi berikutnya.

Akhirnya, penulis berharap Buku Ajar Keperawatan Gerontik ini dapat menjadi salah satu referensi utama dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi keperawatan serta menjadi kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas pelayanan keperawatan bagi lansia di Indonesia. Semoga buku ini memberikan manfaat yang luas bagi dunia pendidikan, profesi keperawatan, dan masyarakat, serta menjadi amal jariyah bagi semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunannya.

Penulis

Oktober, 2025

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

BAB 1 KONSEP LANSIA	1
----------------------------------	----------

A. Definisi Lanjut Usia.....	3
B. Klasifikasi Lanjut Usia.....	3
C. Teori Penuaan	4
D. Tugas Perkembangan Lanjut Usia	5
E. Faktor yang Mempengaruhi Penuaan.....	6
F. Perubahan-Perubahan yang Terjadi pada Lanjut Usia.....	7
G. Masalah yang Sering Muncul pada Lanjut Usia.....	8
H. Latihan Soal.....	9
I. Rangkuman Materi.....	10
J. Glosarium.....	12
K. Daftar Pustaka.....	12

BAB 2 KONSEP KEPERAWATAN GERONTIK	15
--	-----------

A. Pengertian Keperawatan Gerontik.....	17
B. Fokus Keperawatan Gerontik.....	18
C. Tujuan Keperawatan Gerontik.....	19
D. Peran Perawat Gerontik.....	21
E. Fungsi Perawat Gerontik	23
F. Sifat Pelayanan Gerontik	26
G. Sifat layanan dan sarana Keperawatan gerontik.....	27
H. Latihan Soal.....	28
I. Rangkuman Materi.....	29
J. Glosarium.....	30
K. Daftar Pustaka.....	31

BAB 3 MODEL KEPERAWATAN GERONTIK.....	33
--	-----------

A. Model Keperawatan menurut Madeleine Leininger	35
B. Model Keperawatan menurut Model Callista Roy	40
C. Model Keperawatan menurut Konseptual model Orem	43

D. Model Keperawatan menurut Teori Martha E. Rogers.....	46
E. Model Keperawatan menurut Model Betty Neuman	47
F. Model Keperawatan menurut Model Virginia Henderson.....	49
G. Latihan Soal.....	51
H. Rangkuman Materi.....	53
I. Glosarium.....	54
J. Daftar Pustaka.....	55

BAB 4 PROSES KEPERAWATAN PADA INDIVIDU DAN KELOMPOK KHUSUS LANSIA.....57

A. Konsep Dasar Proses Keperawatan pada Lansia	60
B. Pengkajian Keperawatan pada lansia (Kurdi Fahrudin. dkk, 2025)	61
C. Diagnosa keperawatan	77
D. Intervensi dan Implementasi	78
E. Evaluasi dan dokumentasi	92
F. Latihan Soal.....	104
G. Rangkuman Materi.....	105
H. Glosarium.....	106
I. Daftar Pustaka.....	108

BAB 5 PROSEDUR PENGKAJIAN PADA LANSIA.....109

A. Pengkajian Fisik Lansia.....	111
B. Penilaian tingkat kemandirian.....	111
C. Pengkajian Status Mental Gerontik.....	115
D. Penilaian Depresi Lanjut Usia	120
E. Penilaian Status Nutrisi	121
G. Latihan Soal.....	127
H. Rangkuman Materi.....	129
I. Glosarium.....	129
J. Referensi	130

BAB 6 APLIKASI ASUHAN KEPERAWATAN PADA LANSIA DALAM KONTEKS INDIVIDU.....131

A. Prinsip Pemberian Asuhan Keperawatan	133
B. Aplikasi Kasus Asuhan Keperawatan pada Lansia.....	136

C. Peran perawat dalam asuhan individu lansia	143
D. Latihan Soal.....	144
E. Rangkuman Materi.....	146
F. Glosarium.....	147
G. Referensi	147

BAB 7 APLIKASI ASUHAN KEPERAWATAN PADA LANSIA DALAM KONTEKS KELOMPOK.....	149
A. Memahami Konsep Dasar Keperawatan Kelompok Lansia	153
B. Mengidentifikasi Kebutuhan Kesehatan Lansia dalam Kelompok	157
C. Menyusun Rencana Asuhan Keperawatan untuk Kelompok Lansia.....	161
D. Mengimplementasikan Intervensi Keperawatan Kelompok Lansia:	165
E. Mengevaluasi Efektivitas Asuhan Keperawatan Kelompok Lansia.....	169
F. Mengidentifikasi Tantangan dalam Keperawatan Kelompok Lansia dan Solusi yang Tepat.....	173
G. Latihan Soal.....	177
H. Rangkuman Materi.....	180
I. Glosarium.....	181
PROFIL PENULIS	185

BAB 1

KONSEP LANSIA

Tujuan Intruksional:

- Menjelaskan konsep/ definisi lanjut usia (lansia)
- Menjelaskan klasifikasi lanjut usia
- Menjelaskan teori menua
- Menjelaskan tugas perkembangan lanjut usia
- Menjelaskan faktor yang mempengaruhi penuaan
- Menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi pada lansia (bio-psiko-sosio-spiritual)
- Menjelaskan masalah yang sering muncul pada lanjut usia

Capaian Pembelajaran:

- Mampu menjelaskan konsep lansia dan teori menua yang digunakan dalam keperawatan gerontik
- Mampu memberikan asuhan keperawatan gerontik secara profesional pada tatanan klinik dan komunitas dengan memahami konsep lansia dan teori menua

Pendahuluan

Proses menua merupakan fenomena biologis yang pasti dialami oleh setiap individu yang hidup cukup lama. Penuaan bukanlah suatu penyakit, melainkan fase alami dalam siklus kehidupan manusia yang mengalami perubahan pada biopsiko sosio dan spiritual. Seiring bertambahnya usia, tubuh mengalami penurunan fungsi organ, daya tahan terhadap stres menurun, dan risiko timbulnya berbagai penyakit degeneratif meningkat. Namun, menua juga merupakan masa yang kaya akan pengalaman, kebijaksanaan, dan nilai kehidupan yang dapat menjadi sumber inspirasi bagi generasi berikutnya.

Lanjut usia (lansia) sebagai kelompok populasi memiliki karakteristik dan kebutuhan khusus yang berbeda dari kelompok usia lainnya. Pertambahan jumlah lansia secara global, termasuk di Indonesia, memberikan tantangan sekaligus peluang dalam bidang kesehatan, sosial, maupun ekonomi. Peningkatan angka harapan hidup menuntut adanya perhatian serius terhadap kualitas hidup lansia, bukan hanya sekadar perpanjangan usia. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep lansia dan teori

menua menjadi hal yang sangat penting, terutama bagi tenaga kesehatan, pendidik, maupun masyarakat luas.

Berbagai teori menua telah dikembangkan untuk menjelaskan mekanisme penuaan, baik dari sudut pandang biologis, psikologis, maupun sosial. Teori-teori ini membantu memberikan kerangka berpikir dalam memahami perubahan yang dialami lansia serta strategi yang dapat diterapkan untuk mendukung mereka agar tetap sehat, produktif, dan bermakna dalam kehidupannya. Dalam hal ini, perawat gerontik memiliki peran yang sangat strategis. Sebagai tenaga kesehatan yang berada paling dekat dengan lansia, perawat gerontik harus mengutamakan promotive dan preventif, selain kuratif. Perawat gerontik berperan dalam mendampingi lansia agar tetap mampu menjalani hidup dengan sehat, mandiri, dan bermakna. Selain itu, perawat juga menjadi fasilitator bagi keluarga dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang ramah lansia.

Buku ajar ini disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai konsep lansia dan teori menua, sehingga diharapkan dapat menjadi dasar pengetahuan bagi mahasiswa, tenaga kesehatan, serta pihak-pihak yang peduli terhadap peningkatan kesejahteraan lansia. Dengan memahami proses penuaan secara komprehensif, diharapkan lahir upaya-upaya yang lebih manusiawi dan holistik dalam menghadapi berbagai tantangan yang terkait dengan populasi lanjut usia.

Gambaran pembahasan bab ini adalah pengertian lansia, klasifikasi lansia, teori penuaan, tugas perkembangan lansia, faktor yang mempengaruhi penuaan, perubahan bio-psiko-sosio-spiritual pada lanjut usia, dan permasalahan yang sering terjadi pada lanjut usia.

Uraian Materi

Pembahasan pada bab ini meliputi pengertian lansia, klasifikasi lansia, teori penuaan, tugas perkembangan lansia, faktor yang mempengaruhi penuaan, perubahan bio-spiko-sosio-spiritual pada lanjut usia, dan permasalahan yang sering terjadi pada lanjut usia dan latihan soal tentang konsep lansia dan teori penuaan pada lansia.

A. Definisi Lanjut Usia

Menurut *World Health Organization* (WHO), lanjut usia (lansia) adalah kelompok populasi yang telah mencapai usia 60 tahun atau lebih. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, yang mendefinisikan lansia sebagai individu, baik laki-laki maupun perempuan, yang berusia 60 tahun ke atas, terlepas dari kemampuan mereka untuk bekerja atau melakukan aktivitas sehari-hari. Adapun menurut Kemenkes (Kementerian Kesehatan) lansia sebagai tahap terakhir perkembangan pada proses kehidupan manusia mulai berkembang dari bayi, anak-anak, dewasa, dan akhirnya menjadi tua. Penuaan merupakan proses alami yang harus dilalui setiap individu, di mana kemampuan jaringan tubuh untuk memperbaiki dan mempertahankan fungsi normalnya secara bertahap menurun (Manafe & Berhimpon, 2022).

B. Klasifikasi Lanjut Usia

Lanjut usia ditandai dengan usia di atas 60 tahun, dengan beberapa klasifikasi batasan lansia sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi "Lanjut usia adalah seseorang yang mencapai 60 tahun ke atas".
2. Menurut *World Health Organization* (WHO), usia lanjut dikategorikan ke dalam empat kelompok, dengan definisi lansia dimulai dari usia 60 tahun ke atas (WHO, 2022):
 - a. Lanjut usia (elderly): 60-74 tahun.
 - b. Lanjut usia tua (old): 75-90 tahun.
 - c. Usia sangat tua (very old): lebih dari 90 tahun.
3. Berdasarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2015), lansia dikelompokkan menjadi:
 - a. Usia lanjut (60-69 tahun): memiliki risiko kesehatan tinggi.
 - b. Usia lanjut lebih dari 70 tahun: sering menghadapi berbagai masalah kesehatan.

4. Menurut Prof. Dr. Koesmanto Setyonegoro dalam Yuswatiningsih & Suhariat (2021), masa lanjut usia (geriatric age) dimulai dari usia di atas 65 atau 70 tahun, dengan pembagian sebagai berikut:
 - a. Young old: 70-75 tahun.
 - b. Old: 75-80 tahun.
 - c. Very old: lebih dari 80 tahun.
5. Lanjut usia dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori berdasarkan klasifikasi dari Depkes RI, yang mencakup lima golongan berikut (Gemini, et al., 2021) dan Astuti, et al (2023)
 - a. Pralansia (Prasenilis): Individu yang berada pada rentang usia 49-59 tahun.
 - b. Lansia: Orang yang telah mencapai usia 60 tahun atau lebih.
 - c. Lansia risiko tinggi: Lansia berusia 70 tahun ke atas, atau lansia berusia 60 tahun yang menghadapi banyak masalah kesehatan.
 - d. Lansia potensial: Lansia yang masih mampu bekerja atau melakukan aktivitas yang menghasilkan pendapatan atau jasa.
 - e. Lansia tidak potensial: Lansia yang tidak mampu mencari nafkah, sehingga kehidupannya bergantung sepenuhnya pada orang lain.

C. Teori Penuaan

Menurut Astuti dkk. (2023), terdapat berbagai teori yang menjelaskan proses penuaan, antara lain:

1. Teori Biologis, yang mencakup:

- a. Teori jam genetik (genetic clock theory), menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki "jam biologis" yang mengatur siklus kehidupannya. Saat jam ini berhenti, maka individu akan meninggal secara alami. Meski begitu, proses tersebut dapat ditunda sementara melalui gaya hidup sehat, pencegahan penyakit, serta tindakan medis.
- b. Teori mutasi somatik, menyebutkan bahwa penuaan disebabkan oleh akumulasi kesalahan dalam transkripsi dan translasi enzim dalam waktu lama. Kesalahan ini mengakibatkan penurunan fungsi metabolisme, pembentukan RNA, dan kemampuan perbaikan sel, sehingga memicu proses menua.
- c. Teori imunologi/autoimun, menyatakan bahwa tubuh menghasilkan zat yang justru merugikan dirinya sendiri, membuat daya tahan tubuh melemah dan lebih mudah sakit.
- d. Teori radikal bebas, berpendapat bahwa radikal bebas yang tidak stabil dapat merusak sel tubuh hingga menghambat regenerasinya.

- e. Teori keausan (wear and tear theory), menggambarkan bahwa tubuh yang terus digunakan dalam jangka panjang akan mengalami kerusakan akibat kelelahan organ.
- f. Teori stres, menjelaskan bahwa penuaan terjadi akibat hilangnya sel-sel yang secara normal dibutuhkan tubuh.
- g. Teori ikatan silang (cross-link theory), mengemukakan bahwa reaksi kimia pada sel-sel tua membentuk ikatan yang kuat, menyebabkan jaringan menjadi kaku dan kurang elastis sehingga menimbulkan tanda-tanda penuaan.

2. Teori Sosial-Psikologis, yang meliputi:

- a. Teori aktivitas (activity theory), menekankan pentingnya lansia untuk tetap aktif agar memperoleh kepuasan hidup. Lansia yang dianggap berhasil adalah mereka yang terlibat dalam berbagai kegiatan sosial.
- b. Teori kontinuitas (continuity theory), menyatakan bahwa pengalaman menua dipengaruhi oleh pola kepribadian yang sudah terbentuk sebelumnya.
- c. Teori pelepasan (disengagement theory), berasumsi bahwa semakin bertambah usia, seseorang cenderung menarik diri dari kehidupan sosial. Hal ini berdampak pada menurunnya frekuensi dan kualitas interaksi sosial, berkurangnya peran, serta menipisnya komitmen dalam masyarakat.

3. Teori Psikologis

Menekankan pentingnya pemahaman individu terhadap tahapan perkembangan hidupnya. Pada masa dewasa tua, tugas perkembangan meliputi penerimaan atas penurunan kondisi fisik dan kesehatan, menghadapi masa pensiun dengan segala konsekuensi ekonominya, mengelola kehilangan akibat kematian orang-orang terdekat, menjaga hubungan sosial, beradaptasi dengan peran baru, serta tetap berusaha mempertahankan kualitas hidup yang memuaskan.

D. Tugas Perkembangan Lanjut Usia

Apabila seseorang pada masa pertumbuhan sebelumnya menjalani rutinitas sehari-hari dengan baik dan menjaga hubungan yang harmonis dengan orang di sekitarnya, maka ketika sudah lanjut usia, ia akan tetap melanjutkan kegiatan yang biasa dilakukannya seperti berolahraga, mengekspresikan hobi berkebun, dan lain-lain (Afrizal, 2018).

Menurut Afrizal (2018), ketika seseorang memasuki usia lansia, mereka memiliki 7 tugas perkembangan yang harus dijalani, yaitu:

1. Menyesuaikan diri dengan penurunan kekuatan fisik dan kesehatan secara bertahap.
2. Menyesuaikan diri dengan berkurangnya pendapatan.

3. Menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup.
4. Menjadi anggota kelompok sebaya dan mengikuti pertemuan sosial.
5. Mengembangkan kegiatan untuk mengisi waktu luang yang semakin banyak.
6. Menyesuaikan diri dengan peran sosial secara fleksibel.
7. Kesiapan menghadapi kematian.

E. Faktor yang Mempengaruhi Penuaan

Penuaan bisa terjadi baik secara fisiologis maupun patologis. Penuaan yang mengikuti perkembangan usia kronologis dipengaruhi oleh berbagai faktor. Beberapa faktor yang mempengaruhi proses penuaan antara lain (Muhith & Siyoto, 2016):

1. Hereditas (Genetik)

Kematian sel merupakan bagian dari seluruh siklus kehidupan yang berhubungan dengan peran penting DNA dalam mengendalikan fungsi sel. Secara genetik, perempuan memiliki sepasang kromosom X, sementara laki-laki hanya memiliki satu kromosom X. Kromosom X ini membawa unsur-unsur kehidupan yang menjadi alasan mengapa perempuan cenderung memiliki harapan hidup yang lebih panjang dibandingkan laki-laki.

2. Nutrisi/Makanan

Kelebihan atau kekurangan nutrisi dapat mengganggu keseimbangan sistem kekebalan tubuh. Seiring bertambahnya usia, kebutuhan tubuh akan karbohidrat dan lemak cenderung menurun, sementara kebutuhan akan protein, vitamin, dan mineral justru meningkat. Persentase asupan energi yang disarankan untuk lansia adalah sekitar 55-60% karbohidrat, 20-25% protein, dan 20-25% lemak (Zelvy, 2014).

3. Pengalaman Hidup

- a. Paparan sinar matahari: Kulit yang tidak terlindungi dari sinar matahari rentan mengalami flek, kerutan, dan penurunan kecerahan.
- b. Kurangnya olahraga: Olahraga berperan penting dalam pembentukan otot dan meningkatkan kelancaran sirkulasi darah.
- c. Konsumsi alkohol: Alkohol dapat menyebabkan pembesaran pembuluh darah kecil di kulit, yang meningkatkan aliran darah di dekat permukaan kulit.

4. Lingkungan

Penuaan secara biologis merupakan proses alami yang tidak dapat dihindari, namun usia lanjut dapat dipertahankan jika kesehatan terjaga dan lingkungan mendukung. Sebaliknya, lingkungan yang tidak stabil, seperti pencahayaan yang buruk atau terlalu terang, kebisingan, suhu ruangan yang

ekstrem, serta kondisi seperti depresi dan ketakutan, dapat menyebabkan ketidaknyamanan pada lansia dan berisiko mengganggu kesejahteraan mereka.

5. Stress

Penuaan dapat dipengaruhi oleh tekanan hidup sehari-hari, baik yang berasal dari pekerjaan, lingkungan rumah, maupun masyarakat, yang kemudian tercermin dalam gaya hidup lansia.

F. Perubahan-Perubahan yang Terjadi pada Lanjut Usia

Perubahan pada lanjut usia adalah proses fisiologis yang pasti terjadi, berlangsung secara berkesinambungan, dan menyebabkan penurunan fungsi fisik, mental, psikososial, serta spiritual. Proses ini juga berdampak pada berbagai aspek kemunduran. Beberapa perubahan yang dialami oleh lansia meliputi (Gemini, et al., 2021):

1. Perubahan Fisik

Secara umum, proses penuaan ditandai dengan perubahan biologis yang terlihat dari kemunduran fisik. Perubahan ini meliputi kulit yang mulai mengendur, wajah berkeriput dengan garis-garis kerutan yang menetap, rambut berubah menjadi putih atau beruban, gigi mulai tanggal, fungsi Indera menurun, tubuh mudah lelah dan rentan jatuh, nafsu makan berkurang, pergerakan melambat, dan pola tidur yang berubah.

Pada lansia, sistem muskuloskeletal juga mengalami perubahan signifikan, termasuk pada jaringan penghubung seperti kolagen dan elastin. Kemampuan kartilago untuk bergerak menurun, kepadatan tulang berkurang, struktur otot berubah, elastisitas sendi menurun, dan kartilago yang menipis mengurangi fungsinya sebagai bantalan antara tulang dan sendi. Gesekan yang terus menerus pada ujung tulang dapat menyebabkan inflamasi sendi yang menimbulkan rasa nyeri (Zalila, et al., 2022).

2. Perubahan Mental

Pada lansia, perubahan mental sering ditandai dengan sikap yang lebih egosentris, mudah merasa curiga, serta kecenderungan menjadi lebih pelit atau serakah. Secara umum, sebagian besar lansia memiliki keinginan untuk hidup lebih lama, menjaga energi mereka, dan tetap memiliki peran di tengah masyarakat. Selain itu, mereka cenderung ingin mempertahankan hak serta harta benda mereka, berharap meninggal dengan terhormat, dan memiliki keyakinan untuk masuk surga.

3. Perubahan Psikososial

Perubahan psikososial pada lansia sering kali dikaitkan dengan tingkat produktivitas mereka, terutama dalam peran pekerjaan. Saat memasuki masa pensiun, lansia dapat mengalami berbagai bentuk kehilangan, seperti penurunan pendapatan, kehilangan status sosial, berkurangnya lingkaran pertemanan, serta hilangnya rutinitas bekerja. Selain itu, mereka juga mulai menyadari keterbatasan fisik dan kemungkinan kematian. Faktor-faktor seperti kesulitan ekonomi, penyakit, rasa kesepian, gangguan nutrisi, serta penurunan kekuatan dan postur tubuh turut memperburuk kondisi psikososial lansia.

Perubahan psikososial pada lansia sering kali dikaitkan dengan tingkat produktivitas mereka, terutama dalam peran pekerjaan. Saat memasuki masa pensiun, lansia dapat mengalami berbagai bentuk kehilangan, seperti penurunan pendapatan, kehilangan status sosial, berkurangnya lingkaran pertemanan, serta hilangnya rutinitas pekerjaan. Selain itu, mereka juga mulai menyadari keterbatasan fisik dan kemungkinan kematian. Faktor-faktor seperti kesulitan ekonomi, penyakit, rasa kesepian, gangguan nutrisi, serta penurunan kekuatan dan postur tubuh turut memperburuk kondisi psikososial lansia.

4. Perubahan Spiritual

Pada tahap lanjut usia, individu cenderung mencapai kematangan yang lebih tinggi dalam kehidupan keagamaan mereka. Hal ini tercermin dalam pola pikir dan tindakan sehari-hari. Pada usia 70 tahun ke atas, perkembangan yang dicapai biasanya ditunjukkan melalui cara berpikir dan bertindak yang mengedepankan keteladanan dalam mencintai sesama dan menegakkan keadilan.

G. Masalah yang Sering Muncul pada Lanjut Usia

Menurut Aniyati & Kamalah (2018), terdapat berbagai penurunan kemampuan tubuh pada lansia.

1. Lansia mulai mengalami penurunan pendengaran, sehingga untuk berinteraksi dengan lansia diperlukan suara yang lebih keras.
2. Fungsi penglihatan, yang mana lansia perlu berhati-hati saat berjalan agar tidak jatuh.
3. Fungsi kognitif, mereka membutuhkan waktu lebih lama untuk mengingat suatu kejadian, yang sangat memengaruhi kehidupan psikososial mereka.
4. Masalah psikososial, mereka kehilangan pasangan atau orang terdekat, berurusan dengan penegak hukum, dan trauma psikis dapat menyebabkan lansia merasa bingung, panik, bahkan apatis. Ketika lansia pensiun, mereka mungkin merasa tidak mampu melakukan aktivitas yang biasa mereka lakukan bisa

menjadi sumber stres dan beban pikiran bagi mereka, sehingga memungkinkan lansia akan depresi yang diakibatkan oleh stres dan beban pikiran berlebih. Namun, sumber tersebut juga bisa dapat mengganggu interaksi sosial atau aktivitas sosial mereka.

Masalah lain yang muncul adalah lingkungan tempat tinggal lansia, mereka membutuhkan lingkungan yang aman dan nyaman untuk mencegah cedera dan mengurangi stres psikologis. Masalah di sekitar mereka dapat memengaruhi kualitas hidup mereka secara signifikan (Aniyati, 2018).

H. Latihan Soal

1. Menurut *World Health Organization* (WHO), seseorang digolongkan sebagai lanjut usia apabila berusia...
 - A. ≥ 45 tahun
 - B. ≥ 50 tahun
 - C. ≥ 55 tahun
 - D. ≥ 60 tahun
 - E. ≥ 65 tahun
2. Teori penuaan yang menjelaskan bahwa proses menua terjadi karena adanya penurunan kemampuan sistem imun tubuh disebut...
 - A. Teori Wear and Tear
 - B. Teori Genetik
 - C. Teori Imunologi
 - D. Teori Radikal Bebas
 - E. Teori Program Biologis
3. Masalah kesehatan yang sering dialami lansia akibat perubahan fisiologis adalah...
 - A. Diabetes melitus, hipertensi, dan osteoporosis
 - B. Campak, polio, dan cacar air
 - C. Tuberkulosis, malaria, dan demam berdarah
 - D. Thalassemia, hemofilia, dan leukemia
 - E. HIV/AIDS, sifilis, dan gonore
4. Perubahan biologis yang terjadi pada lansia antara lain...
 - A. Peningkatan fungsi organ tubuh
 - B. Penurunan elastisitas kulit dan berkurangnya massa otot
 - C. Peningkatan metabolisme basal

- D. Pertumbuhan rambut lebih cepat
 - E. Peningkatan kepadatan tulang
5. Perubahan psikososial yang sering dialami lansia adalah...
- A. Meningkatnya produktivitas kerja
 - B. Kehilangan pasangan hidup atau teman sebaya
 - C. Peran sosial dalam keluarga tetap sama
 - D. Meningkatnya kekuatan fisik
 - E. Tidak adanya perubahan spiritualitas

Kunci Jawaban

1. Kunci Jawaban D ≥ 60 tahun
Pembahasan: Menurut *World Health Organization* (WHO), usia lanjut dikategorikan ke dalam empat kelompok, dengan definisi lansia dimulai dari usia 60 tahun ke atas (WHO, 2022)
2. Kunci Jawaban C Teori imunologi
Pembahasan: Teori ini menyatakan bahwa tubuh akan menjadi lemah dan sakit atau mengalami penurunan imunitas.
3. Kunci Jawaban A Diabetes melitus, hipertensi, dan osteoporosis
Pembahasan: Seiring bertambahnya usia, tubuh mengalami penurunan fungsi organ atau permasalahan fisik/fisiologis dan risiko timbulnya berbagai penyakit degenerative meningkat. Penyakit degenerative seperti diabetes mellitus dan hipertensi.
4. Kunci Jawaban B Penurunan elastisitas kulit dan berkurangnya massa otot
Pembahasan: Penurunan elastisitas kulit dan berkurangnya massa otot merupakan salah satu contoh penurunan fungsi biologis/ fisik pada lansia.
5. Kunci Jawaban B Kehilangan pasangan hidup atau teman sebaya
Pembahasan: Masalah psikososial pada lansia yaitu mereka kehilangan pasangan atau orang terdekat.

I. Rangkuman Materi

Lanjut usia (lansia) merupakan tahap akhir dalam siklus kehidupan manusia yang ditandai dengan proses menua, yaitu suatu proses alami yang tidak dapat dihindari. Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, seseorang dikategorikan lansia apabila berusia 60 tahun ke atas. Menurut WHO, kelompok usia lansia terbagi menjadi elderly (60–74 tahun), old (75–90 tahun), dan very old (>90 tahun). Pada masa ini, individu mengalami berbagai perubahan yang meliputi aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual.

Proses penuaan telah lama menjadi perhatian para ahli dan dijelaskan melalui berbagai teori. Teori biologis, misalnya, menjelaskan bahwa penuaan dapat terjadi karena sel dan jaringan mengalami keausan, kerusakan akibat radikal bebas, pemrograman genetik, atau penurunan sistem imun. Sementara itu, teori psikososial menekankan pada interaksi lansia dengan lingkungannya, yang menyatakan bahwa lansia cenderung menarik diri dari peran sosial.

Seiring bertambahnya usia, lansia menghadapi berbagai masalah. Masalah fisik yang umum adalah penyakit degeneratif seperti hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung, osteoporosis, serta gangguan penglihatan dan pendengaran. Dari sisi psikologis, lansia rentan mengalami depresi, kecemasan, demensia, serta rasa kesepian. Secara sosial, mereka dapat kehilangan peran akibat pensiun, kehilangan pasangan hidup maupun teman sebaya, serta mengalami isolasi sosial. Dari segi ekonomi, lansia sering menghadapi berkurangnya pendapatan dengan meningkatnya kebutuhan biaya kesehatan. Di samping itu, muncul pula kebutuhan spiritual yang semakin besar, misalnya keinginan untuk mendekatkan diri pada Tuhan, mencari makna hidup, dan menyiapkan diri menghadapi akhir hayat.

Perubahan yang dialami lansia dapat dipahami melalui empat dimensi utama. Secara biologis, terjadi penurunan fungsi organ, elastisitas kulit berkurang, rambut memutih, massa otot dan tulang menurun, serta fungsi indra melemah. Secara psikologis, lansia kerap mengalami penurunan daya ingat, gangguan kognitif, perubahan suasana hati, hingga perasaan kesepian. Dari aspek sosial, lansia sering mengalami berkurangnya peran dalam masyarakat dan keluarga, serta keterbatasan dalam berinteraksi. Sementara itu, secara spiritual, banyak lansia yang lebih mendalami nilai-nilai keagamaan, meningkatkan ibadah, serta mencari ketenangan batin.

Dengan demikian, lansia adalah kelompok yang mengalami perubahan kompleks dalam aspek bio-psiko-sosio-spiritual. Pemahaman mengenai konsep lansia, teori penuaan, masalah yang muncul, serta perubahan yang dialami sangat penting untuk memberikan pelayanan kesehatan, dukungan sosial, dan pendampingan spiritual yang menyeluruh.

J. Glosarium

Populasi: kumpulan orang atau pribadi yang mempunyai ciri-ciri yang sama atau permasalahan yang sama

Sebaya: memiliki usia yang sama atau teman seperguruan

Fleksibel: luwes/ tidak kaku, mudah menyesuaikan diri atau mudah beradaptasi

Kronologis: urutan peristiwa atau kejadian disusun berdasarkan waktu terjadinya, dari awal hingga akhir

Inflamasi: reaksi tubuh terhadap mikroorganisme dan benda asing yang ditandai oleh panas, bengkak, nyeri, dan gangguan fungsi organ tubuh

Egosentris: menjadikan diri sendiri sebagai pusat pemikiran, berpusat pada diri sendiri

Produktivitas: kemampuan untuk menghasilkan sesuatu

K. Daftar Pustaka

Afrizal, A. (2018). Permasalahan yang dialami lansia dalam menyesuaikan diri terhadap penguasaan tugas-tugas perkembangannya. *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 2(2), 91-106.

Aniyati, S., Kamalah, A.D. (2018). Gambaran kualitas hidup lansia di wilayah kerja Puskesmas Bojong I Kabupaten Pekalongan. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Keperawatan*, 14(1).

Astuti, R., Umboh, M. J., Pradana, A. A., Silaswati, S., Susanti, F., Resna, R. W., Sukmawati, A. S., Maryam, R. S., Tinungki, Y. L., Riasmini, N. M., and others. (2023). *Keperawatan Gerontik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=-fXDEAAAQBAJ>

Gemini, S. et al., (2021). *Keperawatan Gerontik*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.

Kementerian Kesehatan RI. (2015). Klasifikasi lansia.

Manafe, L. A. & Berhimpon, I., (2022). Hubungan tingkat depresi lansia dengan interaksi sosial lansia di BSLUT Senja Cera Manado. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 11(1), pp. 749-758.

Muhith, A. & Siyoto, S., (2016). *Pendidikan Keperawatan Gerontik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

WHO. (2022). *Ageing and Health*. World Health Organization.

- Yuswatiningsih, E. & Suhariat, H. I., (2021). Hubungan tingkat pendidikan dengan kemandirian lansia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. *Hospital Majapahit*, 13(1), pp. 61-70.
- Zalila et al. (2022). *Penyakit Pada Sistem Muskuloskeletal*. Universitas Bina Sehat PPNI.
- Zelvya, P., (2014). Hubungan status gizi terhadap kebugaran lansia di paguyuban senam karang weda jambangan surabaya. *Jurnal Kesehatan Olahraga*, 2(2), pp. 50-57.

BAB 2

KONSEP KEPERAWATAN GERONTIK

Tujuan Instruksional:

- Setelah Proses pembelajaran peserta didik mampu memahami konsep keperawatan gerontik

Capaian Pembelajaran:

- Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian keperawatan gerontik.
- Mahasiswa mampu menjelaskan fokus keperawatan gerontik
- Mahasiswa mampu menjelaskan tujuan keperawatan gerontik
- Mahasiswa mampu menjelaskan peran perawat gerontik
- Mahasiswa mampu menjelaskan fungsi perawat gerontik
- Mahasiswa mampu menjelaskan sifat layanan gerontik
- Mahasiswa mampu menjelaskan sifat layanan dan sarana keperawatan gerontik

Pendahuluan

Pertambahan jumlah penduduk lanjut usia merupakan fenomena demografis global yang menuntut transformasi layanan kesehatan. Dalam konteks tersebut, keperawatan gerontik hadir sebagai ranah ilmu dan praktik keperawatan yang berfokus pada kebutuhan unik individu lanjut usia (lansia) secara holistik—bio-psiko-sosial-spiritual dengan tujuan utama mempertahankan kemampuan fungsional, memajukan kualitas hidup, serta mendukung proses penuaan yang sehat dan bermakna.

Berbeda dari keperawatan geriatri yang banyak berfokus pada penanganan klinis penyakit pada usia lanjut, keperawatan gerontik menekankan pendekatan promotif–preventif sekaligus kuratif–rehabilitatif dalam berbagai tatanan layanan (komunitas, keluarga, panti, hingga rumah sakit). Praktiknya berlandaskan nilai martabat, otonomi, keamanan, keadilan, dan kemitraan, serta berorientasi pada person- and family-centered care yang sensitif budaya.

Untuk merancang asuhan yang efektif, perawat perlu memahami teori perkembangan dan penuaan, dinamika sindrom geriatri (misalnya jatuh, gangguan kognitif, depresi, inkontinensia, malnutrisi, ulkus tekan), serta isu kompleks seperti frailty, multimorbiditas, dan polifarmasi. Penilaian gerontik komprehensif—mencakup status fungsional (ADL/IADL), kognitif, nutrisi, nyeri, mood, risiko lingkungan, serta dukungan sosial menjadi fondasi penetapan diagnosis keperawatan, perencanaan intervensi, dan evaluasi berkelanjutan.

Selain kompetensi klinis, keperawatan gerontik menuntut keterampilan komunikasi terapeutik, edukasi kesehatan, manajemen transisi perawatan, dan kolaborasi interprofesional. Perawat juga berperan sebagai advokat lansia dalam isu etika dan hukum, termasuk informed consent, pencegahan kekerasan dan penelantaran, perencanaan perawatan lanjutan, serta perawatan paliatif yang berbelas kasih.

Bab ini memberikan landasan konseptual keperawatan gerontik yang akan mengulas definisi dan ruang lingkup, prinsip-prinsip etik dan profesional, kerangka penilaian gerontik komprehensif, perencanaan dan implementasi intervensi pada sindrom geriatri umum, hingga strategi promosi kesehatan, keselamatan, dan kualitas hidup lansia di berbagai tatanan pelayanan. Dengan pemahaman tersebut, mahasiswa keperawatan diharapkan mampu merancang asuhan yang aman, efektif, dan berpusat pada lansia serta keluarganya.

Konsep Keperawatan Gerontik

A. Pengertian Keperawatan Gerontik

Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan bersifat komprehensif terdiri dari bio, psiko, sosial dan spiritual ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat baik sehat maupun sakit berdasarkan ilmu dan kiat. Lansia baik sebagai individu maupun kelompok merupakan sasaran dari pelayanan keperawatan. Pelayanan keperawatan dilaksanakan dengan pemberian asuhan keperawatan. Pengertian asuhan keperawatan adalah rangkaian interaksi perawat dengan klien dan lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan dan kemandirian dalam merawat dirinya.

Keperawatan gerontik adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang didasarkan pada ilmu dan kiat/teknik keperawatan yang bersifat komprehensif terdiri dari bio-psikososio-spiritual dan kultural yang holistik, ditujukan pada klien lanjut usia, baik sehat maupun sakit pada tingkat individu, keluarga, kelompok dan masyarakat (UU RI No.38 tahun 2014).

Keperawatan Gerontik adalah suatu pelayanan profesional yang berdasarkan ilmu dan kiat/teknik keperawatan yang berbentuk bio-psikososial-spiritual dan kultural yang holistik yang di tujukan pada klien lanjut usia baik sehat maupun sakit pada tingkat individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat (Sarida & Hamonangan, 2020)

Pengertian lain dari keperawatan gerontik adalah praktek keperawatan yang berkaitan dengan penyakit pada proses menua (Kozier, 1987). Sedangkan menurut Lueckerotte (2000), keperawatan gerontik adalah ilmu yang mempelajari tentang perawatan pada lansia yang berfokus pada pengkajian kesehatan dan status fungsional, perencanaan, implementasi serta evaluasi. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa keperawatan gerontik adalah suatu bentuk praktek keperawatan profesional yang ditujukan pada lansia baik sehat maupun sakit yang bersifat komprehensif terdiri dari bio-psiko-sosial dan spiritual dengan pendekatan proses keperawatan terdiri dari pengkajian, diagnosis keperawatan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

B. Fokus Keperawatan Gerontik

Fokus keperawatan gerontik ada 3 yaitu

1. Peningkatan kesehatan (health promotion)

Upaya yang dilakukan adalah memelihara kesehatan dan mengoptimalkan kondisi lansia dengan menjaga perilaku yang sehat. Contohnya adalah memberikan pendidikan kesehatan tentang gizi seimbang pada lansia, perilaku hidup bersih dan sehat serta manfaat olah raga.

2. Pencegahan penyakit (preventif)

Upaya untuk mencegah terjadinya penyakit karena proses penuaan dengan melakukan pemeriksaan secara berkala untuk mendeteksi sedini mungkin terjadinya penyakit, contohnya adalah pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol secara berkala, menjaga pola makan, contohnya makan 3 kali sehari dengan jarak 6 jam, jumlah porsi makanan tidak terlalu banyak mengandung karbohidrat (nasi, jagung, ubi) dan mengatur aktifitas dan istirahat, misalnya tidur selama 6-8 jam/24 jam

3. Mengoptimalkan fungsi mental.

Upaya yang dilakukan dengan bimbingan rohani, diberikan ceramah agama, sholat berjamaah, senam GLO (Gerak Latih Otak) (GLO) dan melakukan terapi aktivitas kelompok, misalnya mendengarkan musik bersama lansia lain dan menebak judul lagunya.

4. Mengatasi gangguan kesehatan yang umum.

Melakukan upaya kerjasama dengan tim medis untuk pengobatan pada penyakit yang diderita lansia, terutama lansia yang memiliki resiko tinggi terhadap penyakit, misalnya pada saat kegiatan Posyandu Lansia.

Fokus asuhan keperawatan gerontik menurut

1. Holistik dan Empatik: Memperhatikan aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual lansia
2. Legal dan Etik: Menjunjung hak lansia dan prinsip etik dalam pengambilan keputusan
3. Model Asuhan Gerontik: Menggunakan pendekatan siklus hidup dan teori menua sebagai dasar intervensi
4. Pencegahan dan Promosi Kesehatan: Edukasi tentang gaya hidup sehat, deteksi dini penyakit, dan pencegahan komplikasi

C. Tujuan Keperawatan Gerontik

Tujuan keperawatan gerontik secara umum, ada lima tujuan keperawatan gerontik yaitu :

1. Lanjut usia dapat melakukan kegiatan sehari–hari secara mandiri dan produktif.
2. Mempertahankan kesehatan serta kemampuan lansia seoptimal mungkin.
3. Membantu mempertahankan dan meningkatkan semangat hidup lansia (Life Support).
4. Menolong dan merawat klien lanjut usia yang menderita penyakit (kronis atau akut).
5. Memelihara kemandirian lansia yang sakit seoptimal mungkin.

Tujuan keperawatan gerontik dapat juga diuraikan dengan lengkap seperti tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Secara umum tujuan keperawatan gerontik adalah mencapai kualitas hidup dan kesejahteraan yang optimal sehingga lansia dapat berdayaguna bagi keluarga dan masyarakat.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari keperawatan gerontik adalah:

a. Mempertahankan kesehatan fisik

Tujuan ini mencakup upaya untuk mencegah penyakit, mengelola kondisi kronis, dan mempromosikan kondisi umum yang menunjang kesehatan sehingga lansia tetap aktif, menjaga mobilitas, dan mengurangi risiko komplikasi medis.

b. Meningkatkan kesejahteraan psikologis

Kesejahteraan psikologis menggambarkan kesehatan mental lansia, dan tujuan ini dapat dilakukan dengan cara perawat memberikan dukungan emosional, mengatasi perasaan kesepian atau isolasi serta membantu lansia dalam mengatasi dan mengendalikan stres, termasuk belajar memahami perubahan emosional yang mungkin terjadi dan bagaimana penyelesaiannya.

c. Memfasilitasi kemandirian.

Tujuan ini dilakukan dengan memberikan bantuan dan dukungan sesuai kebutuhan tanpa menghilangkan kemampuan lansia untuk melakukan aktivitas sehari–hari secara mandiri. Perawat berusaha untuk meningkatkan kemandirian lansia sebanyak mungkin sehingga lansia tidak mengalami ketergantungan dengan orang lain.

d. Meningkatkan kualitas hidup.

Tujuan ini dilakukan dengan memberikan perawatan yang nyaman, aman sesuai dengan preferensi lansia dalam rangka memenuhi kebutuhan fisik,

sosial, dan psikologis. Peningkatan kualitas hidup lansia dapat dicapai dengan menerapkan tujuh dimensi lansia tangguh, yang diharapkan dapat mencegah kerentanan lansia yang ditimbulkan oleh berbagai perubahan yang dialami, meliputi: dimensi spiritual, intelektual, fisik, emosional, sosial kemasyarakatan, profesional vokasional, dan dimensi lingkungan.

- e. Mengoptimalkan dukungan sosial. lingkungan (Ekasari, 2019). Perawat membantu lansia dalam menjaga dan memperluas jaringan dukungan sosial, sehingga dengan interaksi sosial tersebut lansia terfasilitasi dan terhindar dari isolasi sosial.

- f. Edukasi dan pemberdayaan.

Tujuan ini dilakukan dengan memberikan edukasi kepada lansia dan keluarga tentang kondisi kesehatan, manajemen obat, dan cara menjalani gaya hidup sehat. Tujuan edukasi adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman lansia dan keluarga, sehingga dengan pengetahuan dan pemahaman tersebut, lansia dan keluarga mampu mengambil keputusan yang tepat tentang perawatan dan kesehatannya.

- g. Paliatif dan perawatan akhir hidup.

Tujuan ini terutama diberikan pada lansia yang terdiagnosa suatu penyakit yang secara medis tidak mungkin dapat disembuhkan, dan dengan sakitnya tersebut lansia mengalami berbagai keterbatasan, sehingga bentuk perawatan yang diberikan seumur hidup, tujuannya untuk memberikan perawatan akhir hidup yang nyaman dan bermartabat, yang dilakukan dengan membantu meredakan nyeri, memberikan dukungan psikologis, dan membantu lansia dan keluarga dalam menghadapi kematian dengan damai dan bermartabat.

- h. Promosi dukungan spiritual. Keperawatan gerontik meyakini aspek spiritual dalam kehidupan lansia. Biasanya aktivitas keagamaan lebih banyak dilakukan pada masa tua, sebagian besar mereka meyakini bahwa akhir sebuah kehidupan adalah kematian, sehingga sebelum datang kematian itu perlu dibekali dengan ibadah sebagai amalan yang akan dipertanggungjawabkan nanti dihadapan sang pencipta. Oleh karena itu perawat dapat memberikan motivasi, dukungan, dan kesempatan pada lansia dalam memenuhi kebutuhan spiritual dan religius sesuai dengan kepercayaan dan nilai – nilai yang diyakini lansia.

- i. Kolaborasi dengan tim kesehatan.

Kompleksnya permasalahan yang dikeluhkan lansia mengisyaratkan bahwa dalam penanganan dan perawatan lansia, perawat perlu melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan profesional kesehatan lain, seperti; dokter, fisioterapis,

ahli gizi, pekerja sosial dll, sehingga lansia mendapatkan pelayanan kesehatan yang terintegrasi dan holistik.

j. Menghormati kehendak lansia.

Meskipun lansia dipandang sebagai seseorang yang mengalami ketidakberdayaan, namun perawat tetap menghormati hak lansia dalam mengambil keputusan mengenai perawatan mereka sendiri dan menghargai keinginan lansia terhadap kualitas hidup dan akhir hidup. Namun demikian perawat perlu memberikan penjelasan secara mendalam agar keputusan apapun yang diambil oleh lansia adalah keputusan yang didasarkan pada pengetahuan

D. Peran Perawat Gerontik

Perawat gerontik dapat menjadi solusi efektif untuk memenuhi kebutuhan dan kenyamanan lansia dalam mempertahankan serta mencapai kualitas hidup dan kesejahteraan yang optimal. Oleh karena itu sebagai perawat yang profesional, perawat gerontik harus dapat menjalankan berbagai peran dan fungsi selama melaksanakan tugasnya, Adapun peran perawat gerontik adalah sebagai berikut:

1. Praktisi Klinis (Pelaksana)

Sebagai praktisi klinis artinya perawat menjalankan tugas sebagai pemberi asuhan keperawatan (UU No 28 Tahun 2014). Perawat gerontik menunjukkan keahlian klinis dalam melakukan perawatan yang diberikan kepada lansia, keahlian ini mencakup kemampuan pengkajian data yang bersumber dari pasien, keluarga, dan lingkungan dimana lansia tinggal, penilaian dan identifikasi masalah yang mungkin muncul berdasarkan data pengkajian, selanjutnya dibuatlah perencanaan. Perencanaan adalah Kunci dari continuity of care, perawat perlu mempersiapkan perencanaan berbasis masalah, oleh karena itu perawat wajib memiliki pengetahuan yang baik sebagai dasar menentukan intervensi yang tepat (Surbakti, 2020).

Tahap selanjutnya melakukan implementasi dan evaluasi, evaluasi dilakukan untuk menilai sejauhmana tindakan yang dilakukan memberikan dampak dalam mengatasi masalah. Yang tidak kalah penting adalah perawat mampu berpartisipasi dalam rencana perawatan interdisipliner

2. Pendidik

Peran ini sejalan dengan upaya promotive, dimana perawat gerontik bertugas mempromosikan berbagai informasi dan aktivitas yang mendukung peningkatan kesehatan. Pendidikan ini dapat dilakukan dengan sasaran individu, keluarga, kelompok atau Masyarakat secara umum, dan dilakukan dengan pendekatan berbagai metode dan media sesuai kebutuhan lansia. Beberapa

informasi yang dapat diberikan kepada lansia diantaranya adalah; isu-isu terkait penuaan seperti, penyakit yang lazim muncul dan pencegahannya, serta informasi lain yang relevan dengan kebutuhan lansia. Lebih lanjut Ginting (2020) dalam sebuah penelitian menjelaskan bahwa perawat harus berperan dalam membantu pasien untuk meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan melalui pendidikan kesehatan.

3. Advokasi

Perawat sebagai advokasi memiliki tugas untuk memastikan lansia telah mendapatkan hak-haknya. Perawat memastikan bahwa lansia mendapatkan perawatan yang sesuai, serta membantu klien dalam mengambil keputusan medis yang penting. Sebuah studi yang dilakukan di RS terkait dengan peran perawat sebagai advokasi, perawat dapat memberikan edukasi pada proses pemberian informed consent, sekaligus sebagai saksi, sebagai perantara dokter dengan keluarga (Kandar, 2015)

4. Konsultan

Sebagai konsultan, perawat gerontik mendukung apabila ada praktisi kesehatan lain yang menyediakan layanan geriatri. Konsultan tersebut diharapkan dapat memberikan petunjuk atau pedoman dalam mengembangkan program Kesehatan dan kesejahteraan seperti pencegahan dan perawatan suatu penyakit (misal; ulkus dekubitus (luka tekan), atau isu-isu klinis terkait penuaan seperti penyakit Alzheimer

5. Peneliti

Berkontribusi dalam pengembangan ilmu keperawatan gerontik melalui riset dan evaluasi praktik. Perawat gerontik bertugas melakukan berbagai penelitian untuk menghasilkan pengetahuan dan teori baru terkait asuhan keperawatan gerontik, dimana fenome penelitian dapat bersumber dari kasus – kasus yang ada di klinik atau komunitas. Selanjutnya mengomunikasikan hasil penelitian tersebut melalui presentasi pada program pendidikan berkelanjutan dan dengan menulis artikel untuk publikasi profesional, sehingga temuan temuan tersebut dapat dijadikan sebagai Evidence Base for Practice (EBP)

6. Konselor emosional

Memberikan dukungan psikososial untuk membantu lansia menghadapi perubahan emosional dan sosial.

7. Manajer Terapi

Mengelola pengobatan, terapi fisik, dan rehabilitasi sesuai kebutuhan lansia.

E. Fungsi Perawat Gerontik

1. Pengkajian holistik,

Melakukan penilaian menyeluruh terhadap kondisi fisik, mental, sosial, dan spiritual lansia.

2. Perencanaan Perawatan

Menyusun rencana keperawatan jangka pendek dan panjang sesuai kebutuhan individu lansia.

3. Pelaksanaan asuhan

Memberikan tindakan keperawatan seperti pemantauan vital sign, pemberian obat, dan terapi aktivitas.

4. Evaluasi Kesehatan

Menilai efektivitas intervensi dan menyesuaikan rencana perawatan secara berkala.

5. Pendidikan kesehatan

Mengedukasi lansia dan keluarga tentang gaya hidup sehat, pengelolaan penyakit, dan hak-hak pasien.

6. Pendampingan Psikososial

Memberikan dukungan emosional dan sosial untuk mengurangi isolasi dan meningkatkan kesejahteraan mental.

7. Koordinasi Lintas Profesi

Bekerja sama dengan dokter, fisioterapis, gizi, dan keluarga untuk memastikan perawatan terpadu.

8. Advokasi Lansia

Memastikan hak lansia terpenuhi, termasuk akses layanan, perlakuan adil, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Pendapat lain tentang fungsi perawat gerontik yaitu menurut Eliopoulus tahun 2005, fungsi perawat gerontik adalah:

1. *Guide persons of all age toward a healthy aging process* (membimbing orang di semua usia agar dapat menuju masa tua yang sehat). Artinya bahwa fungsi ini dilakukan oleh perawat dengan memberikan perawatan kepada seluruh orang, baik sebagai individu, keluarga, kelompok dan masyarakat, baik sehat maupun sakit pada semua kelompok usia sehingga dengan perawatan tersebut seseorang dapat mencapai Kesehatan dan kesejahteraan sampai di masa tuanya.
2. *Eliminate ageism* (menghilangkan perasaan takut tua), perawat tidak hanya membantu mengatasi masalah fisik saja, tetapi memastikan juga kenyamanan dan keamanan psikologis klien selama dalam perawatan, termasuk memberikan penjelasan tentang proses menua yang tidak dapat dihindari namun dapat

dimanajemen, sehingga dengan melakukan pendekatan secara holistic dan komprehensif klien dapat terhindar dari perasaan takut.

3. *Respect the tight of older adults and ensure other do the same* (menghormati hak orang yang lebih tua dan memastikan yang lain melakukan hal yang sama). Fungsi ini dapat dilakukan dengan memberikan prioritas kepada lansia selama proses pemberian perawatan, mengingat lansia dengan segala keterbatasan dan kemunduran fungsi sehingga diharapkan semua orangpun dapat memperlakukan hal yang sama. (misal mengutamakan lansia saat dalam antrian, atau memberikan kesempatan pada lansia untuk duduk ketika harus menunggu)
4. *Obverse and promote quality-of-service delivery* (mengawasi dan mendorong kualitas pelayanan). Saat ini masyarakat di dunia manapun mempunyai ekspektasi terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, kemajuan ilmu dan teknologi semakin membuat masyarakat melek akan hak-hak nya, dan hal ini dapat dilihat dari tingkat kepuasan yang dirasakan terhadap layanan yang diterima. Oleh karena itu sudah seharusnya perawat memberikan perawatan yang professional dan berkualitas selama 24 jam.
5. *Notice and reduce risks to health and wellbeing* (memperhatikan dan mengurangi resiko terhadap kesehatan dan kesejahteraan). Klien lansia yang telah mengalami berbagai kemunduran fungsi dan mengalami berbagai keluhan kesehatan akan lebih rentan terhadap stressor (baik secara fisik, psikis, sosial dll), sehingga perawat harus memberikan aktra perhatian dalam pemberian asuhan keperawatan. Sehingga upaya promotif dan preventif lebih ditekankan tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitative.
6. *Teach and support caregivers* (mendidik dan mendukung pemberi pelayanan kesehatan).
7. *Open channels for continued growth* (membuka kesempatan lanjut usia agar mampu berkembang sesuai kapasitasnya). Meskipun lansia dipandang sebagai seseorang yang mengalami keterbatasan, tetapi perawat masih dapat menggali potensi atau kemampuan yang dimiliki agar lansia dapat berkontribusi di lingkungan tempat tinggal sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Berbagai pengalaman hidup yang dimiliki sampai dengan usianya saat ini, tentu dapat memberikan inspirasi bagi orang lain, sehingga pengalaman pengalaman itulah yang nantinya diharapkan dapat ditularkan kepada orang-orang di sekitarnya.
8. *Listen and support* (mendengarkan semua keluhan dan memberi dukungan kepada lansia). Masa tua digambarkan dengan kesepian, tidak sedikit lansia yang hidup sendiri dan dihantu rasa kesepian sehingga nyaris tidak ada orang yang dapat diajak untuk berkeluh kesah. Perawat dapat berfungsi sebagai pendengar

sekaligus melakukan pengkajian, sehingga akan dengan mudah memberikan bimbingan dan arahan sesuai dengan masalah yang dirasakan.

9. *Offer optimism, encouragement, and hope* (memberikan semangat, dukungan, dan harapan kepada lansia).
10. *Generate, support, use, and participate in research* (menerapkan hasil penelitian, dan mengembangkan layanan keperawatan melalui kegiatan penelitian). Dunia keperawatan bersifat dinamis, selalu ada inovasi dalam pemberian proses asuhan keperawatan, dimana inovasi tersebut biasanya diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya, atau sebaliknya sebuah penelitian dilakukan berdasarkan permasalahan yang sedang dihadapi. Oleh karena itu saatnya perawat mempertimbangkan penggunaan bukti ilmiah (EBP) untuk mendukung pengambilan keputusan di pelayanan Kesehatan.
11. *Implement restorative and rehabilitative measures* (melakukan upaya pemeliharaan dan pemulihan kesehatan).
12. *Coordinate and managed care* (melakukan koordinasi dan manajemen keperawatan). Keberhasilan pelaksanaan asuhan keperawatan tidak mungkin terjadi hanya oleh profesi perawat, perlunya perawat melakukan kerja sama tim dalam bentuk kolaborasi dan koordinasi sesama profesi, dan ini adalah sebuah keharusan. Dengan membangun komunikasi, koordinasi maka akan menemukan sebuah konklusi untuk mencapai Kesehatan lansia.
13. *Asses, plan, implement, and evaluate care in an individualized, holistic maner* (melakukan pengkajian, merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi perawatan secara individual dan perawatan secara menyeluruh).
14. *Link services with needs* (memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan).
15. *Nurture future gerontological nurses for advancement of the speciality* (membangun masa depan perawat gerontik supaya menjadi spesialis dibidangnya). Dalam hal ini perawat perlu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang keperawatan gerontik dengan aktif dan upadate mengikuti berbagai kegiatan ilmiah (seminar, pelatihan, workshop, dan Pendidikan lanjut) sehingga issue issue terkini tentang keperawatan gerontik dapat dipahami.
16. *Understand the unique physical, emoticon, social, spiritual aspect of each other* (saling memahami pada aspek fisik, emosi, sosial, dan spiritual yang memiliki keunikan satu sama lain).
17. *Recognize and encourage the appropriate management of ethical concern* (mengenali dan mendukung manajemen yang sesuai dengan etika tempat bekerja).

18. *Support and comfort through the dying process* (memberikan dukungan dan kenyamanan pada saat menghadapi proses kematian). Kematian tidak ada hubungannya dengan usia, namun manusia dibatasi dengan usia, tidak semua orang siap dengan sebuah kematian, oleh karena itu saat lansia mengalami sebuah proses kematian, perawat sebaiknya dapat memberikan segenap perhatian, hadir dengan memberikan dukungan spiritual, sehingga lansia akan tetap merasakan kenyamanan, merasa ada yang menemani dan mengurangi ketakutan.
19. *Educate to promote selfcare and optimal independence* (mengajarkan untuk meningkatkan perawatan mandiri dan kemandirian yang optimal). bertambahnya usia berimplikasi lurus terhadap berkurangnya kemampuan tubuh untuk mengatasi dan memenuhi kebutuhan sendiri, sehingga lansia cenderung mengalami ketergantungan, dalam hal ini perawat harus mengajarkan kemandirian lansia seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuannya) misalnya mengajarkan mandi, berkemih, memakai baju, makan dll)

F. Sifat Pelayanan Gerontik

1. Holistik

Mencakup aspek bio-psiko-sosio-spiritual dan kultural, bukan hanya fisik.

2. Komprehensif

Menyeluruh, mencakup pengkajian, diagnosis, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

3. Individualistik

Disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, dan preferensi tiap lansia.

4. Humanistik

Mengutamakan empati, penghargaan terhadap martabat, dan nilai-nilai lansia.

5. Promotif dan Preventif

Fokus pada pencegahan penyakit dan peningkatan kualitas hidup, bukan hanya kuratif.

6. Terpadu

Melibatkan kolaborasi antar profesi dan keluarga dalam perawatan lansia.

7. Berorientasi kemandirian

Mendorong lansia untuk tetap aktif dan mandiri sesuai kemampuan.

8. Berbasis Hak Pasien

Menghormati hak lansia dalam pengambilan keputusan dan akses layanan kesehatan.

G. Sifat layanan dan sarana Keperawatan gerontik

Perawatan gerontik di Indonesia mencakup berbagai tatanan pelayanan kesehatan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan khusus lansia. Berikut adalah struktur dan pendekatan keperawatan gerontik di berbagai tatanan pelayanan :

1. Pelayanan Primer: mencakup Puskesmas dengan program Pelayanan Santun Lansia (PSL), Posyandu Lansia untuk deteksi dini dan edukasi kesehatan
2. Pelayanan Sekunder: Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dengan Poliklinik Geriatri, Asuhan keperawatan berbasis tim multidisiplin
3. Pelayanan Tertier: Rumah Sakit Rujukan Nasional dengan Unit Geriatri Terpadu , Fokus pada manajemen penyakit kronis dan rehabilitasi
4. Pelayanan Komunitas: Home care dan kunjungan ke rumah lansia, Program edukasi keluarga dan caregiver
5. Pelayanan sosial kesehatan: Panti Werdha dan Layanan Kesejahteraan, Kolaborasi antara tenaga kesehatan dan pekerja sosial

Secara garis besar ada 2 sarana pelayanan Keperawatan gerontik yaitu

1. Sarana Pelayanan Kesehatan (Klinik/Komunitas)

Adalah lansia yang mengalami gangguan baik fisik, mental atau keduanya (fisik & mental), sehingga dengan kondisi tersebut lansia memerlukan bantuan profesional (tenaga kesehatan atau yang lainnya). Pada tatanan ini berperan sebagai tenaga pelaksana adalah perawat dengan dukungan tenaga kesehatan/lainnya yang bisa bersumber dari keluarga.

Adapun beberapa bentuk intervensi yang dapat diberikan pada lansia yang berada di fasilitas kesehatan, yaitu:

- a. Bentuk pelayanan atau bantuan berupa pemberian perawatan secara langsung/teknis keperawatan, terapi medik (misal; fisioterapi, massase dll), konsultasi pribadi (misal berkaitan dengan kehilangan, berduka
- b. Asuhan keperawatan yang diberikan sesuai dengan tingkat ketergantungan lansia melalui pendekatan proses keperawatan (pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi) dan diikuti dengan melakukan catatan perkembangan keperawatan menggunakan metode SOAP.

2. Rumah

Lansia yang mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah adalah lansia yang mengalami keterbatasan fisik atau mental (atau keduanya) yang memerlukan perawatan di rumah. Dan keluargalah sebagai orang terdekat dengan lansia yang memberikan bantuan perawatan, tentunya dengan bimbingan dan pemantauan dari tenaga kesehatan. Beberapa tindakan yang dapat diberikan pada lansia pada tatanan ini adalah:

- a. Bentuk pelayanan atau bantuan berupa pemberian perawatan secara langsung/teknis keperawatan, terapi medik (misal; fisioterapi, massase dan lain-lain, konsultasi pribadi (misal berkaitan dengan kehilangan, berduka, koping yang tidak efektif dll), pemenuhan kebutuhan dasar manusia (nutrisi, istirahat tidur, ketidaknyamanan, beduka, risiko depresi dll).
- b. Asuhan keperawatan yang diberikan sesuai dengan tingkat ketergantungan lansia melalui pendekatan proses keperawatan (pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi) dan diikuti dengan melakukan catatan perkembangan keperawatan menggunakan metode SOAP.

Pelayanan kesehatan gerontik pada tatanan rumah, perlu adanya kerjasama antara tim kesehatan dengan keluarga, oleh karena itu tim/tenaga kesehatan harus memberikan bimbingan dan arahan terkait dengan pola/gaya hidup seperti apa yang harus diterapkan oleh lansia sesuai dengan permasalahan kesehatan yang dihadapi. Dalam hal ini tenaga kesehatan dipandang perlu menyiapkan beberapa program untuk mendukung keluarga dalam memberikan perawatan pada lansia di rumah (misal; konsultasi, edukasi, pelatihan care giver dll).

H. Latihan Soal

1. Pernyataan berikut ini adalah tujuan dari keperawatan gerontik :
 - A. Peningkatan kesehatan
 - B. Pencegahan penyakit
 - C. Mengoptimalkan fungsi mental.
 - D. Mengatasi gangguan kesehatan yang umum.
 - E. Memelihara kemandirian lansia
2. Menyarankan lansia untuk olah raga secara teratur termasuk fokus keperawatan gerontik:
 - A. Health Promotion
 - B. Prevention
 - C. Kuratif
 - D. Supportif
 - E. Edukatif
3. Menjaga pola makan lansia termasuk tindakan keperawatan yang berfokus pada :
 - A. Health Promotion
 - B. Prevention
 - C. Kuratif
 - D. Supportif

E. Educatif

4. Salah satu trend issue keperawatan gerontik di bawah ini mengarah kepada peningkatan pelayanan keperawatan, yaitu :
 - A. Pengontrolan biaya dalam pelayanan kesehatan
 - B. Perkembangan teknologi & informasi
 - C. Peningkatan penggunaan terapi alternatif (terapi modalitas & terapi komplementer)
 - D. Perubahan demografi
 - E. Community-based nursing care
5. Memberikan dukungan dan kenyamanan dalam menghadapi proses kematian adalah fungsi perawat gerontik :
 - A. Support and comfort through the dying process
 - B. Teach and support caregivers
 - C. Oversee and promote the quality of service delivery
 - D. Open channels for continued growth
6. Jelaskan pengertian keperawatan gerontik
7. Jelaskan fokus keperawatan gerontik
8. Jelaskan tujuan keperawatan gerontik secara umum
9. Jelaskan peran perawat gerontik sebagai advokasi dan konsultan
10. Jelaskan fungsi perawat gerontik

Kunci Jawaban

1. E
2. A
3. B
4. E
5. A

I. Rangkuman Materi

Definisi keperawatan gerontik adalah suatu bentuk praktek keperawatan profesional yang ditujukan pada lansia baik sehat maupun sakit yang bersifat komprehensif. Terdiri dari bio-psiko-sosial dan spiritual dengan pendekatan proses keperawatan (yang terdiri dari pengkajian, diagnosis keperawatan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi). Tujuan keperawatan gerontik secara umum, ada lima tujuan keperawatan gerontik yaitu:

1. Lanjut usia dapat melakukan kegiatan sehari-hari secara mandiri dan produktif.
2. Mempertahankan kesehatan serta kemampuan lansia seoptimal mungkin.

3. Membantu mempertahankan dan meningkatkan semangat hidup lansia (Life Support).
4. Menolong dan merawat klien lanjut usia yang menderita penyakit (kronis atau akut).
5. Memelihara kemandirian lansia yang sakit seoptimal mungkin

Fokus asuhan keperawatan gerontik menurut

1. Holistik dan Empatik: Memperhatikan aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual lansia
2. Legal dan Etik: Menjunjung hak lansia dan prinsip etik dalam pengambilan keputusan
3. Model Asuhan Gerontik: Menggunakan pendekatan siklus hidup dan teori menua sebagai dasar intervensi
4. Pencegahan dan Promosi Kesehatan: Edukasi tentang gaya hidup sehat, deteksi dini penyakit, dan pencegahan komplikasi

Sifat Pelayanan Gerontik

1. Holistik, Mencakup aspek bio-psiko-sosio-spiritual dan kultural, bukan hanya fisik. Komprehensif
2. Menyeluruh, mencakup pengkajian, diagnosis, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
3. Individualistik, Disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, dan preferensi tiap lansia.
4. Humanistik, Mengutamakan empati, penghargaan terhadap martabat, dan nilai-nilai lansia.
5. Promotif dan Preventif, Fokus pada pencegahan penyakit dan peningkatan kualitas hidup, bukan hanya kuratif.
6. Terpadu, melibatkan kolaborasi antar profesi dan keluarga dalam perawatan lansia.
7. Berorientasi kemandirian, mendorong lansia untuk tetap aktif dan mandiri sesuai kemampuan.
8. Berbasis hak pasien, menghormati hak lansia dalam pengambilan keputusan dan akses layanan kesehatan.

J. Glosarium

Alzheimer: Salah satu bentuk demensia yang melibatkan penurunan fungsi otak, terutama dalam hal daya ingat, penalaran, dan keterampilan berpikir.

Deteksi Dini: Proses identifikasi/pemeriksaan adanya kemungkinan mengidap suatu penyakit.

Edukasi: Segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan.

Evidence Base for

Practice (EBP): Penggunaan bukti ilmiah untuk mendukung pengambilan keputusan di pelayanan kesehatan

Gerontologi: Studi ilmiah tentang proses dan masalah penuaan dari semua aspek—biologis, klinis, psikologis, sosiologis, hukum, ekonomi, dan politik

Geriatri: Cabang ilmu kedokteran yang berfokus pada penanganan, diagnosis, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan yang menyerang kalangan lansia.

Holistik: Cara pandang yang menyeluruh atau secara keseluruhan.

Health Promotion: Segala bentuk kombinasi pendidikan kesehatan dan intervensi yang terkait dengan ekonomi, politik dan organisasi yang dirancang untuk memudahkan perubahan perilaku dan lingkungan yang konusif.

K. Daftar Pustaka

4th ed california. Addison. Wesley Luekenotte (2000). Gerontologic nursing. New york; mosby-year book, inc. Marwiati M dkk (2022). Senam Gerak Latih Otak Untuk Mempertahankan Fungsi Keseimbangan Lansia. Jurnal pengabdian Masyarakat. Vol 7 No 4 (2022). Senam Gerak Latih Otak Untuk Mempertahankan Fungsi Keseimbangan Lansia | Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat (unmabanten.ac.id).

Abas I dkk (2020) senam gerak latih otak (glo) mampu meningkatkan fungsi kognitif lanjut usia | abas | jurnal ilmu keperawatan dan kebidanan (umku.ac.id)

adaption norwak appleiton century – croft Kandar dkk (2019). Meningkatkan kualitas hidup lansia konsep dan berbagai intervensi. Wineka media.

Annete g.l. (1996), gerontologic nursing, st louise mosby book inc Chenittz w.c.stone j.t and salisbury s.a (1991) clinical gerontological nursing: a guide to advanced practice philadelphia : wb saunders company

Eliopoulos, C.E. 2005. Gerontological nursing. (6 th ed.), Philadelphia; Lippincott.

Eliopoulos, chariotte, 2005. Geronotologi nursing, 6th editon, philadelphia, lippincott willian & wilkins

Ginting, d. S. (2020, january 13). Peran perawat sebagai edukator dalam pengimplementasian discharge planning untuk proses asuhan keperawatan. <https://doi.org/10.31219/osf.io/kuc4v>

Giovella e.c and brill c.w (1993), nursing care of ageing client: promoting health

Kozier, et.al (1995). Fundamental of nursing. Concepts, process, and practice.

Miller a.c (1995). Nursing care of older adult, teori and practice. 2nded.
Philadelphia; j.b lippincott co

Nur fadhilah dkk (2024), Buku Ajar keperawatan Gerontik, Nuasa Fajar Cemerlang

Sarif La Ode. 2012. Asuhan Keperawatan Gerontik Berstandar Nanda, NIC, NOC,
Dilengkapi dengan Teori dan Contoh Kasus Askep. Jakarta: Nuha Medika

BAB 3

MODEL KEPERAWATAN GERONTIK

Tujuan Instruksional

Mahasiswa mampu memahami, menerapkan dan mengevaluasi Konsep Model Keperawatan Gerontik

Untuk itu marilah kita belajar bersama terkait Konsep Model Keperawatan Gerontik yang dipaparkan dalam Bab ini. Setelah mempelajari BAB ini dengan sungguh sungguh, akhir proses pembelajaran, anda diharapkan dapat:

- Mengetahui dan memahami model Madeleine Leininger
- Mengetahui dan memahami model Callista Roy
- Mengetahui dan memahami model *Orem*
- Mengetahui dan memahami model Martha E. Rogers
- Mengetahui dan memahami Model Betty Neuman
- Mengetahui dan memahami Model Virginia Henderson

Capaian Pembelajaran

Untuk memudahkan Anda mempelajari bab ini, berikut langkah-langkah belajar yang harus Anda lakukan sebagai berikut.

- Pahami dulu mengenai pentingnya perawat memahami Konsep Model Keperawatan Gerontik
- Amati bagaimana Model Keperawatan Gerontik
- Pelajari setiap topik secara bertahap, dan kerjakan tes dan tugas yang ada di bab ini.
- Keberhasilan proses pembelajaran sangat tergantung pada kesungguhan Anda untuk mempelajari isi bab ini.
- Silakan hubungi fasilitator atau dosen yang mengajar bab ini untuk mendapatkan penjelasan lebih mendalam.
- Kami yakin anda memiliki semangat dan motivasi tinggi untuk mempelajari bab ini

Pendahuluan

Pelayanan keperawatan merupakan bagian penting dalam pelayanan kesehatan yang bersifat komprehensif meliputi biopsikososiokultural dan spritual yang ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat, baik dalam keadaan sehat dan sakit dengan pendekatan proses keperawatan. Perbaikan dalam pelayanan keperawatan dan profesionalisme diawali dengan pengembangan ilmu dan teori/konsep keperawatan, karena teori keperawatan merupakan produk kreatif perawat. Keperawatan memiliki landasan teori keperawatan sehingga keperawatan dikatakan memiliki landasan ilmiah. Ilmu keperawatan dikembangkan melalui penelitian ilmiah, berorientasi pada pola pikir ilmiah yang dikembangkan melalui analisis, hipotesa dan eksperimental. Melalui teori keperawatan ini dapat membedakan keperawatan dengan disiplin ilmu lain.

Model keperawatan gerontik adalah suatu pendekatan yang fokus pada kebutuhan khusus lansia dan membantu mereka meningkatkan kualitas hidup. Model ini mempertimbangkan aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual lansia untuk memberikan perawatan yang komprehensif dan holistik. Model konseptual keperawatan dikembangkan para ahli sebagai kerangka pikir perawat. Dalam paradigma para ahli keperawatan memandang 4 komponen dalam keperawatan yaitu manusia, lingkungan, keperawatan dan kesehatan. Untuk melihat bagaimana pengembangan, perbedaan teori dan model konseptual secara empiris serta hubungan model konseptual atau teori keperawatan dengan falsafah, dan paradigma keperawatan. Tujuan Model Keperawatan Gerontik: meningkatkan kualitas hidup lansia, mengatasi masalah kesehatan fisik dan mental, meningkatkan kemandirian lansia, memberikan dukungan sosial dan emosional, karakteristik Model Keperawatan Gerontik.

Model keperawatan gerontik dapat membantu perawat memahami kebutuhan khusus lansia dan memberikan perawatan yang tepat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Tujuan pokok Model Keperawatan Gerontik agar mahasiswa saat di tatanan praktik keperawatan gerontik mampu mengaplikasikan model keperawatan gerontik dalam penerapan asuhan keperawatan gerontik di tatanan klinik. Penggunaan buku ajar ini diperuntukkan bagi mahasiswa keperawatan. Isi dari materi model keperawatan gerontik meliputi model keperawatan menurut beberapa ahli. Metode belajar materi ini dalam bentuk teks tulisan dan gambar. Pendekatan pembelajaran menggunakan pembelajaran aktif dan kolaboratif. Setelah membaca konsep dasar masing masing teori tersebut, mahasiswa dapat merapkan teori tersebut dalam kasus khususnya agregat lansia.

Uraian Materi

Uraian materi dalam Bab ini terdiri Model Keperawatan gerontik menurut beberapa ahli seperti Madeleine Leininger, Sister Callista Roy, Orem, Martha E. Rogers, Betty Neuman, Virginia Henderson

A. Model Keperawatan menurut Madeleine Leininger

Model Leininger adalah suatu teori keperawatan yang dikembangkan oleh Madeleine Leininger, yang fokus pada perawatan yang sesuai dengan budaya dan kebutuhan individu. Dalam keperawatan gerontik, model ini dapat digunakan untuk memahami kebutuhan khusus lansia dari berbagai latar belakang budaya. Teori *Culture Care Diversity and Universality* Leininger berasal dari disiplin ilmu antropologi dan keperawatan. Leininger mengembangkan teorinya berdasarkan keyakinan bahwa manusia dengan budaya yang berbeda akan membutuhkan jenis perawatan yang berbeda pula. Cultural care theory dapat berasal dari induktif dan deduktif, berasal dari pengetahuan emic (*insider*) dan etic (*outsider*). Leininger adalah orang pertama yang melihat keperawatan dari sudut pandang cultural dan antropologi social. Transkultural nursing sebagai area mayor keperawatan yang berfokus pada studi komparatif dan analisis keanekaragaman kultur dan subkultur di dunia dengan menghormati nilai – nilai perawatan, ekspresi, dan keyakinan sehat sakit dan pola perilaku. Leininger menjelaskan teorinya meliputi culture, culture value, culture care diversity, culture care universality, culture care, world view, social structure dimensions, environmental context, ethnohistory, generic care system dan lain sebagainya. Hal ini ditunjukkan melalui sunrise enabler model, dengan komponen yang begitu kompleks. Untuk itu perlu pengembangan teori selanjutnya yang lebih terfokus sehingga dapat menjadi panduan dalam melakukan penelitian-penelitian terkait aplikasi keperawatan. Dengan melihat begitu kompleks komponen dan luasnya cakupan dari model ini maka teori ini masuk ke dalam grand teori (Alligood, 2014).

Konsep Utama Keperawatan menurut Teori Leininger

Paradigma keperawatan transkultural adalah cara pandang, keyakinan, nilai-nilai dan konsep-konsep dalam terlaksananya asuhan keperawatan yang sesuai latar belakang budaya terhadap empat konsep sentral, yaitu : manusia, keperawatan, kesehatan dan lingkungan (Andrew & Boyle, 1995).

1. Manusia

Manusia adalah individu, keluarga atau kelompok yang memiliki nilai-nilai dan norma-norma yang diyakini dan berguna untuk menetapkan pilihan dan melakukan pilihan. Menurut Leininger (1991) manusia memiliki kecenderungan untuk mempertahankan budayanya pada setiap saat dimanapun dia berada (Geiger and Davidzhar, 1995). Manusia dipandang dari kulturenya melalui gender, jenis kelamin, ras, golongan, kondisi biomedis, akulturasi budaya. Manusia dengan kultur yang berbeda dibutuhkan perawatan yang berbeda, karena adanya salah persepsi dari perawat terhadap kondisi klien akan berpengaruh pada pelayanan keperawatan yang diberikan (Marilyn Parker, 2001). Manusia yang mempunyai atribut fisik dan psikologis, maka hal tersebut merupakan atribut budaya atau etnik dari individu atau kelompok masyarakat tertentu.

2. Lingkungan

Menurut Leininger (1991) lingkungan didefinisikan sebagai keadaan menyeluruh meliputi situasi, pengalaman memberikan arti bagi ekspresi individu, interpretasi dan sosial interaksi yang meliputi fisik, ekologi, sosial politik, dan setting kultur. Lingkungan fisik adalah lingkungan alam atau diciptakan oleh manusia seperti daerah katulistiwa, pegunungan, pemukiman padat dan iklim seperti rumah di daerah Eskimo yang hampir tertutup rapat karena tidak pernah ada matahari sepanjang tahun. Lingkungan sosial adalah keseluruhan struktur sosial yang berhubungan dengan sosialisasi individu, keluarga atau kelompok ke dalam masyarakat yang lebih luas. Dalam lingkungan sosial individu harus mengikuti struktur dan aturan-aturan yang berlaku di lingkungan tersebut. Lingkungan simbolik adalah keseluruhan bentuk dan simbol yang menyebabkan individu atau kelompok merasa bersatu seperti musik, seni, riwayat hidup, bahasa dan atribut yang digunakan. (Andrew & Boyle, 1995).

3. Kesehatan

Leininger (1995) mendefinisikan sehat sebagai suatu keadaan sejahtera yang diartikan dalam kultur, nilai, praktik dalam bentuk tanggung jawab individu atau kelompok ataupun masyarakat ditampilkan dalam bentuk ekspresi aturan aktivitas di kulturenya, dan bentuk pola yang ditampilkan. Asuhan keperawatan yang diberikan bertujuan meningkatkan kemampuan klien memilih serta aktif budaya yang sesuai dengan status kesehatannya. Individu memilih budaya yang sesuai dengan status kesehatan melalui proses belajar dengan lingkungan. Sehat yang dicapai adalah kesehatan *holistic* dan *humanistic*, karena melibatkan peran serta klien yang lebih dominan.

4. Keperawatan

Aktivitas yang diarahkan untuk mendukung, membantu pemenuhan kebutuhan yang kongruen dengan nilai budaya, kepercayaan, cara hidup dari penerima perawatan. Leininger mendefinisikan keperawatan sebagai ilmu pengetahuan dan seni humanistik yang berfokus pada perilaku perawatan personal, fungsi dan proses yang diarahkan untuk promosi dan mempertahankan perilaku sehat atau proses penyembuhan dari penyakit. Keperawatan sebagai profesi perawatan transkultural yang unik karena aktivitas perawatan pasien ditujukan untuk memberikan dukungan dan mempersiapkan pasien untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan nilai budaya, kepercayaan dan gaya hidup mereka (Masters, 2010). Strategi yang digunakan dalam asuhan keperawatan adalah perlindungan/ mempertahankan budaya, mengakomodasi/ menegosiasi budaya dan restrukturisasi budaya (Leininger, 1991).

- a. Mempertahankan budaya, dilakukan bila budaya pasien tidak bertentangan kesehatan. Misal : budaya berolahraga setiap pagi.
- b. Negosiasi budaya, dilakukan untuk membantu klien beradaptasi terhadap budaya tertentu yang lebih menguntungkan kesehatan. Perawat membantu klien agar dapat memilih dan menentukan budaya lain yang lebih mendukung peningkatan kesehatan. Misal : Ibu hamil yang pantang makan makanan yang berbau amis, maka ikan dapat diganti dengan sumber protein hewani yang lain.
- c. Restrukturisasi budaya
Restrukturisasi budaya klien dilakukan bila budaya yang dimiliki merugikan status kesehatan. Perawat berupaya merestrukturisasi gaya hidup klien sebagai perokok aktif untuk mengurangi konsumsi rokoknya. Pola rencana hidup yang dipilih biasanya yang lebih menguntungkan dan sesuai dengan keyakinan yang dianut.

Komponen konsep *Theory's of Culture Care Diversity and Universality*

Leininger mengembangkan istilah yang relevan dengan teorinya, yaitu:

a. *Human care and caring*

Mengacu pada abstrak dan manifestasi fenomena yang berupa ekspresi memberi bantuan, dukungan, memberi kesempatan, dan memfasilitasi untuk membantu orang lain dengan fakta atau antisipasi kebutuhan dalam meningkatkan kesehatan, kondisi kemanusiaan, gaya hidup serta dalam menghadapi kecacatan atau kematian.

b. *Culture*

Mengacu pada pola gaya hidup, nilai, keyakinan, norma, simbol dan praktik individu, kelompok atau organisasi, yang dipelajari, dibagikan, disosialisasikan dan selalu ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

c. *Culture Care*

Mengacu pada sintesa secara kultural dari memberi bantuan, dukungan, memberi kesempatan atau memfasilitasi tindakan keperawatan pada diri sendiri atau yang lain, berfokus pada fakta atau kebutuhan antisipasi untuk kesejahteraan kesehatan klien atau menghadapi kecacatan, kematian atau kondisi kemanusiaan yang lain.

d. *Culture Care Diversity*

Mengacu pada variasi kultural atau perbedaan dalam keyakinan perawatan, arti, pola, nilai, simbol, dan jalan hidup, diantara kultur dan kehidupan manusia.

e. *Culture Care Universality*

kesamaan kultural berdasar pada arti perawatan (kejujuran), pola, nilai, simbol, dan jalan hidup yang menggambarkan perawatan sebagai kemanusiaan universal.

f. *Worldview*

Mengacu pada cara pandang individu atau kelompok dan pengertian dunia mereka tentang nilai, gambar, sikap, atau perspektif tentang hidup dan dunia.

g. *Cultural and Social Structure Dimensions*

Mengacu pada dimensi yang dinamis, holistik, dan pola yang saling berhubungan dari struktur kultur/subkultur, termasuk agama (spiritual), persaudaraan (sosial), karakteristik politik (legal), ekonomi, edukasi, teknologi, nilai kultural/budaya, filosofi, sejarah dan bahasa.

h. *Environmental Context*

Mengacu pada totalitas dari lingkungan (fisik, geografi, dan sosiokultural), situasi, atau kejadian yang berhubungan dengan pengalaman yang memberikan interpretasi, memberi petunjuk terhadap ekspresi manusia dan pengambilan keputusan dengan referensi lingkungan atau situasi tertentu.

i. *Ethnohistory*

Mengacu pada urutan fakta, kejadian atau perkembangan waktu yang diketahui, dibuktikan atau didokumentasi tentang proses terjadinya suatu budaya manusia.

j. *Emic*

Mengacu pada pandangan dan nilai fenomena yang bersifat lokal, indigenous, dari dalam.

k. *Etic*

Mengacu pada pandangan dan nilai fenomena yang sifatnya dari luar dan lebih universal.

l. *Health*

Mengacu pada kondisi kesejahteraan atau kondisi restoratif yang dipahami secara kultural, ditemukan, dinilai dan dipraktikkan oleh individu atau kelompok dan memberi kesempatan mereka untuk berfungsi dalam kehidupan sehari – hari.

m. *Transcultural Nursing*

Mengacu pada area formal humanistic, ilmu pengetahuan dan praktek yang berfokus pada fenomena holistik *cultural care and caring*, kompetensi untuk membantu individu / kelompok mempertahankan dan meningkatkan kesehatan / kesejahteraan, beradaptasi dengan kecacatan, kematian atau kondisi kemanusiaan lainnya dalam budaya yang kongruen dan bermanfaat.

n. *Culture Care Preservation or Maintenance*

Mengacu pada tindakan profesional untuk memberikan bantuan, dukungan, fasilitasi, memberi kesempatan dan pengambilan keputusan untuk membantu orang dalam budaya tertentu dalam rangka mempertahankan serta memelihara nilai keperawatan dan gaya hidup untuk kesejahteraan manusia, untuk sembuh dari sakit, atau beradaptasi dengan penderitaan atau kematian.

o. *Culture Care Accommodation or Negotiation*

Mengacu pada tindakan profesional untuk memberikan bantuan, dukungan, fasilitasi, atau memberi kesempatan dan pengambilan keputusan yang membantu orang menemukan kultur/sub kultur untuk beradaptasi, melakukan negosiasi dengan yang lain untuk mencapai tujuan kesehatan yang kongruen dan bermanfaat.

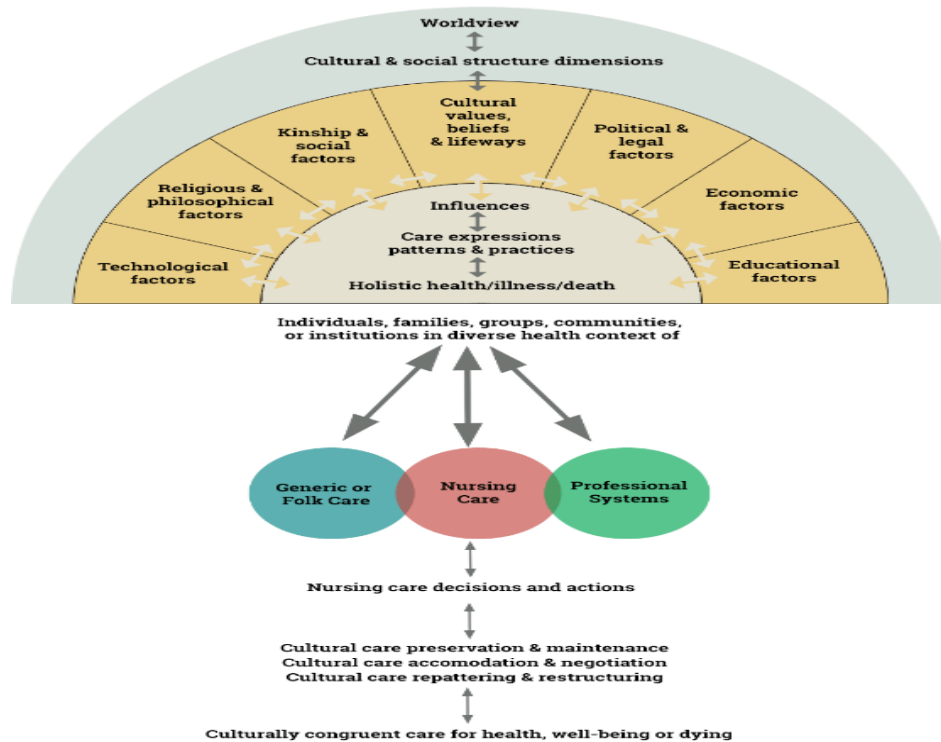
p. *Culture Care Repatterning or Restructuring*

Mengacu pada tindakan profesional untuk memberikan bantuan, dukungan, fasilitasi, memberi kesempatan dan pengambilan keputusan untuk membantu pasien berubah atau memodifikasi gaya hidup mereka untuk tujuan kesehatan yang baru, berbeda dan bermanfaat.

q. *Culturally Competent Nursing Care*

Mengacu pada penggunaan kemampuan budaya secara eksplisit berdasarkan kepedulian dan pengetahuan kesehatan yang sensitif, kreatif dan bermakna untuk memastikan gaya hidup secara general, kebutuhan individu atau kelompok untuk manfaat kesehatan dan kesejahteraan, atau menghadapi sakit, kecacatan dan kematian.

Madeleine Leininger's Transcultural Nursing
The Sunrise Enabler to
Discover Culture Care Sunrise Model



Gambar 3.1 Sunrise Model

Aplikasi Model Leininger dalam Keperawatan Gerontik:

1. Menghargai Nilai-Nilai Budaya Lansia: Memahami dan menghargai nilai-nilai budaya lansia dalam memberikan perawatan.
2. Mengembangkan Rencana Perawatan yang Sesuai: Mengembangkan rencana perawatan yang sesuai dengan kebutuhan individu lansia dan budaya mereka.
3. Meningkatkan Kualitas Hidup Lansia: Meningkatkan kualitas hidup lansia dengan memberikan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan dan budaya mereka.

Dengan menggunakan model Leininger, perawat dapat memberikan perawatan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan khusus lansia dari berbagai latar belakang budaya.

B. Model Keperawatan menurut Model Callista Roy

Teori Roy adalah suatu teori keperawatan yang dikembangkan oleh Sister Callista Roy, yang fokus pada adaptasi individu terhadap perubahan lingkungan. Dalam konteks keperawatan lansia, teori ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana lansia beradaptasi dengan perubahan fisik, psikologis, dan sosial yang terkait dengan penuaan. Teori Roy dikenal dengan "Model Adaptasi Roy". Menurut Roy, adaptasi merupakan suatu proses dari seseorang dalam berperilaku

pengeluaran hasil pemikiran dan merasakan sebagai individu atau kelompok guna menciptakan lingkungan yang terintegrasi. Adaptasi ini ada karena adanya suatu stimulus. Stimuli umum yang mempengaruhi Adaptasi antara lain:

1. *Kultur* – Status sosial ekonomi, etnis, sistem keyakinan
2. *Keluarga* – Struktur dan tugas-tugas.
3. *Tahap Perkembangan* – Faktor usia, jenis, tugas, keturunan, dan genetik.
4. *Integritas Modes Adaptif* Fisiologis (mencakup patologi penyakit), konsep diri, fungsi peran, interdependensi.
5. *Efektivitas Cognitor* Persepsi, pengetahuan, ketrampilan.
6. *Pertimbangan Lingkungan* Perubahan lingkungan internal atau eksternal, pengelolaan medis, menggunakan obat-obat, alkohol, tembakau.

Marriner-Tomey (2006) Terdapat 3 tingkatan adaptasi pada manusia, diantaranya;

1. Stimuli Fokal yaitu stimulus yang langsung beradaptasi dengan seseorang dan akan mempunyai pengaruh kuat terhadap seorang individu
2. Stimuli Kontekstual yaitu stimulus yang dialami seseorang dan baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi, kemudian dapat dilakukan observasi, diukur secara subyektif.
3. Stimuli Residual yaitu stimulus lain yang merupakan ciri tambahan yang ada atau sesuai dengan situasi dalam proses penyesuaian dengan lingkungan yang sukar dilakukan observasi.

Tiga proses adaptasi yang dikemukakan Roy:

1. Mekanisme koping. Pada sistem ini terdapat dua mekanisme yaitu pertama mekanisme koping bawaan yang prosesnya secara tidak disadari manusia tersebut, yang ditentukan secara genetik atau secara umum dipandang sebagai proses yang otomatis pada tubuh. Kedua yaitu mekanisme koping yang didapat dimana coping tersebut di peroleh melalui pengembangan atau pengalaman yang dipelajarinya
2. Pengaturan subsistem. Merupakan proses coping yang menyertakan subsistem tubuh yaitu saraf, proses kimiawi dan sistem endokrin.
3. Cognitor subsistem. Proses coping seseorang yang menyertakan empat sistem pengetahuan dan emosi: pengolahan persepsi dan informasi, pembelajaran, pertimbangan, dan emosi.

Marriner-Tomey (2006) Sistem adaptasi memiliki empat mode adaptasi diantaranya;

1. Fungsi Fisiologis; Sistem adaptasi fisiologis diataranya adalah oksigenasi, nutrisi, eliminasi, aktivitas dan istirahat, integritas kulit, indera, cairan dan elektrolit, fungsi neurologis dan endokrin,
2. Konsep diri; Bagaimana seseorang mengenal pola-pola interaksi sosial dalam berhubungan dengan orang lain.

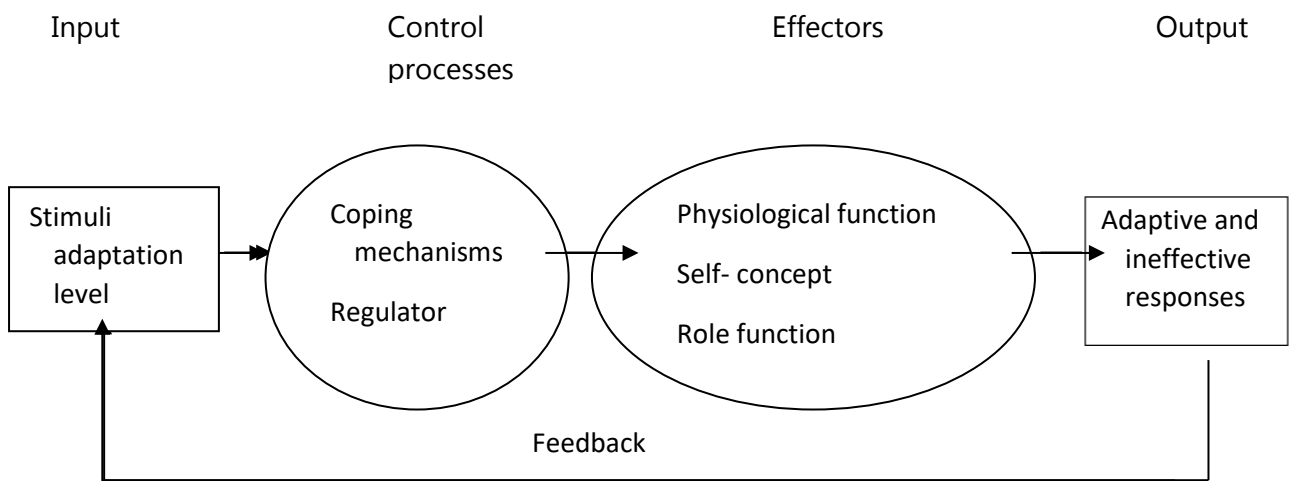
3. Fungsi peran; Proses penyesuaian yang berhubungan dengan bagaimana peran seseorang dalam mengenal pola-pola interaksi sosial dalam berhubungan dengan orang lain.
4. Interdependent; Kemampuan seseorang mengenal pola-pola tentang kasih sayang, cinta yang dilakukan melalui hubungan secara interpersonal pada tingkat individu maupun kelompok.

Terdapat dua respon adaptasi yang dinyatakan Roy yaitu:

1. Respon yang adaptif dimana terminologinya adalah manusia dapat mencapai tujuan atau keseimbangan sistem tubuh manusia.
2. Respon yang tidak adaptif dimana manusia tidak dapat mengontrol dari terminologi keseimbangan sistem tubuh manusia, atau tidak dapat mencapai tujuan yang akan di raih.

KERANGKA SKEMATIK MODEL ADAPTASI ROY

Dari pengetahuan diatas dapat di gambarkan melalui kerangka mekanisme sebagai berikut ini (Marriner-Tomey, 2006):



Gambar 3.2 Model Adaptasi Roy

Konsep Utama Teori Roy:

1. Stimuli : Stimuli adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan adaptasi individu, baik dari dalam maupun dari luar diri individu.
2. Proses Adaptasi : Proses adaptasi adalah cara individu mengatasi stimuli dan mempertahankan keseimbangan dan kesehatan.
3. Respon Adaptif : Respon adaptif adalah hasil dari proses adaptasi, yang dapat berupa fisiologis, psikologis, atau sosial.

Dengan memahami ketiga bagian besar ini, perawat dapat membantu individu, termasuk lansia, beradaptasi dengan perubahan dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Aplikasi Teori Roy dalam Keperawatan Lansia:

1. Mengidentifikasi Stimuli yang Mempengaruhi Adaptasi Lansia: Membantu lansia mengidentifikasi stimuli yang mempengaruhi kemampuan adaptasi mereka.
2. Mengembangkan Strategi Adaptasi: Membantu lansia mengembangkan strategi adaptasi untuk mengatasi perubahan fisik, psikologis, dan sosial.
3. Meningkatkan Kemampuan Adaptasi Lansia: Membantu lansia meningkatkan kemampuan adaptasi mereka untuk mempertahankan keseimbangan dan kesehatan.

Dengan menggunakan teori Roy, perawat dapat membantu lansia beradaptasi dengan perubahan yang terkait dengan penuaan dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

C. Model Keperawatan menurut Konseptual model Orem

Teori Orem adalah suatu teori keperawatan yang dikembangkan oleh Dorothea Orem, yang fokus pada kemampuan individu untuk melakukan perawatan diri sendiri. Dalam konteks kesehatan lansia, teori ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana lansia dapat melakukan perawatan diri sendiri dan meningkatkan kemandirian mereka. Teori *self care deficit* Dorothea E. Orem diturunkan pada tahun 1958 sebagai pandangan tentang konsep keperawatan yaitu keinginan pasien untuk merawat dirinya sendiri. Pengetahuan ini muncul dari pengetahuan Orem pada sifat-sifat situasi praktik keperawatan. Menurut Orem (2007) *self care* merupakan kemampuan individu untuk memprakarsai dirinya dalam melakukan perawatan diri sendiri dalam rangka mempertahankan kehidupan, kesehatan dan kesejahteraan.

Teori Orem dikenal dengan "*teori self care deficit*". Teori ini disusun berdasarkan tiga teori yang berhubungan yaitu: *self care*, *self care deficit* dan *nursing system*. Asumsi dasar dari ketiga hal tersebut menurut Orem, adalah sebagai berikut:

1. Perawatan Sendiri (Self Care)

Menggambarkan atau menjelaskan tentang perawatan diri sendiri dalam suatu kontribusi berkelanjutan pada orang dewasa bagi eksistensi, kesehatan dan kesejahteraannya. Dapat pula diartikan sebagai latihan aktifitas yang individunya dalam memulai dan menampilkan kepentingan mereka dalam mempertahankan hidup, kesehatan dan kesejahteraan

Mayo (1997) menyebutkan bahwa perawatan sendiri adalah suatu kebutuhan universal untuk menjaga dan meningkatkan eksistensinya,

kesehatannya, dan kesejahteraan hidupnya. Perawat membantu klien untuk mencapai kemampuan perawatan diri dengan pemenuhan udara, air, makanan, kebersihan, aktifitas dan istirahat, menyendiri dan interaksi sosial, pencegahan dari bahaya, dan pengenalan fungsi makhluk hidup. Delapan syarat ini menampilkan macam-macam perbuatan manusia yang akan membawa pada kondisi internal dan eksternal yang dapat mempertahankan fungsi dan struktur manusia. Ketika hal ini secara efektif tersedia, perawatan diri atau perawatan bergantung yang terorganisir seputar syarat perawatan mandiri membantu perkembangan positif bagi kesehatan dan kesejahteraan (Tommey & Alligood, 2006).

2. Ketidakmampuan Perawatan Mandiri (*Self Care Deficit*)

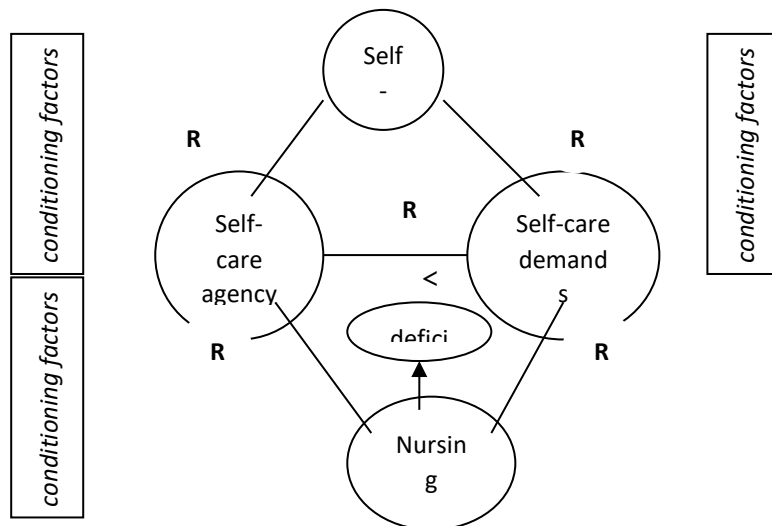
Self Care Deficit adalah suatu kondisi manakala seseorang mengalami ketidakmampuan atau ketidakpedulian pada dirinya sendiri. Ketidakmampuan klien ini memerlukan agen keperawatan yang mempunyai kemampuan khusus untuk memberikan perawatan yang akan menggantikan kerugian atau memberikan bantuan dalam mengatasi penurunan kesehatan

Terkait hal tersebut dikenal adanya agen keperawatan yang mempunyai kemampuan khusus yang memungkinkan mereka memberikan perawatan yang akan menggantikan kerugian atau bantuan dalam mengatasi turunan kesehatan atau perawatan mandiri. Agen keperawatan (*Nursing agency*) yaitu karakteristik orang yang mampu memenuhi status perawatan dalam kelompok-kelompok sosial. Sementara itu Orem (2007) menyebutkan juga bahwa *self care agency* adalah individu yang dapat memberikan bantuan dalam kegiatan perawatan diri. Ada tambahan tiga istilah yang berhubungan dengan "*Self care agency*", yaitu "*agent*", "*self care agent*", "*dependent care agent*". "*Agent*" adalah orang yang mengambil tindakan. "*Self care agent*" adalah penyedia perawatan mandiri. "*Dependent care agent*" adalah penyelenggara perawatan (misalnya keluarga)

3. Sistem-sistem Keperawatan (Nursing Systems)

Sistem-sistem keperawatan dibentuk ketika para perawat menggunakan kemampuan-kemampuan mereka untuk menetapkan, merancang, dan memberikan perawatan kepada pasien (sebagai individu atau kelompok) Aksi-aksi ini atau sistem-sistem keperawatan ini mengatur nilai kemampuan atau latihan kemampuan individu dihubungkan dengan *self care* dan mempertemukan syarat-syarat perawatan sendiri bagi individu dengan cara terapi yang tepat.

Terdapat tiga teori yang saling berkaitan yaitu teori *self care*, *self care deficit* dan *nursing system* yang dapat dilihat dari gambar 3.3.



Gambar 3.3. Struktur konseptual dari teori self care deficit
(sumber: *Nursing Theorists and Their Work St.Louis: Mosby, h. 183.*)

Penjelasan gambar :

Pemenuhan kebutuhan lansia di rumah/panti berdasarkan Orem Terdapat 3 (tiga) tingkatan / kategori sistem keperawatan dengan berbagai tingkatan:

1. *Wholly Compensatory System* : Dibutuhkan tindakan perawat secara total untuk pemenuhan self care, menyediakan kebutuhan self care akibat ketidakmampuan lansia, mensupport dan melindungi lansia. Pada umumnya dibutuhkan untuk lansia yang tidak mampu mengontrol dan memantau lingkungannya dan tidak berespon terhadap rangsangan.
2. *Partially Compensatory System* : Sebagian tindakan pemenuhan dilakukan oleh perawat dan sebagian lagi oleh lansia sendiri. Tindakan yang dilakukan perawat berupa pengkajian penentuan kebutuhan self care lansia, menyediakan kebutuhan self care akibat keterbatasan lansia, membantu lansia sesuai indikasi yang dibutuhkan. Sedangkan tindakan lansia dengan kebutuhan self carenya, meregulasi self care agency menerima perawatan dan membantu perawat. Biasanya dilakukan pada lansia-lansia dengan keterbatasan gerak, dll.
3. *Supportive Educative System* : Tindakan perawat hanya meregulasi pelatihan dan mensupport perkembangan self agency, sedangkan kebutuhan self care mampu dikerjakan oleh lansia

Konsep Utama Teori Orem:

1. Perawatan Diri Sendiri: Individu memiliki kemampuan untuk melakukan perawatan diri sendiri dan mempertahankan kesehatan.
2. Kemandirian: Kemandirian individu dalam melakukan perawatan diri sendiri dapat mempengaruhi kesehatan dan kualitas hidup.

Aplikasi Teori Orem dalam Kesehatan Lansia:

1. Meningkatkan Kemandirian Lansia_: Membantu lansia meningkatkan kemandirian mereka dalam melakukan perawatan diri sendiri.
2. Mengembangkan Kemampuan Perawatan Diri Sendiri_: Membantu lansia mengembangkan kemampuan perawatan diri sendiri dan mempertahankan kesehatan.
3. Mengurangi Ketergantungan_: Membantu lansia mengurangi ketergantungan pada orang lain dan meningkatkan kemampuan perawatan diri sendiri.

Dengan menggunakan teori Orem, perawat dapat membantu lansia meningkatkan kemandirian dan kemampuan perawatan diri sendiri, sehingga meningkatkan kualitas hidup mereka.

D. Model Keperawatan menurut Teori Martha E. Rogers

Teori Martha E. Rogers adalah suatu teori keperawatan yang fokus pada konsep kesatuan manusia dan lingkungan. Dalam konteks kesehatan lansia, teori ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana lansia berinteraksi dengan lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Rogers meletakkan sekumpulan asumsi-asumsi dasar yang menggambarkan proses kehidupan manusia. Asumsi-asumsi yang merupakan kunci utama Martha E. Rogers terhadap empat konsep sentral adalah sebagai berikut:

1. Keperawatan

Rogers menyatakan bahwa ilmu keperawatan adalah Unitary Human Being, yaitu manusia sebagai unit. Dia mengartikan bahwa tidak ada ilmu lain yang mempelajari manusia secara keseluruhan atau utuh. Rogers menjelaskan keperawatan sebagai profesi yang menggabungkan unsur ilmu pengetahuan dan seni. Keperawatan adalah ilmu pengetahuan humanistik yang didedikasikan untuk menghibur agar dapat menjaga dan memperbaiki kesehatan, mencegah penyakit, dan merawat serta merehabilitasi seseorang yang sakit dan cacat. Praktek professional keperawatan bersifat kreatif, imajinatif, eksis untuk melayani orang, hal tersebut berakar dalam keputusan intelektual, pengetahuan abstrak dan perasaan makhluk. (Rogers,1992 dalam Meleis 2007).

2. Kesehatan

Istilah kesehatan digunakan sebagai terminologi nilai yang ditentukan oleh budaya atau individu. Kesehatan dan penyakit merupakan manifestasi pola dan dianggap menunjukkan pola perilaku yang nilainya tinggi dan rendah. Rogers memandang konsep sehat-sakit sebagai suatu ekspresi dari interaksi manusia dengan lingkungannya dalam proses yang mendasar (Fitzpatrick dan Whall, 1986).

3. Lingkungan,

Lingkungan sebagai empat bangunan energi yang tidak dapat direduksi yang diidentifikasi dengan pola dan manifestasi karakteristik yang spesifik. Lingkungan mencakup segala sesuatu yang berada diluar yang diberikan oleh bangunan manusia. (Meleis 2007)

4. Manusia

Manusia merupakan satu kesatuan yang utuh dan memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda. Proses kehidupan manusia dinamis selalu berinteraksi dengan lingkungan, saling mempengaruhi dan dipengaruhi atau sebagai system terbuka. Rogers juga mengkonsepkan manusia sebagai unit yang mampu berpartisipasi secara kreatif dalam perubahan. (Meleis, 2007).

Konsep Utama Teori Martha E. Rogers:

1. Kesatuan Manusia dan Lingkungan: Manusia dan lingkungan adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
2. Pola dan Proses Kehidupan: Pola dan proses kehidupan individu dapat mempengaruhi kesehatan dan kualitas hidup.

Aplikasi Teori Martha E. Rogers dalam Kesehatan Lansia:

1. Meningkatkan Kualitas Hidup Lansia_: Membantu lansia meningkatkan kualitas hidup mereka dengan memahami pola dan proses kehidupan mereka.
2. Mengembangkan Interaksi yang Positif dengan Lingkungan_: Membantu lansia mengembangkan interaksi yang positif dengan lingkungan dan meningkatkan kemampuan adaptasi mereka.
3. Meningkatkan Kesadaran dan Pemahaman Diri_: Membantu lansia meningkatkan kesadaran dan pemahaman diri tentang kebutuhan dan kemampuan mereka.

Dengan menggunakan teori Martha E. Rogers, perawat dapat membantu lansia memahami kesatuan antara diri mereka dan lingkungan, sehingga meningkatkan kualitas hidup mereka.

E. Model Keperawatan menurut Model Betty Neuman

Model Neuman adalah suatu model keperawatan yang fokus pada konsep stres dan kemampuan individu untuk mengatasi stres. Dalam konteks kesehatan lansia, model ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana lansia dapat mengatasi stres dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Model konsep yang dikemukakan oleh Betty Neuman adalah model konsep Health Care System yaitu model konsep yang menggambarkan aktivitas keperawatan yang ditujukan kepada penekanan penurunan stress dengan memperkuat garis pertahanan diri secara fleksibel atau normal maupun resisten

dengan sasaran pelayanan adalah klien sebagai sistem yang dapat berupa individu, keluarga, kelompok, komunitas, atau kelompok sosial tertentu.

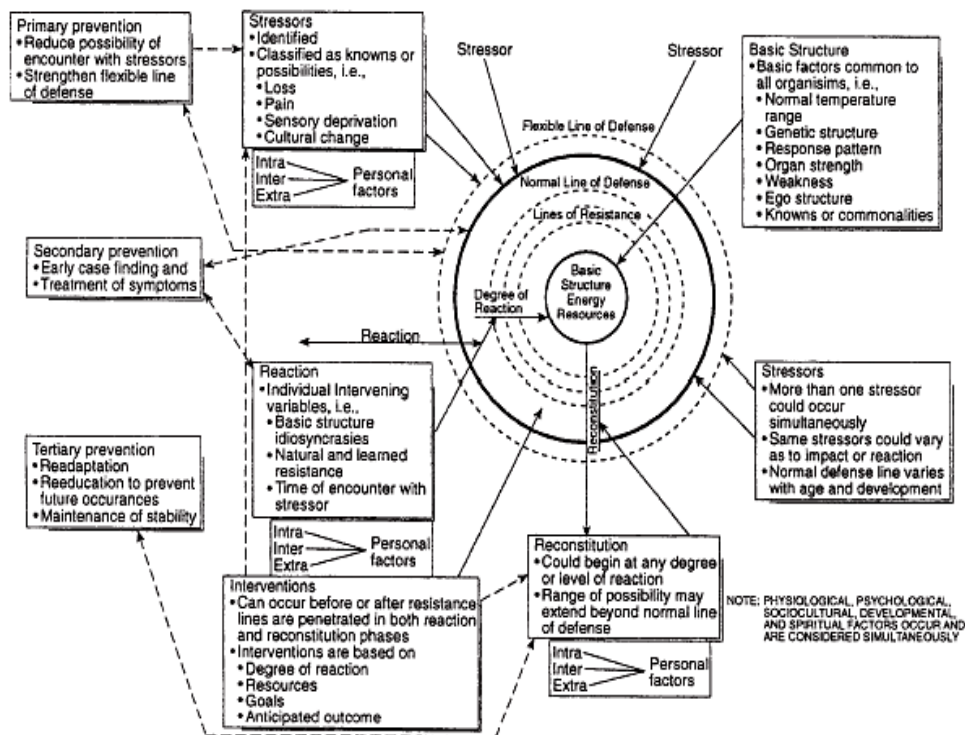
Garis pertahanan diri pada klien sebagai sistem tersebut meliputi garis pertahanan fleksibel, meliputi hubungan antara variabel fisiologi, psikologi, sosiokultural, perkembangan dan spiritual, ketersediaan pelayanan, lingkungan yang sehat, sikap masyarakat terhadap kesehatan, ketersediaan dana pelayanan kesehatan, iklim, dan pekerjaan .

Garis pertahanan normal yang meliputi pola coping individu, gaya hidup dan tahap perkembangan, ketersediaan pelayanan, adanya perlindungan status nutrisi secara umum, tingkat pendapatan, rumah yang memenuhi syarat kesehatan dan sikap masyarakat terhadap kesehatan. Garis pertahanan resisten lingkaran ini menyediakan sumber-sumber yang membantu klien mempertahankan melawan suatu stresor misalnya mekanisme sistem kekebalan tubuh.

Intervensi keperawatan diarahkan pada garis pertahanan dengan penggunaan pencegahan primer meliputi berbagai tindakan keperawatan seperti mengidentifikasi adanya stresor, mencegah reaksi tubuh karena adanya stresor serta mendukung coping secara konstruktif. Pencegahan sekunder meliputi berbagai tindakan keperawatan yang dapat mengurangi atau menghilangkan gejala penyakit serta reaksi tubuh lainnya karena adanya stresor. Pencegahan tertier meliputi pengobatan secara rutin dan teratur serta pencegahan terhadap adanya kerusakan lebih lanjut dari komplikasi suatu penyakit. Untuk mencapai upaya pencegahan yang maksimal diperlukan adanya pendidikan dan pemeliharaan kesehatan.

Betty Neuman dalam memahami konsep keperawatan ini memiliki dasar pemikiran yang terkait dengan komponen paradigma yaitu memandang manusia sebagai suatu sistem terbuka, yang selalu mencari keseimbangan dan merupakan satu kesatuan dari variabel yang utuh diantaranya fisiologis, psikologis, sosiokultural dan spiritual, juga memandang pelayanan keperawatan akan dipengaruhi lingkungan sekitar klien serta memandang sehat sebagai kondisi terbebasnya dari gangguan pemenuhan kebutuhan dan merupakan keseimbangan yang dinamis yang terhindar dari stressor.

Secara umum fokus dari model konsep keperawatan menurut Neuman ini berfokus pada respon terhadap stressor serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses adaptasi pada pasien. Untuk itu tindakan keperawatan yang seharusnya dilakukan menurut Neuman adalah mencegah atau mengurangi adanya reaksi tubuh akibat stresor . Upaya tersebut dapat juga dinamakan pencegahan primer, sekunder dan tersier.



Gambar 3.4 Teori Betty Neuman

Konsep Utama Model Neuman:

1. Stres: Stres dapat mempengaruhi kesehatan dan kualitas hidup individu.
2. Garis Pertahanan: Individu memiliki garis pertahanan yang dapat membantu mengatasi stres.

Aplikasi Model Neuman dalam Kesehatan Lansia:

1. Mengidentifikasi Stres pada Lansia: Membantu lansia mengidentifikasi stres yang mempengaruhi kesehatan dan kualitas hidup mereka.
2. Mengembangkan Strategi Mengatasi Stres: Membantu lansia mengembangkan strategi mengatasi stres dan meningkatkan kemampuan adaptasi mereka.
3. Meningkatkan Kualitas Hidup Lansia: Membantu lansia meningkatkan kualitas hidup mereka dengan mengatasi stres dan meningkatkan kemampuan adaptasi mereka.

Dengan menggunakan model Neuman, perawat dapat membantu lansia mengatasi stres dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

F. Model Keperawatan menurut Model Virginia Henderson

Model Virginia Henderson adalah suatu model keperawatan yang fokus pada konsep kebutuhan dasar manusia. Dalam konteks kesehatan lansia, model ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana lansia dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Model konsep keperawatan yang

dijelaskan oleh Virginia Henderson adalah model konsep aktivitas sehari-hari dengan memberikan gambaran tentang fungsi utama perawat yaitu menolong seseorang yang sehat/sakit dalam usaha menjaga kesehatan atau penyembuhan atau untuk menghadapi kematiannya dengan tenang. Usaha tersebut dapat dilakukan sendiri oleh klien bila ia sadar, berkemauan dan cukup kuat, oleh karena itu perawat berperan untuk memandirikan klien sebagai kemampuan yang harus dimiliki.

Konsep Utama Model Virginia Henderson:

1. Kebutuhan Dasar Manusia_: Individu memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk mempertahankan kesehatan dan kualitas hidup.
2. 14 Kebutuhan Dasar: Model Virginia Henderson mengidentifikasi 14 kebutuhan dasar manusia, termasuk:
 - a. Bernapas
 - b. Makan dan minum
 - c. Eliminasi
 - d. Bergerak dan beraktivitas
 - e. Istirahat dan tidur
 - f. Berpakaian dan menjaga penampilan
 - g. Mengatur suhu tubuh
 - h. Menjaga kebersihan dan kesehatan
 - i. Menghindari bahaya
 - j. Berkomunikasi
 - k. Beribadah dan memiliki keyakinan
 - l. Bekerja dan berkarya
 - m. Bermain dan beraktivitas rekreasi
 - n. Belajar dan mengembangkan diri

Aplikasi Model Virginia Henderson dalam Kesehatan Lansia:

1. Mengidentifikasi Kebutuhan Dasar Lansia: Membantu lansia mengidentifikasi kebutuhan dasar mereka yang harus dipenuhi.
2. Mengembangkan Rencana Perawatan: Membantu lansia mengembangkan rencana perawatan yang sesuai dengan kebutuhan dasar mereka.
3. Meningkatkan Kualitas Hidup Lansia: Membantu lansia meningkatkan kualitas hidup mereka dengan memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Dengan menggunakan model Virginia Henderson, perawat dapat membantu lansia memenuhi kebutuhan dasar mereka dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

G. Latihan Soal

1. Teori model keperawatan yang menekankan pada kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan perawatan dirinya tanpa ada ketergantungan dengan orang lain (mandiri) adalah....
 - A. Virginia Henderson
 - B. Dorothea Orem
 - C. Leininger
 - D. Watson
 - E. Calista Roy

2. Konsep kesehatan menurut teori Dorothea Orem adalah...
 - A. Konsep yang penting dalam perawatan transkultural
 - B. Suatu keadaan dan proses menjadi manusia secara utuh dan terintegrasi secara keseluruhan
 - C. Sehat sebagai pengalaman hidup manusia yang dinamis
 - D. Kesehatan adalah kualitas dari kehidupan dan dasar dari fungsi manusia
 - E. Suatu keadaan sehat secara fisik, psikologis, interpersonal dan social

3. Teori leininger adalah teori yang berasal dari ilmu
 - A. Biologi
 - B. Antropologi
 - C. Biopsikologi
 - D. Analogi
 - E. Sosiologi

4. Leininger mengembangkan teorinya berdasarkan dari perbedaan
 - A. manusia dan kultur
 - B. kultur dan lingkungan
 - C. manusia dan universal
 - D. manusia dan lingkungannya
 - E. kultur dan universal

5. Berikut ini, mana yang termasuk tiga komponen dalam model adaptasi Roy?
 - A. Complex stimuli
 - B. Ficial stimuli
 - C. Residual stimuli
 - D. Contextual stimuli
 - E. Fixal stimuli

6. Apa yang dimaksud dengan Focal stimuli ?
 - A. Stimulus yang secara langsung mengharuskan manusia berespon adaptif
 - B. Semua stimulus lain yang dialami seseorang baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi situasi dan dapat diobservasi, diukur dan secara subyektif dilaporkan
 - C. stimulus lain yang merupakan cirri tambahan yang ada atau sesuai dengan situasi dalam proses penyesuaian dengan lingkungan yang sukar dilakukan observasi.
 - D. Bentuk mekanisme coping yang di gunakan untuk observasi
 - E. Stimulus untuk subsistem kognator dapat eksternal maupun internal

7. Apa tujuan keperawatan menurut Callista Roy ?
 - A. Meningkatkan respon adaptasi berhubungan dengan empat mode respon adaptasi
 - B. Melakukan intervensi keperawatan serta membina hubungan terapeutik, intervensi keperawatan bertujuan untuk membantu meningkatkan dan mencegah penyakit serta memperbaiki status kesehatan
 - C. Membedakan keperawatan dengan disiplin ilmu lain bertujuan menggabarkan, menjelaskan, memperkirakan dan mengontrol hasil asuhan dan pelayanan keperawatan yang dilakukan
 - D. Membantu keseimbangan individu terutama coping atau cara pemecahan masalah yang dilakukan ketika sakit
 - E. Mengidentifikasi adanya stresor, mencegah terjadinya reaksi tubuh karena adanya stresor serta mendukung coping pasien yang konstruktif

8. Model teori apa yang dikemukakan oleh betty neuman ...
 - A. Self care
 - B. Soft care
 - C. Hot shot
 - D. Healt care system
 - E. External

9. Apa yang dimaksud dengan Healt care system
 - A. Ketika klien tidak dapat beradaptasi dari lingkungan external dan internal.
 - B. Sehat sebagai kondisi terbebasnya dari gngguan pemenuhan kebutuhan dan merupakan keseimbangan yang dinamis dari menghindari stress.
 - C. Model konsep yang menggambarkan aktifitas keperawatan yang ditujukan kepada penekanan penurunan stress dengan memperkuat garis pertahanan

diri secara fleksibel atau normal maupun resisten dengan sasaran pelayanan adalah komunitas.

- D. Suatu system terbuka yang selalu mencari keseimbangan dan merupakan suatu kesatuan dari variable yang utuh di antaranya fisiologis.
- E. Kebiasaan merawat orang sakit jiwa.

10. Untuk memberikan penguatan pertahanan tubuh terhadap stressor melalui pendidikan kesehatan dan untuk membantu dalam pencegahan terjadinya masalah yang sama merupakan prinsip dari ..
- A. Prinsip dari pencegahan tersier.
 - B. Prinsip dari pencemaran tersier.
 - C. Prinsip dari pemecahan tersier.
 - D. Prinsip dari pemilihan tersier.
 - E. Prinsip dari pemulihan tersier

Kunci Jawaban

1	B	6	A
2	E	7	A
3	B	8	D
4	E	9	C
5	D	10	A

H. Rangkuman Materi

Model keperawatan lansia adalah suatu kerangka kerja yang digunakan untuk memahami dan mengatasi kebutuhan kesehatan lansia. Beberapa model keperawatan lansia yang populer antara lain: Madeleine Leininger, Sister Callista Roy, Orem, Martha E. Rogers, Betty Neuman, Virginia Henderson. Tujuan Model Keperawatan Lansia meningkatkan Kualitas Hidup Lansia, Meningkatkan Kemandirian Lansia dan Mengembangkan Strategi Mengatasi Stres. Dengan menggunakan model keperawatan lansia, perawat dapat membantu lansia meningkatkan kualitas hidup mereka dan memenuhi kebutuhan dasar mereka.

I. Glosarium

Adaptif	:	Mudah menyesuaikan diri dengan keadaan
Akulturasibudaya	:	Proses sosial ketika dua atau lebih kebudayaan yang berbeda saling bertemu dan memengaruhi satu sama lain, menghasilkan percampuran budaya tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan aslinya
Caring	:	Peduli
Deduktif	:	Cara berpikir dari pernyataan umum kemudian ditarik kesimpulan spesifik atau khusus
Kolaboratif	:	Upaya kerja sama
Gaya Hidup	:	Tingkah laku hidup sehari-hari manusia
Holistik	:	Dampak kesehatan pada seluruh tubuh
Induktif	:	Cara berpikir dari fakta-fakta yang spesifik, kemudian menyimpulkan menjadi sebuah pernyataan atau umum di bagian akhir
Kognator	:	Subsistem mekanisme coping dengan respon melalui proses
Kompleks	:	Persepsi informasi, mengambil keputusan dan belajar.
Coping	:	Cara yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah dan beradaptasi dengan perubahan
Kontekstual	:	Berhubungan dengan konteks
LiveWays	:	Cara hidup
Negoisasi	:	Proses tawar-menawar dengan cara berunding
Partly	:	Memberikan bantuan sebagian
Compensatory		
Regulator	:	Pengatur
Religius	:	Bersifat keagamaan
Restrukturisasi	:	Penataan kembali
Residual	:	Sisa
Supportive	:	Dukungan yang edukatif
Educative		
Self Care	:	Perawatan diri

J. Daftar Pustaka

- Alligood, R., Martha. (2014). *Nursing Theorists and Their Work*, 7th Ed. St.Louis, Missouri : Elsevier Inc.
- Andrew,M., & Boyle,J.S., (1995). *Transcultural Concepts in Nursing Care* 2nd Ed. Philadelphia : J.B. Lippincot Company
- Cardinal Stritch University Library, 2008, Orem Frameworks, diakses dari www.cardinalstrichuniversity.au.edu/library/Nursing_theorists/dorotheaorem.htm
- Connerley, K., Ristau, S., Lindberg, C., & McFarland, M. (1999). The Roy Model in Nursing Practice, The Roy Adaptation Model (second ed., pp. 515-534). Stamford, CT: Appleton & Lange.
- Ed. USA : Mosby Inc.
- Fawcett, J. (2006). *Contemporary Nursing Knowledge Analysis and Evaluation of Nursing Models and Theorist*, 2nd. Philadelphia : F.A. Davis Company
- Giger,J.J. & Davidhizar ., R.E. (1995). *Transcultural Nursing: Assesment and Intervention*, 2nd Ed. Missouri : Mosby Year Book Inc.
- Leininger M., (1991). *Culture Care Diversity and Universality: A Theory of Nursing*. New York : National League for Nursing Press
- Marriner- Tomey, A.(2006) .Nursing Theorists and Their Work. Third Edition. Philadelphia: Mosby Year – Book,Inc.
- McEwen, Melanie; Wills, Evelyn. (2007). Theoretical Basis for Nursing. 2nd edition. Philadelphia. Lippincot Williams & Wilkins.
- Pearson A., Vaughan B.(1986). *Nursing Models for Practice*. London:
- Poter PA & Perry AG, (1991), Fundamental of Nursing ; Concept, Process and Practice terj 3th Edition, ST Louis CV Mosby Company
- Tomey Ann Marriner, Alligood M.R.(2006). *Nursing Theorists and Their work*. 6 WilliamHeinemann Medical Books.

BAB 4

PROSES KEPERAWATAN PADA INDIVIDU DAN KELOMPOK KHUSUS LANSIA

Capaian pembelajaran

Kognitif

Mahasiswa diharapkan mampu:

- Menjelaskan konsep proses keperawatan pada lansia (pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi, dan evaluasi).
- Menganalisis perubahan biologis, psikologis, sosial, dan spiritual pada lansia.
- Mengidentifikasi kebutuhan dasar lansia sesuai dengan teori kebutuhan (seperti Maslow, Virginia Henderson, dan lain-lain).
- Menjelaskan berbagai masalah kesehatan yang umum terjadi pada lansia.
- Merancang intervensi keperawatan yang sesuai untuk lansia dengan kebutuhan khusus secara individu dan kelompok.
- Mengevaluasi efektivitas intervensi keperawatan terhadap lansia.

Afektif

Mahasiswa diharapkan mampu:

- Menunjukkan empati, kepedulian, dan rasa hormat dalam memberikan asuhan keperawatan kepada lansia.
- Menunjukkan sikap profesional dan etis dalam interaksi dengan lansia dan keluarganya.
- Menghargai keberagaman budaya, nilai, dan kepercayaan lansia dalam praktik keperawatan.
- Berpartisipasi aktif dalam kegiatan promosi kesehatan dan edukasi untuk lansia.
- Menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap kesejahteraan lansia dalam praktik keperawatan.

Psikomotor

Mahasiswa diharapkan mampu:

- Melakukan pengkajian keperawatan secara menyeluruh pada lansia.
- Menyusun diagnosa keperawatan yang tepat berdasarkan data pengkajian lansia.
- Merancang dan mengimplementasikan intervensi keperawatan yang sesuai untuk lansia secara individu dan kelompok.

- Melaksanakan tindakan keperawatan spesifik lansia (misalnya mobilisasi, pemantauan nutrisi, pencegahan jatuh).
- Mendidik lansia dan keluarganya terkait pencegahan penyakit dan peningkatan kualitas hidup.
- Mencatat dan mengevaluasi hasil asuhan keperawatan pada lansia dengan menggunakan dokumentasi yang tepat.

Tujuan Instruksional Umum (TIU)

- Mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan proses keperawatan pada lansia secara individu maupun kelompok dengan pendekatan holistik, sistematis, dan etis.

Tujuan Instruksional Khusus (TIK)

Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa mampu:

- Mengidentifikasi kebutuhan dasar lansia secara individu dan kelompok.
- Melakukan pengkajian keperawatan secara komprehensif pada lansia.
- Menyusun diagnosis keperawatan berdasarkan data yang diperoleh.
- Merencanakan intervensi keperawatan sesuai kebutuhan lansia.
- Melaksanakan asuhan keperawatan yang efektif dan efisien.
- Mengevaluasi hasil tindakan keperawatan.
- Mengembangkan pendekatan keperawatan berbasis komunitas lansia.

Pendahuluan

Lanjut usia (lansia) merupakan kelompok usia yang mengalami berbagai perubahan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual akibat proses penuaan. Seiring bertambahnya usia, individu lansia cenderung rentan terhadap berbagai masalah kesehatan yang bersifat kronis dan degeneratif, seperti hipertensi, diabetes mellitus, osteoarthritis, dan gangguan kognitif. Oleh karena itu, peran perawat sangat penting dalam memberikan asuhan keperawatan yang komprehensif dan berkelanjutan, baik secara individu maupun dalam kelompok khusus lansia.

Proses keperawatan adalah pendekatan sistematis yang digunakan perawat untuk mengidentifikasi, merencanakan, dan mengevaluasi kebutuhan kesehatan pasien. Pada lansia, proses ini harus mempertimbangkan karakteristik khusus usia lanjut, termasuk perubahan dalam respons terhadap penyakit, kemampuan fungsional, dan kebutuhan akan dukungan emosional dan sosial. Dalam pendekatan kelompok, keperawatan pada lansia juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, mendorong aktivitas sosial, serta mencegah isolasi dan depresi yang umum terjadi di usia lanjut.

Dengan pendekatan holistik dan humanistik, proses keperawatan pada individu dan kelompok lansia bertujuan tidak hanya untuk menangani penyakit, tetapi juga untuk mempertahankan dan meningkatkan kemandirian serta kesejahteraan mereka. Melalui asesmen yang tepat, perencanaan yang partisipatif, intervensi yang terarah,

serta evaluasi yang berkelanjutan, perawat dapat memberikan asuhan yang efektif dan bermakna bagi para lansia.

A. Konsep Dasar Proses Keperawatan pada Lansia

1. Definisi proses keperawatan

Proses keperawatan adalah suatu metode sistematis yang digunakan oleh perawat untuk memberikan asuhan keperawatan yang bersifat holistik dan individual kepada klien, termasuk lansia. Proses ini terdiri dari lima langkah utama: (Amzal Mortin Andas, dkk, 2025)

- a. Pengkajian – Pengumpulan data mengenai kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual lansia.
- b. Diagnosa Keperawatan – Identifikasi masalah kesehatan berdasarkan data yang dikumpulkan.
- c. Perencanaan – Menyusun rencana asuhan yang sesuai dengan kebutuhan lansia.
- d. Implementasi – Pelaksanaan intervensi keperawatan yang telah direncanakan.
- e. Evaluasi – Menilai efektivitas intervensi dan menyesuaikan rencana jika diperlukan. (Sunanto, Nurul Laili, 2024)

2. Karakteristik lansia

Lansia (lanjut usia) adalah individu berusia 60 tahun ke atas. Mereka memiliki beberapa karakteristik umum yang perlu dipahami oleh tenaga kesehatan. (Amzal Mortin Andas, dkk (2025)

- a. Fisik
 - 1) Penurunan fungsi organ tubuh (penglihatan, pendengaran, mobilitas.
 - 2) Resiko tinggi terhadap penyakit kronis (hipertensi, diabetes, osteoarthritis)
 - 3) Penurunan daya tahan tubuh
- b. Psikologis
 - 1) Resiko depresi, kesepian, gangguan memori (misalnya demensia)
 - 2) Perubahan peran sosial (pension, kehilangan pasangan).
- c. Sosial
 - 1) Meningkatnya ketergantungan terhadap keluarga atau fasilitas perawatan.
 - 2) Keterbatasan dalam aktifitas sosial dan ekonomi.
- d. Spiritual
 - 1) lebih fokus pada makna hidup, kematian, dan ketenangan batin.

3. Prinsip-prinsip etika dan budaya dalam perawatan lansia

Merawat lansia membutuhkan pendekatan yang tidak hanya ilmiah, tetapi juga etis dan sensitive terhadap budaya. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

- a. Prinsip etika
 - 1) Otonomi: menghormati hak lansia untuk membuat keputusan sendiri.

- 2) Beneficiency (kebaikan): melakukan tindakan yang memberikan manfaat
 - 3) Non malfiency (tidak merugikan): menghindari tindakan yang dapat membahayakan lansia
 - 4) Justice (keadilan): memberikan pelayanan yang adil tanpa deskriminasi.
 - 5) fidelity (kesetiaan): menjaga kepercayaan dan kerahasiaan pasien.
- b. Sensitifitas budaya
- 1) Memahami nilai kepercayaan dan praktik budaya lansia
 - 2) Menghargai adat istiadat dan ritual yang mungkin penting bagi lansia.
 - 3) menyesuaikan komunikasi dan pendekatan sesuai latar belakang budaya.

B. Pengkajian Keperawatan pada lansia (Kurdi Fahrudin. dkk, 2025)

1. Wawancara: pengumpulan Riwayat kesehatan

Faktor-faktor yang mempengaruhi proses wawancara

- a. Kemampuan pewawancara (perawat)
- b. Kondisi klien:
 - 1) Gangguan penglihatan
 - 2) Penurunan pendengaran
 - 3) Ansietas
 - 4) Kelelahan
 - 5) Nyeri
 - 6) Kecendrungan untuk mengenang

2. Komponen utama pengkajian keperawatan pada lansia

- a. Identitas klien
 - 1) nama lengkap
 - 2) Usia (kategori lansia: pra lansia 45-59 tahun, lansia awal 60-74 tahun, lansia lanjut 75-90 tahun, lansia sangat tua >90 tahun)
 - 3) Nama lengkap
 - 4) Jenis kelamin
 - 5) Status pernikahan
 - 6) Agama
 - 7) Pendidikan terakhir
 - 8) Pekerjaan terakhir
 - 9) Sumber pendapatan
- b. Keluhan Utama

Keluhan yang dirasakan saat ini oleh lansia (misalnya nyeri sendi, sesak nafas, sulit tidur, nyeri kronis).

c. Riwayat Kesehatan

- 1) Riwayat Kesehatan Sekarang
 - a) Diagnosa medis (jika ada)
 - b) Pengobatan yang sedang dijalani
 - c) Gejala yang dirasakan
 - d) Pemeriksaan penunjang (lab, rongent, dll)
- 2) Riwayat Kesehatan Masa Lalu
 - a) Penyakit yang pernah diderita
 - b) Riwayat rawat inap
 - c) Opereasi
- 3) Riwayat Kesehatan Keluarga
 - a) Apakah ada riwayat penyakit keturunan (hipertensi, diabetes, jantung, Alzheimer, dll)
- 4) Genogram
- 5) Riwayat pekerjaan
- 6) Riwayat lingkungan hidup
- 7) Riwayat rekreasi
- 8) Sistem pendukung
- 9) Riwayat penggunaan obat
 - a) Obat-obatan rutin
 - b) Obat herbal atau tradisional
 - c) Alergi obat
- 10) Status Kesehatan
- 11) Tinjauan Sistem (Jelaskan tentang kondisi sistem – sistem di bawah ini & bagaimana pemenuhannya)
 - a) Keadaan Umum
 - b) Tingkat Kesadaran
 - c) GCS
 - d) TTV

Meliputi system:

a. Sistem Integumen (Kulit, Rambut, Kuku)

- 1) Perubahan: kulit menjadi kering, keriput, elastisitas menurun, mudah memar.
- 2) Hal yang dikaji:
 - a) Luka tekan
 - b) Luka kronis
 - c) Tanda-tanda infeksi
 - d) Kebersihan diri

- e) Risiko cedera kulit
- b. Sistem Muskuloskeletal
 - 1) Perubahan: penurunan massa otot, osteoporosis, kekakuan sendi.
 - 2) Hal yang dikaji:
 - a) Kemampuan mobilitas
 - b) Nyeri sendi atau otot
 - c) Risiko jatuh
 - d) Kekuatan otot
 - e) Postur tubuh
- c. Sistem Saraf
 - 1) Perubahan: penurunan refleks, koordinasi, memori, dan fungsi kognitif.
 - 2) Hal yang dikaji:
 - a) Status mental (MMSE atau SPMSQ)
 - b) Orientasi waktu/tempat/orang
 - c) Gangguan tidur
 - d) Tremor, pusing
 - e) Risiko demensia/delirium/depresi
- d. Sistem Sensorik
 - 1) Perubahan: penurunan penglihatan, pendengaran, pengecap, penciuman.
 - 2) Hal yang dikaji:
 - a) Penggunaan alat bantu (kacamata, alat bantu dengar)
 - b) Gangguan penglihatan (katarak, glaukoma)
 - c) Tuli atau kesulitan komunikasi
 - d) Risiko isolasi sosial
- e. Sistem Kardiovaskular
 - 1) Perubahan: elastisitas pembuluh darah menurun, denyut jantung lambat.
 - 2) Hal yang dikaji:
 - a) Tekanan darah
 - b) Edema
 - c) Riwayat hipertensi, jantung koroner
 - d) Aktivitas fisik dan toleransinya
 - e) Risiko stroke
- f. Sistem Pernapasan
 - 1) Perubahan: elastisitas paru menurun, kapasitas vital menurun.
 - 2) Hal yang dikaji:
 - a) Pola napas
 - b) Batuk, sesak napas
 - c) Riwayat PPOK/asma

- d) Frekuensi napas
 - e) Saturasi oksigen
- g. Sistem Pencernaan
 - 1) Perubahan: motilitas lambung menurun, gigi tanggal, nafsu makan menurun.
 - 2) Hal yang dikaji:
 - a) Pola makan dan minum
 - b) Berat badan (penurunan atau peningkatan)
 - c) Konstipasi atau diare
 - d) Disfagia (sulit menelan)
 - e) Gizi (malnutrisi)
- h. Sistem Genitourinaria
 - 1) Perubahan: penurunan fungsi ginjal dan kandung kemih, inkontinensia.
 - 2) Hal yang dikaji:
 - a) Frekuensi buang air kecil
 - b) Warna urin, bau, nyeri saat BAK
 - c) Inkontinensia urin/feses
 - d) Riwayat penyakit ginjal atau saluran kemih
- i. Sistem Reproduksi
 - 1) Perubahan: penurunan hormon seks, perubahan fungsi seksual.
 - 2) Hal yang dikaji:
 - a) Perubahan libido
 - b) Keluhan saat hubungan seksual
 - c) Masalah prostat (pada pria)
 - d) Masalah vagina (pada wanita, seperti kekeringan)
- j. Sistem Imun
 - 1) Perubahan: penurunan respon imun, mudah terkena infeksi.
 - 2) Hal yang dikaji:
 - a) Riwayat vaksinasi
 - b) Penyakit autoimun
 - c) Frekuensi infeksi
 - d) Luka yang tidak sembuh
- k. Sistem Endokrin
 - 1) Perubahan: penurunan metabolisme, sensitivitas insulin menurun.
 - 2) Hal yang dikaji:
 - a) Riwayat diabetes, hipotiroid
 - b) Perubahan berat badan
 - c) Tanda-tanda hipoglikemia/hiperglikemia

3. Pengkajian Psikososial, Emosional & Spiritual

a. Psikososial

Kemampuan sosialisasi klien pada saat sekarang, sikap klien pada orang lain, harapan – harapan klien dalam melakukan sosialisasi, kepuasan klien dalam sosialisasi, dll.

b. Identifikasi Masalah Emosional

Pertanyaan Tahap 1

- 1) Apakah klien mengalami sukar tidur?
- 2) Apakah klien sering merasa gelisah?
- 3) Apakah klien sering murung atau menangis sendiri?
- 4) Apakah klien sering was – was atau kuatir?

Lanjutkan ke pertanyaan tahap 2 jika lebih dari atau sama dengan 1 jawaban “Ya”

Pertanyaan Tahap 2

- 1) Keluhan lebih dari 3 bulan atau lebih dari 1 kali dalam 1 bulan?
- 2) Ada masalah atau banyak pikiran?
- 3) Ada gangguan / masalah dengan keluarga lain?
- 4) Menggunakan obat tidur / penenang atau anjuran dokter?
- 5) Cenderung mengurung diri?

Bila lebih dari atau sama dengan 1 jawaban “Ya”: MASALAH EMOSIONAL POSITIF (+)

1) Spiritual

Agama, kegiatan keagamaan, konsep / keyakinan klien tentang kematian, harapan – harapan klien terhadap dirinya, dll.

4. Pengkajian Fungsional Klien / ADL

a. KATZ Indeks:

Tabel 4.1 Pengkajian Fungsional Klien / ADL

1. MANDI (dengan spon, pancuran, atau bak rendam) M : Tidak membutuhkan bantuan (keluar dan masuk ke dalam bak rendam, bila mandi yang dimaksudkan menggunakan sarana tersebut) D : Menerima bantuan saat mandi hanya pada bagian tubuh tertentu (seperti punggung atau tungkai) T : Memerlukan bantuan terhadap lebih dari satu bagian tubuhnya (atau tidak mandi sama sekali)
2. BERPAKAIAN M : Mampu mengambil dan mengenakan pakaian secara lengkap tanpa memerlukan bantuan D : Berpakaian lengkap tanpa memerlukan bantuan kecuali saat menalikan sepatu T : Memerlukan bantuan mengambil dan mengenakan pakaian atau bila

3. TOILETING

M : Mampu pergi ke toilet, membersihkan diri sendiri dan mampu memilih baju tanpa bantuan (mungkin menggunakan objek sebagai penopang seperti tongkat, tongkat kaki tiga, kursi roda. Juga mungkin mampu menggunakan tampungan selama di tempat tidur atau juga pispot yang akan dikosongkan saat pagi hari)

D : Memerlukan bantuan untuk pergi ke toilet, membersihkan diri sendiri atau bahkan dalam memilih atau memperbaiki pakaian yang akan dikenakan, setelah eliminasi baik dengan alat tampung malam hari

4. BERPINDAH

M : Bergerak naik turun dari tempat tidur dan kursi tanpa memerlukan bantuan (mungkin mempergunakan objek penopang seperti tongkat atau walker)

D : Naik turun dari tempat tidur atau kursi dengan bantuan

5. KONTINENSIA

M : Mengendalikan perkemihan dan defekasi secara mandiri sepenuhnya

D : Kadang terjadi "ketaksengajaan"

T : Pengawasan yang diberikan merupakan bantuan dalam mengendalikan perkemihan dan defekasi pasien, dapat menggunakan kateter, atau bahkan terjadi inkontinensia sepenuhnya.

6. MAKAN

M : Menyuap sendiri tanpa bantuan

D : Makan tanpa memerlukan bantuan kecuali pada saat memotong daging atau mengoles roti dengan mentega

T : Memerlukan bantuan saat makan atau makan melalui selang atau cairan

Ket. Singkatan: M, Mandiri; D, Dibantu; T, Tergantung

Termasuk kategori yang manakah klien?

- A. A. Mandiri dalam makan, kontinensia, (BAK & BAB), menggunakan pakaian, pergi ke toilet, berpindah dan mandi
- B. Mandiri semuanya kecuali salah satu saja dari fungsi di atas
- C. Mandiri, kecuali mandi, dan satu fungsi yang lain
- D. Mandiri, kecuali mandi, berpakaian, dan satu fungsi yang lain
- E. Mandiri, kecuali mandi, berpakaian, ke toilet dan satu fungsi yang lain

F. Mandiri, kecuali mandi, berpakaian, ke toilet, berpindah dan satu fungsi yang lain

G. Ketergantungan untuk semua fungsi di atas.

Lain-lain: tergantung pd sedikitnya 2 fungsi tetapi tidak dapat diklasifikasikan pada C, D, E, F

b. Barthel Indeks

Tabel 4.2 Barthel Indeks

Termasuk yang manakah klien ?

NO.	KRITERIA	DENGAN BANTUAN	MANDIRI	KET
1.	Makan	5	10	Frekuensi : Jumlah : Jenis :
2.	Minum	5	10	Frekuensi : Jumlah : Jenis :
3.	Berpindah dari kursi roda tempat tidur, sebaliknya	5 – 10	15	
4.	Personal toilet (cuci muka, menyisir rambut, gosok gigi)	0	5	Frekuensi :
5.	Keluar masuk toilet (mencuci pakaian, menyeka tubuh, menyiram)	5	10	
6.	Mandi		15	Frekuensi :
7.	Jalan dipermukaan datar	5	5	
8.	Naik turun tangga	0	10	
9.	Mengenakan pakaian	5	10	
10.	Kontrol bowel (BAB)	5	10	Frekuensi : Jenis :
11.	Kontrol bladder (BAK)	5	10	Frekuensi : Warna :
12.	Olahraga / latihan	5	10	Frekuensi : Jenis :
13.	Rekreasi / pemanfaatan waktu luang	5	10	Frekuensi : Jenis :

Keterangan

- 130 : Mandiri
- 65 – 125 : Ketergantungan sebagian
- 60 : Ketergantungan total

5. Pengkajian Status Mental Gerontik

- a. Identifikasi fungsi intelektual lansia dengan menggunakan Short Portable Mental Status Questioner (SPMSQ)

Tabel 4.3 (SPMSQ)

BENAR	SALAH	NO	PERTANYAAN	JAWABAN
		1.	Tanggal berapa hari ini ?	
		2.	Hari apa sekarang ?	
		3.	Apa nama tempat ini ?	
		4.	Di mana alamat Anda ?	
		5.	Berapa umur Anda ?	
		6.	Kapan Anda lahir ? (minimal tahun lahir)	
		7.	Siapa Presiden Indonesia sekarang ?	
		8.	Siapa Presiden Indonesia sebelumnya ?	
		9.	Siapa nama ibu Anda?	
		10.	Kurangi 3 dari 20 dan tetap pengurangan 3 dari setiap angka baru, semua secara menurun sampai bilangan terkecil.	

Seri total = Σ

Catatan:

Apabila ada suatu kesulitan dari lansia untuk menjawab setiap pertanyaan, ada beberapa alternatif pertanyaan untuk lansia di antaranya:

- Tanggal dan tahun berapa Indonesia merdeka?
- Sekarang tahun berapa?
- Hari apa sekarang?
- Sekarang jam berapa?
- Sekarang malam, siang, atau pagi?
- Apa nama tempat ini?
- Di mana alamat Anda?
- Lahir di mana?
- Berapa umur Anda?

- Kapan Anda lahir?
- Tahun berapa?
- Zaman pemerintahannya siapa?
- Siapa Presiden Indonesia sekarang?
- Siapa ketua panti sekarang?
- Siapa ketua asrama sekarang?
- Siapa Presiden Indonesia sebelumnya?
- Siapa Presiden Indonesia pertama kali?
- Siapa nama ibu Anda?
- Sebutkan nama anak – anak Anda!

Interpretasi hasil:

Salah 0 – 3 : Fungsi intelektual utuh

Salah 4 – 5 : Kerusakan intelektual ringan

Salah 6 – 8 : Kerusakan intelektual sedang

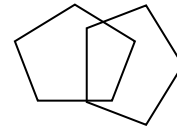
Salah 9 – 10 : Kerusakan intelektual berat

- b. Identifikasi aspek kognitif dari fungsi mental dengan menggunakan MMSE (Mini Mental Status Exam)

Tabel 4.4 Mini Mental Status Exam

Angka Maksimum	<i>Orientasi</i>
5	(Tahun) (musim) (tanggal) (hari) (bulan) apakah ini ?
5	Di (negara bagian) (pedesaan) (kota) (rumah sakit) (wilayah) manakah kita ?
3	<i>Registrasi</i> Namai tiga obyek : satu detik untuk setiap nama, kemudian minta pasien untuk mengulangi setelah Anda menyebutkannya. Beri satu hal untuk setiap jawaban yang benar. Ulangi kembali sampai pasien mengerti ketiga obyek tersebut. Hitung banyaknya pasien mencoba dan masukkan jumlah percobaan tersebut ke dalam rekaman data.
5	<i>Perhatian dan Kalkulasi</i> Mulai dari angka 100 dan hitung mundur setiap kali 7 angka (hentikan setelah jawaban ke lima) Atau sebagai alternatif pengganti, ejaan "dunia" dari belakang ke depan.

3	Mengingat Tanyakanlah ketiga obyek yang telah disebutkan tadi di atas. Bahasa Perlihatkan sebatang pensil serta sebuah jam tangan, dan minta pasien untuk menamai kedua obyek tersebut. 1 Ulangi hal berikut : "Tanpa jika, dan, atau tetapi" 3 Suatu perintah bertahap tiga : "Ambil secarik kertas dengan tangan kanan Anda, lipat menjadi dua, dan letakkan di atas lantai." 1 Baca dan ikuti perintah ini (perlihatkan bahan – bahan tertulis) 1 TUTUP MATA ANDA Tuliskan sebaris kalimat 1 Salin suatu desain (poligon kompleks)
---	--



b.

Interpretasi Hasil

24 – 30 : Tidak ada gangguan kognitif

18 – 23 : Gangguan kognitif sedang

0 – 17 : Gangguan kognitif berat

6. Pengkajian Keseimbangan untuk Klien Lansia (Tinneti, ME dan Ginser, SF, 1998)

Perubahan posisi atau gerakan keseimbangan

a. Bangun dari kursi (dimasukkan dan analisis) kursi yang keras tanpa

Tidak bangun dari duduk dengan satu kali gerakan, tetapi mendorong tubuhnya keatas dengan tangan atau bergerak ke bagian depan kursi terlebih dahulu, tidak stabil pada saat berdiri pertama kali.

b. Duduk ke kursi (dimasukkan dan analisis) kuris yang keras tanpa lengan
Menjatuhkan diri dikursi, tidak duduk ditengah kursi

c. Menahan dorongan pada sternum (pemeriksaan mendorong sternum perlahan – lahan sebanyak 3 kali)

d. Menggerakkan kaki memegang obyek untuk dukungan, kaki tidak menyentuh sisi – sisinya

e. Mata tertutup

Sama sepertia diatas (periksa kepercayaan pasien tentang input penglihatan untuk keseimbangan)

f. Perputaran leher

Menggerakkan kaki, menggenggam obyek untuk dukungan, kaki tidak menyentuh sisi – sisinya, keluhan vertigo, pusing atau keadaan tidak stabil

g. Gerakan menggapai sesuatu

Tidak mampu untuk menggapai sesuatu dengan bahu fleksi sepenuhnya sementara berdiri pada ujung – ujung jari kanan kiri, tidak stabil, memegang sesuatu untuk dukungan

h. Membungkuk

Tidak mampu untuk membungkuk untuk mengambil obyek – obyek kecil (misalnya pulpen) dari lantai, memegang suatu obyek untuk bisa berdiri lagi, memerlukan usaha – usaha multiple untuk bangun

Komponen gaya berjalan atau gerakan

a. Meminta klien untuk berjalan ke tempat yang ditentukan ragu – ragu, tersandung memegang obyek untuk dukungan

b. Ketinggian langkah kaki (mengangkat kaki pada saat melangkah)

Kaki tidak naik dari lantai secara konsisten (menggeser atau menyeret kaki), mengangkat kaki terlalu tinggi (>2 inchi)

c. Kontinuitas langkah kaki (lebih baik diobservasi dari samping pasien)

Setelah langkah – langkah awal, tidak konsisten memulai mengangkat satu kaki sementara kaki yang lain menyentuh lantai

d. Kesimetrisan langkah (lebih baik diobservasi dari samping pasien)

Panjangnya langkah yang tidak sama (sisi yang patologis biasanya memiliki langkah yang lebih panjang, masalah terdapat pada pinggul, lutut, pergelangan kaki atau otot – otot disekitarnya)

e. Penyimpangan jalur pada saat berjalan (lebih baik diobservasi dari belakang pasien) Tidak berjalan dalam garis lurus, bergelombang dari sisi ke sisi

f. Berbalik

Berhenti sebelum mulai berbalik, jalan sempoyongan, bergoyang, memegang obyek untuk dukungan

Mengidentifikasi Tingkat Depresi Pada Lansia

Tabel 4.5 Inventaris Depresi Beck

Skore	Uraian
A. Kesedihan	
3	Saya sangat sedih / tidak bahagia dimana saya tak dapat menghadapinya
2	Saya galau / sedih sepanjang waktu dan saya tidak dapat keluar darinya

1	Saya merasa sedih atau galau
0	Saya tidak merasa sedih
B. Pesimisme	
3	Saya merasa bahwa masa depan adalah sia-sia dan sesuatu tidak dapat membaik
2	Saya merasa tidak mempunyai apa-apa untuk memandang ke depan
1	Saya merasa tidak berkecil hati mengenai masa depan
0	Saya tidak begitu pesimis atau kecewa tentang masa depan
C. Rasa kegagalan	
3	Saya merasa benar-benar gagal sebagai orang tua (suami / istri)
2	Bila melihat kehidupan ke belakang, semua yang dapat saya lihat hanya kegagalan
1	Saya merasa gagal melebihi orang pada umumnya.
0	Saya merasa tidak gagal
D. Ketidakpuasan	
3	Saya tidak puas dengan segalanya
2	Saya tidak lagi mendapatkan kepuasan dari apapun
1	Saya tidak menyukai cara yang saya gunakan
0	Saya tidak merasa tidak puas
E. Rasa bersalah	
3	Saya merasa seolah-olah sangat buruk atau tak berharga
2	Saya merasa sangat bersalah
1	Saya merasa buruk / tak berharga sebagai bagian dari waktu yang baik
0	Saya tidak merasa benar-benar bersalah
F. Tidak menyukai diri sendiri	
3	Saya benci diri saya sendiri
2	Saya muak dengan diri saya sendiri
1	Saya tidak suka dengan diri saya sendiri
0	Saya tidak merasa kecewa dengan diri saya sendiri
G. Membahayakan Diri Sendiri	
3	Saya akan membunuh diri saya sendiri jika saya mempunyai kesempatan
2	Saya mempunyai rencana pasti tentang tujuan bunuh diri
1	Saya merasa lebih baik mati
0	Saya tidak kehilangan minat pada orang lain
H. Menarik Diri dari Sosial	
3	Saya telah kehilangan semua minat saya pada orang lain dan tidak peduli pada mereka semuanya.

2	Saya telah kehilangan semua minat saya pada orang lain dan mempunyai sedikit perasaan pada mereka.
1	Saya kurang berminat pada orang lain daripada sebelumnya
0	Saya tidak kehilangan minat kepada orang lain.
I. Keragu-raguan	
3	Saya tidak dapat membuat keputusan sama sekali
2	Saya tidak mempunyai banyak kesulitan dalam membuat keputusan
1	Saya berusaha mengambil keputusan
0	Saya membuat keputusan yang baik
J. perubahan gambaran diri	
3	Saya merasa saya jelek atau tampak menjijikan
2	Saya merasa ada perubahan-perubahan yang permanen dalam penampilan saya ini dan membuat saya tak menarik
1	Saya khawatir bahwa saya tampak tua atau tak menarik
0	Saya tidak merasa bahwa saya tampak lebih buruk daripada sebelumnya
K. Kesulitan kerja	
3	Saya tidak melakukan pekerjaan sama sekali
2	Saya telah mendorong diri saya sendiri dengan keras untuk melakukan sesuatu
1	Saya memerlukan tambahan untuk mulai melakukan sesuatu
0	Saya dapat bekerja kira-kira sebaik sebelumnya.
L. Keletihan	
3	Saya sangat lelah untuk melakukan sesuatu
2	Saya merasa lelah untuk melakukan sesuatu
1	Saya merasa lelah lebih dari biasanya
0	Saya tidak merasa lelah lebih dari biasanya
M. Anoreksia	
3	Saya tidak lagi mempunyai nafsu makan sekali
2	Nafsu makan saya sangat memburuk sekarang
1	Nafsu makan saya tidak sebaik sebelumnya
0	Nafsu makan saya tidak buruk dari biasanya
0-4	Depresi tidak ada atau minimal
5-7	Depresi ringan
8-15	Depresi sedang
16+	Depresi berat
<i>Dari beck AT, Beck RW : Screening depressed patient in family practice (1972)</i>	

Apgar Keluarga Dengan Lansia

Tabel 4.6 (Suatu Alat Yang Dapat Digunakan Untuk Mengkaji Fungsional Sosial Lansia)

No	Uraian	Fungsi	Skore
1	Saya puas, saya dapat kembali pada keluarga (teman – teman) saya untuk membantu pada waktu sesuatu menyusahkan saya	Adaption	
2	Saya puas dengan cara keluarga (teman – teman) saya membicarakan sesuatu dengan saya dan menggunakan masalah dengan saya	Partnership	
3	Saya puas bahwa keluarga (teman – teman) saya menerima dan mendukung keinginan saya untuk melakukan aktifitas atau arah baru	Growth	
4	Saya puas dengan cara keluarga (teman – teman) saya mengekspresikan efek atau berespon terhadap emosi – emosi saya seperti marah, sedih atau mencintai	Affection	
5	Saya puas dengan teman – teman saya dan saya menyediakan waktu bersama – sama	Resolve	
	Penilaian : Pertanyaan – pertanyaan yang dijawab : 1. Selalu : skore 2 2. Kadang – kadang : skore 1 3. Hampir tidak pernah : skore 0	Total	

Skala Nyeri Obyektif

**Tabel 4.7 (Diadopsi pada PAINAD
(Pain Assesment in Advanced Dementia Scale))**

ITEM	0	1	2	Skore
Bernafas	Normal	Kadang sulit bernafas Periode hiperventilasi singkat	Nafas sulit & berbunyi / Periode hiperventilasi panjang / pernafasan Cheyne Stokes	

Vokalisasi negatif	Tidak ada	Kadang mengerang / pembicaraan terbatas pada ketidaksetujuan	Kesulitan memanggil / meraung keras / menangis	
Ekspresi fasial	Senyum / tiada ekspresi	Sedih / takut / mengernyit	Grimas / meringis	
Bahasa tubuh	Rileks	Tegang / distressed pacing / fidgeting	Badan kaku / tangan mengepal / lutut ditarik / menendang – nendang	
Consolability	Tidak perlu ditenangkan	Bisa ditenangkan dengan suara atau sentuhan	Tidak bisa ditenangkan	
Skore total				

Pengkajian Resiko Jatuh

Tabel 4.8 (Morse Fall Scale)

VARIABEL		SKOR	SKOR KX
Riwayat jatuh	Tidak ada	0	
	ada	25	
Diagnosis sekunder	Tidak ada	0	
	Ada	15	
Alat bantu gerak	Tidak ada / tirah baring / berdiri dengan bantuan total	0	
	Kruk / tongkat / walker	15	
	furniture	30	
Infus	Tidak ada	0	
	Ada	20	
Gait / langkah	Normal / tirah baring / kursi roda	0	
	Lemah	10	
	Terganggu / tidak mampu	20	
Status mental	Tahu keterbatasan diri	0	
	Tidak Tahu keterbatasan diri	15	
Skor Total			

Kriteria skor total ≥ 50 : resiko jatuh +

Skrining Status Nutrisi

Tabel 4.9 Diadopsi Dari Mini Nutritional Assessment-Nestle Nutrition Institute

VARIABEL		SKOR	SKOR KX
Apakah asupan makanan dalam 3 bulan terakhir ini berkurang karena kehilangan nafsu makan atau masalah dalam mengunyah, menelan atau mencerna makanan?	Sangat berkurang	0	
	Agak berkurang	1	
	Tidak berkurang	2	
Adakah penurunan BB 3 bulan terakhir?	>3 kg	0	
	Tidak tahu	1	
	1-3 kg	2	
	Tidak ada	3	
Mobilitas	Hanya di tempat tidur/kursi	0	
	Bisa bangkit dari tempat tidur/kursi tapi tidak keluar rumah	1	
	Bisa keluar rumah	2	
Mengalami stress psikologis atau penyakit akut dalam 3 bulan terakhir	Ya	0	
	Tidak	2	
Body mass indeks	< 19	0	
	19 - < 21	1	
	21 - < 23	2	
	≥ 23	3	
Skor total	11		

C. Diagnosa keperawatan

Berikut adalah beberapa diagnosa keperawatan (PPNI, 2017):

1. Risiko jatuh (D.00155)

- a. Definisi: Risiko peningkatan kejadian jatuh yang dapat menyebabkan cedera.
- b. Indikator: Keseimbangan menurun, kekuatan otot melemah, gangguan mobilitas, penggunaan alat bantu jalan.

2. Gangguan mobilitas fisik (D.0054)

- a. Definisi: Keterbatasan dalam gerak fisik secara mandiri.
- b. Indikator: Kelemahan otot, penurunan kekuatan, gangguan koordinasi, nyeri saat bergerak.

3. Defisit perawatan diri (mandi, berpakaian, makan, eliminasi) (D0109)

- a. Definisi: Ketidakmampuan melakukan aktivitas perawatan diri tanpa bantuan.
- b. Indikator: Tidak mampu mandi, berpakaian, makan, atau ke toilet secara mandiri.

4. Gangguan pola tidur (D0055)

- a. Definisi: Perubahan kuantitas dan kualitas pola tidur yang tidak memuaskan.
- b. Indikator: Sering terbangun di malam hari, sulit tidur kembali, tidur siang berlebihan.

5. Risiko nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh (D0032)

- a. Definisi: Risiko asupan nutrisi yang tidak adekuat untuk memenuhi kebutuhan metabolik.
- b. Indikator: Penurunan nafsu makan, berat badan turun, masalah mengunyah/menelan.

6. Isolasi sosial (D0121)

- a. Definisi: Perasaan kesepian akibat berkurangnya interaksi sosial.
- b. Indikator: Menarik diri, tidak aktif dalam kegiatan sosial, ekspresi sedih/sepi.

7. Gangguan memori (D.0062)

- a. Definisi: Penurunan kemampuan mengingat informasi jangka pendek maupun jangka panjang.
- b. Indikator: Lupa nama orang terdekat, lupa waktu, lupa lokasi, kebingungan.

8. Risiko kekerasan (dari orang lain atau diri sendiri) (D.0146)

- a. Definisi: Risiko mengalami tindakan kekerasan secara fisik, emosional, atau finansial.
- b. Indikator: Luka yang tidak wajar, ketakutan terhadap pengasuh, penarikan diri.

9. Ansietas (D.0080)

- a. Definisi: Perasaan cemas berlebihan terhadap kondisi kesehatan atau masa depan.

- b. Indikator: Gelisah, sulit tidur, detak jantung meningkat, sering mengeluh khawatir.

10. Koping individu tidak efektif (D.0096)

- a. Definisi: Ketidakmampuan mengelola stres atau perubahan secara adaptif.
- b. Indikator: Mengeluh tidak mampu mengatasi situasi, marah, menarik diri, menangis.

D. Intervensi dan Implementasi

Berikut adalah intervensi dan implementasi keperawatan pada pasien dengan gangguan eliminasi akibat patologis sistem pencernaan dan perkemihan berdasarkan Tim POKJA SIKI PPNI (2018):

1. Resiko jatuh

Intervensi utama: Pencegahan jatuh (I.14540)

Observasi

- a. Identifikasi faktor jatuh (mis: usia > 65 tahun, penurunan tingkat kesadaran, defisit kognitif, hipotensi ortostatik, gangguan keseimbangan, gangguan penglihatan, neuropati)
- b. Identifikasi risiko jatuh setidaknya sekali setiap shift atau sesuai dengan kebijakan institusi
- c. Identifikasi faktor lingkungan yang meningkatkan risiko jatuh (mis: lantai licin, penerangan kurang)
- d. Hitung risiko jatuh dengan menggunakan skala (mis: fall morse scale, humpty dumpty scale), jika perlu
- e. Monitor kemampuan berpindah dari tempat tidur ke kursi roda dan sebaliknya

Terapeutik

- a. Orientasikan ruangan pada pasien dan keluarga
- b. Pastikan roda tempat tidur dan kursi roda selalu dalam kondisi terkunci
- c. Pasang handrail tempat tidur
- d. Atur tempat tidur mekanis pada posisi terendah
- e. Tempatkan pasien berisiko tinggi jatuh dekat dengan pantauan perawat dari nurse station
- f. Gunakan alat bantu berjalan (mis: kursi roda, walker)
- g. Dekatkan bel pemanggil dalam jangkauan pasien

Edukasi

- a. Anjurkan memanggil perawat jika membutuhkan bantuan untuk berpindah
- b. Anjurkan menggunakan alas kaki yang tidak licin
- c. Anjurkan berkonsentrasi untuk menjaga keseimbangan tubuh

- d. Anjurkan melebarkan jarak kedua kaki untuk meningkatkan keseimbangan saat berdiri
- e. Ajarkan cara menggunakan bel pemanggil untuk memanggil perawat

2. Gangguan mobilitas fisik

Intervensi utama:

Dukungan ambulasi (I.06171).

Memfasilitasi pasien untuk meningkatkan aktivitas berpindah.

Observasi

- a. Identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya
- b. Identifikasi toleransi fisik melakukan ambulasi
- c. Monitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum memulai ambulasi
- d. Monitor kondisi umum selama melakukan ambulasi

Terapeutik

- a. Fasilitasi aktivitas ambulasi dengan alat bantu (mis: tongkat, kruk)
- b. Fasilitasi melakukan mobilisasi fisik, jika perlu
- c. Libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan ambulasi

Edukasi

- a. Jelaskan tujuan dan prosedur ambulasi
- b. Anjurkan melakukan ambulasi dini
- c. Ajarkan ambulasi sederhana yang harus dilakukan (mis: berjalan dari tempat tidur ke kursi roda, berjalan dari tempat tidur ke kamar mandi, berjalan sesuai toleransi)

Dukungan mobilisasi d (I.05173).

Dukungan mobilisasi adalah intervensi yang dilakukan oleh perawat dalam memfasilitasi pasien untuk meningkatkan aktivitas pergerakan fisik.

Observasi

- a. Identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya
- b. Identifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan
- c. Monitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum memulai mobilisasi
- d. Monitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi

Terapeutik

- a. Fasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu (mis: pagar tempat tidur)
- b. Fasilitasi melakukan pergerakan, jika perlu
- c. Libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan

Edukasi

- a. Jelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi
- b. Anjurkan melakukan mobilisasi dini

- c. Ajarkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan (mis: duduk di tempat tidur, duduk di sisi tempat tidur, pindah dari tempat tidur ke kursi)

3. Defisit perawatan diri (mandi, berpakaian, makan, eliminasi)

Intervensi utama:

Dukungan perawatan diri (I.11348).

Dukungan perawatan diri adalah intervensi yang dilakukan oleh perawat untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan perawatan diri.

Observasi

- a. Identifikasi kebiasaan aktivitas perawatan diri sesuai usia
- b. Monitor tingkat kemandirian
- c. Identifikasi kebutuhan alat bantu kebersihan diri, berpakaian, berhias, dan makan

Terapeutik

- a. Sediakan lingkungan yang terapeutik (mis: suasana hangat, rileks, privasi)
- b. Siapkan keperluan pribadi (mis: parfum sikat gigi, dan sabun mandi)
- c. Dampingi dalam melakukan perawatan diri sampai mandiri
- d. Fasilitasi untuk menerima keadaan ketergantungan
- e. Fasilitasi kemandirian, bantu jika tidak mampu melakukan perawatan diri
- f. Jadwalkan rutinitas perawatan diri

Edukasi

Anjurkan melakukan perawatan diri secara konsisten sesuai kemampuan

4. Gangguan pola tidur

Intervensi Utama;

Dukungan tidur (I.05174).

Dukungan tidur adalah intervensi yang dilakukan oleh perawat untuk memfasilitasi siklus tidur dan terjaga yang teratur.

Observasi

- a. Identifikasi pola aktivitas dan tidur
- b. Identifikasi faktor pengganggu tidur (fisik dan/atau psikologis)
- c. Identifikasi makanan dan minuman yang mengganggu tidur (mis: kopi, teh, alcohol, makan mendekati waktu tidur, minum banyak air sebelum tidur)
- d. Identifikasi obat tidur yang dikonsumsi

Terapeutik

- a. Modifikasi lingkungan (mis: pencahayaan, kebisingan, suhu, matras, dan tempat tidur)
- b. Batasi waktu tidur siang, jika perlu
- c. Fasilitasi menghilangkan stress sebelum tidur
- d. Tetapkan jadwal tidur rutin

- e. Lakukan prosedur untuk meningkatkan kenyamanan (mis: pijat, pengaturan posisi, terapi akupresur)
- f. Sesuaikan jadwal pemberian obat dan/atau Tindakan untuk menunjang siklus tidur-terjaga

Edukasi

- a. Jelaskan pentingnya tidur cukup selama sakit
- b. Anjurkan menepati kebiasaan waktu tidur
- c. Anjurkan menghindari makanan/minuman yang mengganggu tidur

5. Resiko nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh

Intervensi utama:

Manajemen gangguan makan (I.03111).

Manajemen gangguan makan adalah intervensi yang dilakukan oleh perawat untuk mengidentifikasi dan mengelola diet yang buruk, olahraga yang berlebihan dan/atau pengeluaran makanan dan cairan yang berlebihan.

Observasi

- a. Monitor asupan dan keluarnya makanan dan cairan serta kebutuhan kalori

Terapeutik

- a. Timbang berat badan secara rutin
- b. Diskusikan perilaku makan dan jumlah aktivitas fisik (termasuk olahraga) yang sesuai
- c. Lakukan kontrak perilaku (mis: target berat badan, tanggungjawab perilaku)
- d. Dampingi ke kamar mandi untuk pengamatan perilaku memuntahkan Kembali makanan
- e. Berikan penguatan positif terhadap keberhasilan target dan perubahan perilaku
- f. Berikan konsekuensi jika tidak mencapai target sesuai kontrak
- g. Rencanakan program pengobatan untuk perawatan di rumah (mis: medis, konseling)

Edukasi

- a. Anjurkan membuat catatan harian tentang perasaan dan situasi pemicu pengeluaran makanan (mis: pengeluaran yang disengaja, muntah, aktivitas berlebihan)
- b. Ajarkan pengaturan diet yang tepat
- c. Ajarkan keterampilan koping untuk penyelesaian masalah perilaku makan

Kolaborasi

- a. Kolaborasi dengan ahli gizi tentang target berat badan, kebutuhan kalori dan pilihan makanan

Manajemen nutrisi (I.03119).

Manajemen nutrisi adalah intervensi yang dilakukan oleh perawat untuk mengidentifikasi dan mengelola asupan nutrisi yang seimbang.

Observasi

- a. Identifikasi status nutrisi
- b. Identifikasi alergi dan intoleransi makanan
- c. Identifikasi makanan yang disukai
- d. Identifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutrisi
- e. Identifikasi perlunya penggunaan selang nasogastrik
- f. Monitor asupan makanan
- g. Monitor berat badan
- h. Monitor hasil pemeriksaan laboratorium

Terapeutik

- a. Lakukan oral hygiene sebelum makan, jika perlu
- b. Fasilitasi menentukan pedoman diet (mis: piramida makanan)
- c. Sajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai
- d. Berikan makanan tinggi serat untuk mencegah konstipasi
- e. Berikan makanan tinggi kalori dan tinggi protein
- f. Berikan suplemen makanan, jika perlu
- g. Hentikan pemberian makan melalui selang nasogastrik jika asupan oral dapat ditoleransi

Edukasi

- a. Ajarkan posisi duduk, jika mampu
- b. Ajarkan diet yang diprogramkan

Kolaborasi

- a. Kolaborasi pemberian medikasi sebelum makan (mis: Pereda nyeri, antiemetik), jika perlu
- b. Kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrisi yang dibutuhkan, jika perlu
- d. Anjurkan penggunaan obat tidur yang tidak mengandung supresor terhadap tidur REM
- e. Ajarkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap gangguan pola tidur (mis: psikologis, gaya hidup, sering berubah shift bekerja)
- f. Ajarkan relaksasi otot autogenik atau cara nonfarmakologi lainnya

6. Isolasi sosial

Intervensi utama

Promosi sosialisasi (I.13498).

Promosi sosialisasi adalah intervensi yang dilakukan oleh perawat untuk meningkatkan kemampuan pasien untuk berinteraksi dengan orang lain.

Observasi

- a. Identifikasi kemampuan melakukan interaksi dengan orang lain
- b. Identifikasi hambatan melakukan interaksi dengan orang lain

Terapeutik

- a. Motivasi meningkatkan keterlibatan dalam suatu hubungan
- b. Motivasi kesabaran dalam mengembangkan suatu hubungan
- c. Motivasi berpartisipasi dalam aktivitas baru dan kegiatan kelompok
- d. Motivasi berinteraksi di luar lingkungan (mis: jalan-jalan, ke toko buku)
- e. Diskusikan kekuatan dan keterbatasan dalam berkomunikasi dengan orang lain
- f. Diskusikan perencanaan kegiatan di masa depan
- g. Berikan umpan balik positif dalam perawatan diri
- h. Berikan umpan balik positif pada setiap peningkatan kemampuan

Edukasi

- a. Anjurkan berinteraksi dengan orang lain secara bertahap
- b. Anjurkan ikut serta kegiatan sosial dan kemasyarakatan
- c. Anjurkan berbagi pengalaman dengan orang lain
- d. Anjurkan meningkatkan kejujuran diri dan menghormati hak orang lain
- e. Anjurkan penggunaan alat bantu (mis: kacamata dan alat bantu dengar)
- f. Anjurkan membuat perencanaan kelompok kecil untuk kegiatan khusus
- g. Latih bermain peran untuk meningkatkan keterampilan komunikasi
- h. Latih mengekspresikan marah dengan tepat

Terapi aktivitas (I.01026).

Terapi aktivitas adalah intervensi yang dilakukan oleh perawat dalam menggunakan aktivitas fisik, kognitif, sosial, dan spiritual tertentu untuk memulihkan keterlibatan, frekuensi, atau durasi aktivitas individu atau kelompok.

Observasi

- a. Identifikasi defisit tingkat aktivitas
- b. Identifikasi kemampuan berpartisipasi dalam aktivitas tertentu
- c. Identifikasi sumber daya untuk aktivitas yang diinginkan
- d. Identifikasi strategi meningkatkan partisipasi dalam aktivitas
- e. Identifikasi makna aktivitas rutin (mis: bekerja) dan waktu luang
- f. Monitor respons emosional, fisik, sosial, dan spiritual terhadap aktivitas

Terapeutik

- a. Fasilitasi fokus pada kemampuan, bukan defisit yang dialami
- b. Sepakati komitmen untuk meningkatkan frekuensi dan rentang aktivitas
- c. Fasilitasi memilih aktivitas dan tetapkan tujuan aktivitas yang konsisten sesuai kemampuan fisik, psikologis, dan sosial

- d. Koordinasikan pemilihan aktivitas sesuai usia
- e. Fasilitasi makna aktivitas yang dipilih
- f. Fasilitasi transportasi untuk menghadiri aktivitas, jika sesuai
- g. Fasilitasi pasien dan keluarga dalam menyesuaikan lingkungan untuk mengakomodasi aktivitas yang dipilih
- h. Fasilitasi aktivitas rutin (mis: ambulasi, mobilisasi, dan perawatan diri), sesuai kebutuhan
- i. Fasilitasi aktivitas pengganti saat mengalami keterbatasan waktu, energi, atau gerak
- j. Fasilitasi aktivitas motorik kasar untuk pasien hiperaktif
- k. Tingkatkan aktivitas fisik untuk memelihara berat badan, jika sesuai
- l. Fasilitasi aktivitas motorik untuk merelaksasi otot
- m. Fasilitasi aktivitas dengan komponen memori implisit dan emosional (mis: kegiatan keagamaan khusus) untuk pasien demensia, jika sesuai
- n. Libatkan dalam permainan kelompok yang tidak kompetitif, terstruktur, dan aktif
- o. Tingkatkan keterlibatan dalam aktivitas rekreasi dan diversifikasi untuk menurunkan kecemasan (mis: vocal group, bola voli, tenis meja, jogging, berenang, tugas sederhana, permainan sederhana, tugas rutin, tugas rumah tangga, perawatan diri, dan teka-teki dan kartu)
- p. Libatkan keluarga dalam aktivitas, jika perlu
- q. Fasilitasi mengembangkan motivasi dan penguatan diri
- r. Fasilitasi pasien dan keluarga memantau kemajuannya sendiri untuk mencapai tujuan
- s. Jadwalkan aktivitas dalam rutinitas sehari-hari
- t. Berikan penguatan positif atas partisipasi dalam aktivitas

Edukasi

- a. Jelaskan metode aktivitas fisik sehari-hari, jika perlu
- b. Ajarkan cara melakukan aktivitas yang dipilih
- c. Anjurkan melakukan aktivitas fisik, sosial, spiritual, dan kognitif dalam menjaga fungsi dan Kesehatan
- d. Anjurkan terlibat dalam aktivitas kelompok atau terapi, jika sesuai
- e. Anjurkan keluarga untuk memberi penguatan positif atas partisipasi dalam aktivitas

Kolaborasi

- a. Kolaborasi dengan terapis okupasi dalam merencanakan dan memonitor program aktivitas, jika sesuai
- b. Rujuk pada pusat atau program aktivitas komunitas, jika perlu

7. Gangguan memory

Intervensi utama

Latihan memori (I.06188).

Latihan memori menurut SIKI adalah intervensi yang dilakukan untuk mengajarkan pasien suatu kemampuan untuk meningkatkan daya ingat.

Observasi

- a. Identifikasi masalah memori yang dialami
- b. Identifikasi kesalahan terhadap orientasi
- c. Monitor perilaku dan perubahan memori selama terapi

Terapeutik

- a. Rencanakan metode mengajar sesuai kemampuan pasien
- b. Stimulasi memori dengan mengulang pikiran yang terakhir kali diucapkan, jika perlu
- c. Koreksi kesalahan orientasi
- d. Fasilitasi mengingat Kembali pengalaman masa lalu, jika perlu
- e. Fasilitasi tugas pembelajaran (mis: mengingat informasi verbal dan gambar)
- f. Fasilitasi kemampuan konsentrasi (mis: bermain kartu pasangan), jika perlu
- g. Stimulasi menggunakan memori pada peristiwa yang baru terjadi (mis: bertanya ke mana saja ia pergi akhir-akhir ini), jika perlu

Edukasi

- a. Jelaskan tujuan dan prosedur Latihan
- b. Ajarkan Teknik memori yang tepat (mis: imajinasi visual, perangkat mnemonic, permainan memori, isyarat memori, Teknik asosiasi, membuat daftar, computer, papan nama)

Kolaborasi

- a. Rujuk pada terapi okupasi, jika perlu

Orientasi (I.09297).

Orientasi realita adalah intervensi yang dilakukan oleh perawat untuk meningkatkan kesadaran terhadap identitas diri, waktu, dan lingkungan.

Observasi

- a. Monitor perubahan orientasi
- b. Monitor perubahan kognitif dan perilaku

Terapeutik

- a. Perkenalkan nama saat memulai interaksi
- b. Orientasikan orang, tempat, dan waktu
- c. Hadirkan realita (mis: beri penjelasan alternatif, hindari perdebatan)
- d. Sediakan lingkungan dan rutinitas secara konsisten

- e. Atur stimulus sensorik dan lingkungan (mis: kunjungan, pemandangan, suara, pencahayaan, bau, dan sentuhan)
- f. Gunakan simbol dalam mengorientasikan lingkungan (mis: tanda, gambar, warna)
- g. Libatkan dalam terapi kelompok orientasi
- h. Berikan waktu istirahat dan tidur yang cukup, sesuai kebutuhan
- i. Fasilitasi akses informasi (mis: televisi, surat kabar, radio), jika perlu

Edukasi

- a. Anjurkan perawatan diri secara mandiri
- b. Anjurkan penggunaan alat bantu (mis: kacamata, alat bantu dengar, gigi palsu)
- c. Ajarkan keluarga dalam perawatan orientasi lansia

8. Risiko kekerasan (dari orang lain atau diri sendiri)

Intervensi Utama

Pencegahan perilaku kekerasan (I.14544).

Pencegahan perilaku kekerasan adalah intervensi yang dilakukan oleh perawat untuk mengidentifikasi dan menurunkan meminimalkan kemarahan pasien yang diekspresikan secara berlebihan dan tidak terkendali secara verbal sampai dengan mencederai orang lain dan/atau merusak lingkungan.

Observasi

- a. Monitor adanya benda yang berpotensi membahayakan (mis: benda tajam, tali)
- b. Monitor keamanan barang yang dibawa oleh pengunjung
- c. Monitor selama penggunaan barang yang dapat membahayakan (mis: pisau cukur)

Terapeutik

- a. Pertahankan lingkungan bebas dari bahaya secara rutin
- b. Libatkan keluarga dalam perawatan

Edukasi

- a. Anjurkan pengunjung dan keluarga untuk mendukung keselamatan pasien
- b. Latih cara mengungkapkan perasaan secara asertif
- c. Latih mengurangi kemarahan secara verbal dan nonverbal (mis: relaksasi, bercerita)

Promosi koping (I.09312).

Promosi koping adalah intervensi yang dilakukan oleh perawat untuk meningkatkan upaya kognitif dan perilaku untuk menilai dan merespon stresor dan/atau kemampuan menggunakan sumber-sumber yang ada.

Observasi

- a. Identifikasi kegiatan jangka pendek dan Panjang sesuai tujuan

- b. Identifikasi kemampuan yang dimiliki
- c. Identifikasi sumber daya yang tersedia untuk memenuhi tujuan
- d. Identifikasi pemahaman proses penyakit
- e. Identifikasi dampak situasi terhadap peran dan hubungan
- f. Identifikasi metode penyelesaian masalah
- g. Identifikasi kebutuhan dan keinginan terhadap dukungan sosial

Terapeutik

- a. Diskusikan perubahan peran yang dialami
- b. Gunakan pendekatan yang tenang dan meyakinkan
- c. Diskusikan alasan mengkritik diri sendiri
- d. Diskusikan untuk mengklarifikasi kesalahpahaman dan mengevaluasi perilaku sendiri
- e. Diskusikan konsekuensi tidak menggunakan rasa bersalah dan rasa malu
- f. Diskusikan risiko yang menimbulkan bahaya pada diri sendiri
- g. Fasilitasi dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan
- h. Berikan pilihan realistis mengenai aspek-aspek tertentu dalam perawatan
- i. Motivasi untuk menentukan harapan yang realistis
- j. Tinjau Kembali kemampuan dalam pengambilan keputusan
- k. Hindari mengambil keputusan saat pasien berada dibawah tekanan
- l. Motivasi terlibat dalam kegiatan sosial
- m. Motivasi mengidentifikasi sistem pendukung yang tersedia
- n. Dampingi saat berduka (mis: penyakit kronis, kecacatan)
- o. Perkenalkan dengan orang atau kelompok yang berhasil mengalami pengalaman sama
- p. Dukung penggunaan mekanisme pertahanan yang tepat
- q. Kurangi rangsangan lingkungan yang mengancam

Edukasi

- a. Anjurkan menjalin hubungan yang memiliki kepentingan dan tujuan sama
- b. Anjurkan penggunaan sumber spiritual, jika perlu
- c. Anjurkan mengungkapkan perasaan dan persepsi
- d. Anjurkan keluarga terlibat
- e. Anjurkan membuat tujuan yang lebih spesifik
- f. Ajarkan cara memecahkan masalah secara konstruktif
- g. Latih penggunaan Teknik relaksasi
- h. Latih keterampilan sosial, sesuai kebutuhan
- i. Latih mengembangkan penilaian obyektif

9. Ansietas

Intervensi utama:

Reduksi ansietas (I.09314).

Reduksi ansietas adalah intervensi yang dilakukan oleh perawat untuk meminimalkan kondisi individu dan pengalaman subyektif terhadap objek yang tidak jelas dan spesifik akibatantisipasi bahaya yang memungkinkan individu melakukan Tindakan untuk menghadapi ancaman.

Observasi

- a. Identifikasi saat tingkat ansietas berubah (mis: kondisi, waktu, stresor)
- b. Identifikasi kemampuan mengambil keputusan
- c. Monitor tanda-tanda ansietas (verbal dan nonverbal)

Terapeutik

- a. Ciptakan suasana terapeutik untuk menumbuhkan kepercayaan
- b. Temani pasien untuk mengurangi kecemasan, jika memungkinkan
- c. Pahami situasi yang membuat ansietas
- d. Dengarkan dengan penuh perhatian
- e. Gunakan pendekatan yang tenang dan meyakinkan
- f. Tempatkan barang pribadi yang memberikan kenyamanan
- g. Motivasi mengidentifikasi situasi yang memicu kecemasan
- h. Diskusikan perencanaan realistis tentang peristiwa yang akan datang

Edukasi

- a. Jelaskan prosedur, termasuk sensasi yang mungkin dialami
- b. Informasikan secara faktual mengenai diagnosis, pengobatan, dan prognosis
- c. Anjurkan keluarga untuk tetap Bersama pasien, jika perlu
- d. Anjurkan melakukan kegiatan yang tidak kompetitif, sesuai kebutuhan
- e. Anjurkan mengungkapkan perasaan dan persepsi
- f. Latih kegiatan pengalihan untuk mengurangi ketegangan
- g. Latih penggunaan mekanisme pertahanan diri yang tepat
- h. Latih Teknik relaksasi

Kolaborasi

- a. Kolaborasi pemberian obat antiansietas, jika perlu

Terapi relaksasi (I.09326).

Terapi relaksasi adalah intervensi yang dilakukan oleh perawat untuk menggunakan teknik peregangan untuk mengurangi tanda dan gejala ketidaknyamanan seperti nyeri, ketegangan otot, atau kecemasan.

Observasi

- a. Identifikasi penurunan tingkat energi, ketidakmampuan berkonsentrasi, atau gejala lain yang mengganggu kemampuan kognitif
- b. Identifikasi Teknik relaksasi yang pernah efektif digunakan
- c. Identifikasi kesediaan, kemampuan, dan penggunaan Teknik sebelumnya

- d. Periksa ketegangan otot, frekuensi nadi, tekanan darah, dan suhu sebelum dan sesudah Latihan
- e. Monitor respons terhadap terapi relaksasi

Terapeutik

- a. Ciptakan lingkungan tenang dan tanpa gangguan dengan pencahayaan dan suhu ruang nyaman, jika memungkinkan
- b. Berikan informasi tertulis tentang persiapan dan prosedur teknik relaksasi
- c. Gunakan pakaian longgar
- d. Gunakan nada suara lembut dengan irama lambat dan berirama
- e. Gunakan relaksasi sebagai strategi penunjang dengan analgetik atau Tindakan medis lain, jika sesuai

Edukasi

- a. Jelaskan tujuan, manfaat, Batasan, dan jenis relaksasi yang tersedia (mis: musik, meditasi, napas dalam, relaksasi otot progresif)
- b. Jelaskan secara rinci intervensi relaksasi yang dipilih
- c. Anjurkan mengambil posisi nyaman
- d. Anjurkan rileks dan merasakan sensasi relaksasi
- e. Anjurkan sering mengulangi atau melatih Teknik yang dipilih
- f. Demonstrasikan dan latih Teknik relaksasi (mis: napas dalam, peregangan, atau imajinasi terbimbing)

10. Koping individu tidak efektif

Intervensi Utama:

Dukungan pengambilan keputusan dalam Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (I.09265).

Dukungan pengambilan keputusan adalah intervensi yang dilakukan oleh perawat untuk memberikan informasi dan dukungan saat pembuatan keputusan Kesehatan.

Observasi

- a. Identifikasi persepsi mengenai masalah dan informasi yang memicu konflik

Terapeutik

- a. Fasilitasi mengklarifikasi nilai dan harapan yang membantu membuat pilihan
- b. Diskusikan kelebihan dan kekurangan dari setiap solusi
- c. Fasilitasi melihat situasi secara realistic
- d. Motivasi mengungkapkan tujuan perawatan yang diharapkan
- e. Fasilitasi pengambilan keputusan secara kolaboratif
- f. Hormati hak pasien untuk menerima atau menolak informasi
- g. Fasilitasi menjelaskan keputusan kepada orang lain, jika perlu
- h. Fasilitasi hubungan antara pasien, keluarga, dan tenaga Kesehatan lainnya

Edukasi

- a. Jelaskan alternatif solusi secara jelas
- b. Berikan informasi yang diminta pasien

Kolaborasi

- a. Kolaborasi dengan tenaga Kesehatan lain dalam memfasilitasi pengambilan keputusan

Dukungan penampilan peran dalam Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI) (I.13478).

Dukungan penampilan peran adalah intervensi yang dilakukan oleh perawat untuk memfasilitasi pasien dan keluarga untuk memperbaiki hubungan dengan mengklarifikasi dan memenuhi perilaku peran tertentu.

Observasi

- a. Identifikasi berbagai peran dan periode transisi sesuai tingkat perkembangan
- b. Identifikasi peran yang ada dalam keluarga
- c. Identifikasi adanya peran yang tidak terpenuhi

Terapeutik

- a. Fasilitasi adaptasi peran keluarga terhadap perubahan peran yang tidak diinginkan
- b. Fasilitasi bermain peran dalam mengantisipasi reaksi orang lain terhadap perilaku
- c. Fasilitasi diskusi perubahan peran anak terhadap bayi baru lahir, jika perlu
- d. Fasilitasi diskusi tentang peran orang tua, jika perlu
- e. Fasilitasi diskusi tentang adaptasi peran saat anak meninggalkan rumah, jika perlu
- f. Fasilitasi diskusi harapan dengan keluarga dan peran timbal balik

Edukasi

- a. Diskusikan perilaku yang dibutuhkan untuk pengembangan peran
- b. Diskusikan perubahan peran yang diperlukan akibat penyakit atau ketidakmampuan
- c. Diskusikan perubahan peran dalam menerima ketergantungan orang tua
- d. Diskusikan strategi positif untuk mengelola perubahan peran
- e. Ajarkan perilaku baru yang dibutuhkan oleh pasien/orang tua untuk memenuhi peran

Kolaborasi

- a. Rujuk dalam kelompok untuk mempelajari peran baru

Promosi coping dalam Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI) (I.09312).

Promosi coping adalah intervensi yang dilakukan oleh perawat untuk meningkatkan upaya kognitif dan perilaku untuk menilai dan merespon stresor dan/atau kemampuan menggunakan sumber-sumber yang ada.

Observasi

- a. Identifikasi kegiatan jangka pendek dan Panjang sesuai tujuan
- b. Identifikasi kemampuan yang dimiliki
- c. Identifikasi sumber daya yang tersedia untuk memenuhi tujuan
- d. Identifikasi pemahaman proses penyakit
- e. Identifikasi dampak situasi terhadap peran dan hubungan
- f. Identifikasi metode penyelesaian masalah
- g. Identifikasi kebutuhan dan keinginan terhadap dukungan sosial

Terapeutik

- a. Diskusikan perubahan peran yang dialami
- b. Gunakan pendekatan yang tenang dan meyakinkan
- c. Diskusikan alasan mengkritik diri sendiri
- d. Diskusikan untuk mengklarifikasi kesalahpahaman dan mengevaluasi perilaku sendiri
- e. Diskusikan konsekuensi tidak menggunakan rasa bersalah dan rasa malu
- f. Diskusikan risiko yang menimbulkan bahaya pada diri sendiri
- g. Fasilitasi dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan
- h. Berikan pilihan realistis mengenai aspek-aspek tertentu dalam perawatan
- i. Motivasi untuk menentukan harapan yang realistis
- j. Tinjau Kembali kemampuan dalam pengambilan keputusan
- k. Hindari mengambil keputusan saat pasien berada dibawah tekanan
- l. Motivasi terlibat dalam kegiatan sosial
- m. Motivasi mengidentifikasi sistem pendukung yang tersedia
- n. Dampingi saat berduka (mis: penyakit kronis, kecacatan)
- o. Perkenalkan dengan orang atau kelompok yang berhasil mengalami pengalaman sama
- p. Dukung penggunaan mekanisme pertahanan yang tepat
- q. Kurangi rangsangan lingkungan yang mengancam

Edukasi

- a. Anjurkan menjalin hubungan yang memiliki kepentingan dan tujuan sama
- b. Anjurkan penggunaan sumber spiritual, jika perlu
- c. Anjurkan mengungkapkan perasaan dan persepsi
- d. Anjurkan keluarga terlibat
- e. Anjurkan membuat tujuan yang lebih spesifik
- f. Ajarkan cara memecahkan masalah secara konstruktif
- g. Latih penggunaan Teknik relaksasi
- h. Latih keterampilan sosial, sesuai kebutuhan
- i. Latih mengembangkan penilaian obyektif

E. Evaluasi dan dokumentasi

Standar luaran keperawatan menjadi salah satu panduan untuk mengevaluasi kondisi kesehatan pasien. Tingkat keberhasilan intervensi dapat diamati dan diukur secara spesifik. Adapun standar luaran untuk diagnosa keperawatan pada lansia berdasarkan Tim Pokja SIKI PPNI (2018), yaitu:

1. Resiko jatuh

Luaran utama: Tingkat jatuh

Definisi : Derajat jatuh berdasarkan observasi atau sumber informasi.

Ekspresi: menurun

Tabel 1.1 tingkat jatuh

Kriteria hasil	Meningkat	Cukup meningkat	Sedang	Cukup menurun	Cukup menurun
Jatuh dari tempat tidur	1	2	3	4	5
Jatuh saat berdiri	1	2	3	4	5
Jatuh saat duduk	1	2	3	4	5
Jatuh saat berjalan	1	2	3	4	5
Jatuh saat dipindahkan	1	2	3	4	5
Jatuh saat naik tangga	1	2	3	4	5
Jatuh saat di kamar mandi	1	2	3	4	5
Jatuh saat membungkuk	1	2	3	4	5

2. Gangguan mobilitas fisik

Luaran utama : Mobilitas fisik

Definisi : Kemampuan dalam gerakan fisik dari satu atau lebih ekstremitas secara mandiri.

Ekspektasi : Meningkatkan

Tabel 1.2 Mobilitas fisik

Kriteri hasil	Menurun	Cukup menurun	Sedang	Cukuo meningkat	Meningkat

Pergerakan ekstremitas	1	2	3	4	5
Kekuatan otot	1	2	3	4	5
Rentang gerak (ROM)	1	2	3	4	5
	Meningkat	Cukup meningkat	Sedang	Cukup menurun	Menurun
Nyeri	1	2	3	4	5
Kecemasan	1	2	3	4	5
Kaku sendi	1	2	3	4	5
Gerakan tidak terkoordinasi	1	2	3	4	5
Gerakan terbatas	1	2	3	4	5
Kelemahan fisik	1	2	3	4	5

3. Defisit perawatan diri (mandi, berpakaian, makan, eliminasi)

Luaran utama : Perawatan diri

Definisi : Kemampuan melakukan atau menyelesaikan aktivitas perawatan diri.

Ekspektasi : Meningkatkan

Tabel 1.3 Perawatan diri

Kriteria hasil	Menurun	Cukup menurun	Sedang	Cukup meningkat	Meningkat
Kemampuan mandi	1	2	3	4	5
Kemampuan mengenakan pakaian	1	2	3	4	5
Kemampuan makan	1	2	3	4	5
Kemampuan ke toilet (BAK/BAB)	1	2	3	4	5

Verbalisasi keinginan melakukan perawatan diri	1	2	3	4	5
Minat melakukan perawatan diri	1	2	3	4	5
Mempertahankan kebersihan diri	1	2	3	4	5
Mempertahankan kebersihan mulut	1	2	3	4	5

4. Gangguan pola tidur

Luaran utama : Pola tidur

Definisi : Keadekuatan kualitas dan kuantitas tidur.

Ekspektasi : Membaik

Tabel 1.4 pola tidur

Kriteria hasil	Menurun	Cukup menurun	Sedang	Cukup meningkat	Meningkat
Keluhan sulit tidur	1	2	3	4	5
Keluhan sering terjaga	1	2	3	4	5
Keluhan tidak puas tidur	1	2	3	4	5
Keluhan pola tidur berubah	1	2	3	4	5
eluhan istirahat tidak cukup	1	2	3	4	5

	Meningkat	Cukup meningkat	Sedang	Cukup menurun	Menurun
Kemampuan beraktifitas	1	2	3	4	5

5. Resiko nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh

Luaran utama : Status nutrisi

Definisi : Keadekuatan asupan nutrisi untuk memenuhi kebutuhan metabolisme

Ekspektasi :Membaik

Tabel 1.5 Status nutrisi

Kriteria hasil	Menurun	Cukup menurun	Sedang	Cukup meningkat	Meningkat
Porsi makan yang dihabiskan	1	2	3	4	5
Kekuatan mengunyah	1	2	3	4	5
Kekuatan otot menelan	1	2	3	4	5
Serum albumin	1	2	3	4	5
Verbalisasi keinginan untuk meningkatkan nutrisi	1	2	3	4	5
Pengetahuan tentang pilihan minuman yang sehat	1	2	3	4	5
Pengetahuan tentang asupan nutrisi yang sehat	1	2	3	4	5
Penyiapan dari penyimpanan	1	2	3	4	5

makanan yang sehat					
Penyiapan dari penyimpanan minuman yang sehat	1	2	3	4	5
Sikap terhadap makanan/minuman sesuai dengan tujuan kesehatan	1	2	3	4	5
	Meningkat	Cukup meningkat	Sedang	Cukup menurun	Menurun
Perasaan cepat kenyang	1	2	3	4	5
Nyeri abdomen	1	2	3	4	5
Sariawan	1	2	3	4	5
Rambut rontok	1	2	3	4	5
Diare	1	2	3	4	5
	Memburuk	Cukup memburuk	Sedang	Cukup membaik	Membaik
Berat badan	1	2	3	4	5
Indeks masa tubuh (IMT)	1	2	3	4	5
Frekuensi makan	1	2	3	4	5
Nafsu makan	1	2	3	4	5
Bising usus	1	2	3	4	5

Tebal lipatan kulit trisep	1	2	3	4	5
Membran mukosa	1	2	3	4	5

6. Isolasi sosial

Luaran utama :Keterlibatan sosial

Definisi : Kemampuan untuk membina hubungan yang erat, hangat, terbuka dan independen dengan orang lain.

Ekspektasi : Meningkatkan

Tabel 1.6 Keterlibatan sosial

Kriteria hasil	Menurun	Cukup menurun	Sedang	Cukup meningkat	Meningkat
Minat interaksi	1	2	3	4	5
Verbalisasi tujuan yang jelas	1	2	3	4	5
Mihat terhadap aktifitas	1	2	3	4	5
	Meningkat	Cukup meningkat	Sedang	Cukup menurun	Menurun
Verbalisasi isolasi	1	2	3	4	5
Verbalisasi ketidaksamaan di tempat umum	1	2	3	4	5
Perilaku menarik diri	1	2	3	4	5
Verbalisasi perasaan berbeda dari orang lain	1	2	3	4	5

Verbalisasi preokupasi dengan pikiran sendiri	1	2	3	4	5
Afek murung/sedih	1	2	3	4	5
Perilaku bermusuhan	1	2	3	4	5
	Memburuk	Cukup memburuk	Sedang	Cukup membaik	Membaik
Perilaku sesuai dengan harapan orang lain	1	2	3	4	5
Perilaku bertujuan	1	2	3	4	5
Kontak mata	1	2	3	4	5
Tugas perkembangan sesuai usia	1	2	3	4	5

7. Gangguan memori

Luaran utama : Memori

Definisi : Kemampuan mengingat beberapa informasi atau perilaku.

Ekspektasi : Meningkat

Tabel 1.7 memori

Kriteria hasil	Menurun	Cukup menurun	Sedang	Cukup meningkat	Meningkat
Verbalisasi kemampuan mempelajari hal baru	1	2	3	4	5
Verbalisasi kemampuan mengingat informasi faktual	1	2	3	4	5

Verbalisasi kemampuan mengingat perilaku tertentu yang pernah dilakukan	1	2	3	4	5
Verbalisasi kemampuan mengingat kan peristiwa	1	2	3	4	5
Melakukan kemampuan yang dipelajari	1	2	3	4	5
	Meningkat	Cukup meningkat	Sedang	Cukup menurun	Menurun
Verbalisasi pengalaman lupa	1	2	3	4	5
Verbalisasi lupa jadwal	1	2	3	4	5
Verbalisasi mudah lupa	1	2	3	4	5

8. Resiko kekerasan

Luaran utama : Kontrol diri

Definisi : Kemampuan untuk, mengendalikan atau mengatur emosi, pikiran, dan perilaku dalam menghadapi masalah

Ekspektasi : Meningkatkan

Tabel 1.8 Kontrol diri

Kriteria hasil	Menurun	Cukup menurun	Sedang	Cukup meningkat	Meningkat
Verbalisasi ancaman kepada orang lain	1	2	3	4	5
Verbalisasi umpatan	1	2	3	4	5

Perilaku menyerang	1	2	3	4	5
Perilaku melukai diri sendiri/orang lain	1	2	3	4	5
Perilaku merusak lingkungan sekitar	1	2	3	4	5
Perilaku agresif/amuk	1	2	3	4	5
Suara keras	1	2	3	4	5
Bicara ketus	1	2	3	4	5
Verbalisasi keinginan bunuh diri	1	2	3	4	5
Verbalisasi isyarat bunuh diri	1	2	3	4	5
Verbalisasi ancaman bunuh diri	1	2	3	4	5
Verbalisasi rencana bunuh diri	1	2	3	4	5
Verbalisasi kehilangan	1	2	3	4	5

hubungan yang penting					
Perilaku merencanakan bunuh diri	1	2	3	4	5
Euforia	1	2	3	4	5
Alam perasaan depresi	1	2	3	4	5

9. Ansietas

Luaran utama : Tingkat ansietas

Definisi : Kondisi emosi dan pengalaman subyektif terhadap objek yang tidak jelas dan spesifik akibatantisipasi bahaya yang memungkinkan individu melakukan tindakan untuk menghadapi ancaman.

Ekspektasi : Menurun

Tabel 1.9 Tingkat ansietas

Kriteria hasil	Meningkat	Cukup meningkat	Sedang	Cukup menurun	Menurun
Verbalisasi kebingungan	1	2	3	4	5
Verbalisasi khawatir akibat kondisi yang dihadapi	1	2	3	4	5
Perilaku gelisah	1	2	3	4	5
Perilaku tegang	1	2	3	4	5
Keluhan pusing	1	2	3	4	5
anoreksia	1	2	3	4	5
Palpitasi	1	2	3	4	5
Frekuensi pemapasan	1	2	3	4	5
Frekuensi nad	1	2	3	4	5

Frekuensi tekanan darah	1	2	3	4	5
Diaforesis	1	2	3	4	5
Tremor	1	2	3	4	5
Pucat	1	2	3	4	5
	Memburuk	Cukup memburuk	Sedang	Cukup membaik	Membaik
Konsentrasi	1	2	3	4	5
Pola tidur	1	2	3	4	5
Perasaan keberdayaan	1	2	3	4	5
Kontak mata	1	2	3	4	5
Pola berkemih	1	2	3	4	5
Orientasi	1	2	3	4	5

10. Koping individu tidak efektif

Luaran utama : Status koping

Definisi : Kemampuan menilai dan merespons stresor dan / atau kemampuan menggunakan sumber-sumber yang ada untuk mengatasi masalah.

Ekspektasi : Membaik

Tabel 1.10 Status koping

Kriteria hasil	Menurun	Cukup menurun	Sedang	Cukup meningkat	Meningkat
Kemampuan memenuhi peran sesuai usia	1	2	3	4	5
Perilaku koping adaptif	1	2	3	4	5
Verbalisasi kemampuan mengatasi masalah	1	2	3	4	5

Verbalisasi pengakuan masalah	1	2	3	4	5
Verbalisasi kelemahan diri	1	2	3	4	5
Perilaku asertif	1	2	3	4	5
Partisipasi sosial	1	2	3	4	5
Tagging jawab diri	1	2	3	4	5
Orientasi realita	1	2	3	4	5
Minat mengikuti perawatan/pengobatan	1	2	3	4	5
Kemampuan membina hubungan	1	2	3	4	5
	Meningkat	Cukup meningkat	Sedang	Cukup menurun	Menurun
Verbalisasi menyalahkan orang lain	1	2	3	4	5
Verbalisasi rasionalisasi kegagalan	1	2	3	4	5
Hipersensitif pada kritik	1	2	3	4	5
Perilaku penyalahgunaan zat	1	2	3	4	5
Perilaku manipulasi	1	2	3	4	5

Perilaku permusuhan	1	2	3	4	5
Perilaku superior	1	2	3	4	5

F. Latihan Soal

Pilihan Ganda

2. Apa tujuan utama proses keperawatan pada lansia?
 - c. Memberikan terpai farmakologis secara optimal
 - d. Mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan dasar lansia secara holistic
 - e. Menyembuhkan semua penyakit kronis lansia
 - f. Memberikan makanan tambahan kepada lansia

Jawaban: B

2. Masalah yang sering ditemukan pada pengkajian lansia adalah...
 - a. Nafsu makan meningkat
 - b. Hipertensi dan gangguan mobilitas
 - c. Hipotensi dan gangguan mobilitas
 - d. Hipotermi akut

Jawaban: B

3. Salah satu pendekatan dalam pengkajian lansia adalah menggunakan alat...
 - a. APGAR
 - c. Asia scale
 - b. GDS (geriatric Depression scale)
 - d. Mini Nutritional Test (MNT)

Jawaban: B

4. Dalam tahap diagnosa keperawatan lansia, perawat mengidentifikasi bahwa klien mengalami gangguan mobilitas fisik. Diagnosa yang tepat adalah...
 - a. Resiko jatuh
 - b. Gangguan mobilitas fisik
 - c. Gangguan citra tubuh
 - d. Resiko infeksi

Jawaban: B

5. Prinsip dalam perencanaan keperawatan pada lansia adalah...
 - a. Fokus pada keluarga saja
 - b. Mengabaikan riwayat penyakit masa lalu
 - c. Mengutamakan kebutuhan individu lansia
 - d. Terbatas pada tindakan kuratif

Jawaban: C

Isian Singkat

1. Sebutkan dua contoh intervensi keperawatan untuk lansia dengan risiko jatuh!

Jawaban:

- Pasang bel pemanggil dalam jangkauan
- Pastikan lingkungan bebas dari benda yang menghalangi jalan

2. Apa tujuan dari evaluasi dalam proses keperawatan pada lansia?

Jawaban:

Menilai efektivitas intervensi dan menentukan apakah tujuan keperawatan tercapai atau perlu modifikasi.

3. Sebutkan satu alat skrining status nutrisi pada lansia!

Jawaban:

Mini Nutritional Assessment (MNA)

4. Sebutkan salah satu perubahan fisiologis normal pada lansia!

Jawaban:

Penurunan elastisitas pembuluh darah

5. Dalam proses pengkajian, mengapa penting untuk melibatkan keluarga lansia?

Jawaban: Karena keluarga dapat memberikan informasi tambahan dan mendukung perawatan yang berkelanjutan di rumah

G. Rangkuman Materi

Pengertian Lansia

Lansia (lanjut usia) adalah individu yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas, yang mengalami perubahan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual akibat proses penuaan.

Tujuan Keperawatan Lansia

- Menjaga dan meningkatkan kualitas hidup lansia.
- Membantu lansia mencapai kemandirian optimal.
- Mencegah komplikasi atau penyakit degeneratif.
- Memberikan dukungan emosional dan sosial.

Karakteristik Lansia

- Fisik: Penurunan fungsi indera, otot, tulang, dan sistem organ.
- Psikologis: Risiko depresi, gangguan memori, kecemasan.
- Sosial: Isolasi sosial, kehilangan pasangan/teman, perubahan peran.
- Spiritual: Peningkatan kebutuhan terhadap makna hidup dan ibadah.

Proses Keperawatan Lansia (Nursing Process)

Pengkajian

- Data subjektif dan objektif, mencakup: riwayat kesehatan, pola hidup, ADL (Activity Daily Living), kondisi mental dan sosial.
- Alat bantu: Indeks Barthel, MMSE, GDS (Geriatric Depression Scale), dll.

Diagnosa Keperawatan

Contoh diagnosa umum pada lansia:

- Risiko jatuh.
- Gangguan mobilitas fisik.
- Isolasi sosial.
- Gangguan memori.
- Risiko malnutrisi.

Perencanaan

- Tujuan spesifik dan realistis.
- Fokus pada peningkatan fungsi, adaptasi, dan dukungan sosial.

Implementasi

- Intervensi disesuaikan dengan kondisi lansia: edukasi, terapi fisik, dukungan psikologis, rujukan layanan sosial.
- Pelibatan keluarga atau caregiver.

Evaluasi

- Menilai kemajuan tujuan keperawatan.
- Revisi rencana bila diperlukan.

Keperawatan pada Kelompok Lansia

- Promosi kesehatan: Edukasi gizi, aktivitas fisik, pencegahan penyakit.
- Pencegahan penyakit: Imunisasi, skrining kesehatan rutin.
- Pelayanan komunitas: Posyandu lansia, klub lansia, home care.
- Pemberdayaan lansia: Kegiatan sosial dan keterampilan.

H. Glosarium

Istilah	Pengertian
Lansia (Lanjut Usia)	Individu yang berusia 60 tahun ke atas, sesuai klasifikasi WHO dan pemerintah.
Gerontologi	Ilmu yang mempelajari proses penuaan dari aspek biologis, psikologis, dan sosial.
Geriatri	Cabang ilmu kedokteran yang fokus pada pencegahan, diagnosis, dan pengobatan penyakit pada lansia.
Proses Keperawatan	Metode sistematis dalam memberikan asuhan keperawatan yang terdiri dari 5 tahap: pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi, dan evaluasi.

Istilah	Pengertian
Pengkajian Keperawatan	Tahap awal dalam proses keperawatan untuk mengumpulkan data tentang kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual klien.
Diagnosa Keperawatan	Identifikasi masalah kesehatan yang dapat ditangani oleh perawat, berdasarkan hasil pengkajian.
Intervensi Keperawatan	Tindakan yang dilakukan perawat berdasarkan rencana untuk mengatasi masalah yang ditemukan.
Evaluasi Keperawatan	Proses menilai sejauh mana tujuan keperawatan telah tercapai.
Risiko Jatuh	Keadaan yang sering dialami lansia akibat gangguan keseimbangan, kelemahan otot, atau efek obat.
Skala GDS (Geriatric Depression Scale)	Alat ukur untuk menilai tingkat depresi pada lansia.
MNA (Mini Nutritional Assessment)	Alat skrining status gizi pada lansia.
Demensia	Penurunan fungsi kognitif progresif yang umum pada lansia, seperti Alzheimer.
Delirium	Gangguan kesadaran akut yang bersifat reversibel, sering terjadi pada lansia saat sakit.
Penuaan	Proses alami yang menyebabkan penurunan fungsi tubuh secara bertahap.
Asuhan Keperawatan Holistik	Pendekatan keperawatan yang memperhatikan aspek fisik, emosional, sosial, dan spiritual pasien.
ADL (Activities of Daily Living)	Aktivitas harian dasar seperti makan, mandi, berpakaian, yang digunakan untuk menilai kemandirian lansia.
Kemandirian	Kemampuan lansia untuk melakukan aktivitas sehari-hari tanpa bantuan orang lain.
Support System	Dukungan dari keluarga, teman, atau komunitas yang penting dalam proses penyembuhan dan kesejahteraan lansia.

Istilah	Pengertian
Kelompok Khusus Lansia	Lansia yang memiliki kebutuhan khusus, seperti yang tinggal di panti jompo, lansia dengan penyakit kronis, atau lansia terlantar.
Polifarmasi	Penggunaan banyak obat sekaligus, yang umum terjadi pada lansia dan bisa menyebabkan interaksi obat.

I. Daftar Pustaka

- Amzal Mortin Andas, dkk (2025) Romantika. *Buku Ajar Keperawatan Gerontik*. Sonpedia Publishing Indonesia
- Kurdi, Fahrudin; Latifa Aini Susumaningrum; Hanny Rasni; Tantut Susanto; Rizkiyani Istifada (2025). *Asuhan Keperawatan Gerontik: Pendidikan Profesi Ners*. Perkumpulan Al Hijrah Indonesia (PAHI)
- PPNI. (2017). Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikator Diagnostik, Edisi 1 Cetakan III (Revisi). Jakarta:
- PPNI. (2018). Standar Intervensi Keperawatan Indonesia: Definisi dan Tindakan Keperawatan, Edisi 1 Cetakan II. Jakarta
- PPNI. (2018). Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan, Edisi 1 Cetakan II. Jakarta
- Rasyid, Djusmadi; Agustina Maunaturrohman; Eny Rahmawati; Hartin Suidah;dll (2023) *Asuhan Keperawatan Gerontik dengan Berbagai Masalah Kesehatan*. Nuansa Fajar Cemerlang.
- Sharif La Ode (2020) *Asuhan Keperawatan Gerontik*. Nuha Medika
- Sunanto, Nurul Laili (2024). *Buku Mata Ajar Keperawatan Gerontik*. Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia,
- Supriadi, dkk.(2025) *Buku Keperawatan Gerontik, Pendekatan Holistik*. Deepublish,

BAB 5

PROSEDUR PENGKAJIAN PADA LANSIA

Tujuan Instruksional:

- Menjelaskan konsep pengkajian lansia
- Menjelaskan pengkajian status aktifitas
- Menjelaskan pengkajian kognitif

Capaian Pembelajaran:

- Mendemonstrasikan prosedur pengkajian lansia.

CPL:

- Mampu menjelaskan konsep pengkajian lansia
- Mampu melakukan prosedur pengkajian lansia

CPMK:

- Mahasiswa mampu mempratikkan prosedur pengkajian lansia

Sub CPMK:

- Mampu melakukan prosedur pengkajian fisik
- Mampu melakukan prosedur penilaian status fungsional (tingkat kemandirian lansia)
- Mampu melakukan prosedur pengkajian fungsi psikologis
- Mampu melakukan prosedur pengkajian status nutrisi

Pendahuluan

Penuaan merupakan proses biologis, psikologis, dan sosial yang alami dan tidak dapat dihindari. Seiring meningkatnya usia, individu mengalami perubahan fisik, kognitif, emosional, dan sosial yang mempengaruhi kualitas hidup juga kemampuan dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Pengkajian gerontik merupakan salah satu upaya sistematis untuk menilai kondisi kesehatan, kemampuan fungsional, serta kebutuhan sosial dan psikologis lansia. Pengkajian dilakukan dengan berfokus pada sindrom geriatri, yaitu kumpulan kondisi klinis yang umum terjadi pada lansia seperti gangguan mobilitas, malnutrisi, gangguan kognitif, depresi, *inkontinensia urin*, dan gangguan penglihatan serta pendengaran.

Deteksi dini terhadap sindrom geriatri sangat penting untuk mencegah penurunan fungsi, meningkatkan kemandirian lansia, dan mendorong kualitas hidup yang lebih baik. Oleh karena itu, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi tanda dan gejala, serta melakukan analisis kebutuhan lansia secara komprehensif.

Tujuan buku ajar ini dibuat agar dapat mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam melakukan pengkajian fisik, psikologis, dan sosial pada lanjut usia. Selain itu dapat meningkatkan keterampilan untuk merancang intervensi yang sesuai berdasarkan hasil pengkajian gerontik. Buku ajar ini ditujukan kepada mahasiswa program studi keperawatan. Materinya mencakup pengkajian lansia meliputi pengkajian fisik, pengkajian psikologis dan kognitif, dan pengkajian psikologis – lingkungan.

Buku ajar ini juga menggunakan metode pembelajaran praktik langsung melalui pembelajaran praktik langsung dan berbasis kasus.

Uraian Materi

Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G) merupakan proses diagnostik *interdisiplin*, untuk menentukan masalah dan kapabilitas medis, kemampuan fungsional, psikososial dan lingkungan bagi pasien lanjut usia. Karakteristik dan sindrom pada pasien geriatri berbeda, maka diperlukan pendekatan khusus yang berorientasi bio-psiko-sosial, dan setiap pasien lanjut usia yang mutlak diperlukan agar penatalaksanaannya paripurna.

Pengkajian paripurna ini berupa instrumen dasar yang harus dimiliki oleh setiap dokter, perawat, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik dan lain-lain yang mengelola pasien geriatri sesuai dengan kompetensinya masing-masing.

A. Pengkajian Fisik Lansia

Sebelum melakukan pengkajian khusus lansia, perawat terlebih dahulu melakukan pengkajian fisik lansia. Pengkajian ini meliputi observasi penampilan fisik, pengukuran tanda-tanda vital dan pengkajian per sistem.

Pemeriksaan tanda vital sangat dianjurkan untuk memperhatikan derajat penurunan atau perubahan kesadaran (bila ada). Pemeriksaan tekanan darah dan frekuensi denyut jantung dilakukan pada posisi berbaring dan duduk serta berdiri (bila memungkinkan); *hipotensi ortostatik* lebih sering muncul pada pasien Lanjut Usia. Pengkajian sistem mulai dari sistem kardiovaskular, sistem pernapasan, sistem gastrointestinal, sistem genitourinarius, sistem muskulos-keletal, sistem hematologi, sistem metabolik, endokrinologi dan pemeriksaan neurologik.

B. Penilaian tingkat kemandirian

1. Modifikasi dari Barthel Indeks

Instrumen ini digunakan untuk menilai tingkat kemandirian dalam aktivitas kehidupan sehari-hari (AKS)/ *Activity of Daily Living (ADL)*, digunakan untuk melihat kemajuan pasien penyakit kronis sebelum dan setelah terapi, juga untuk menentukan berapa besar bantuan perawatan yang dibutuhkan pasien.

Kuesioner dalam bentuk skala angka, ditanyakan langsung kepada pasien ataupun keluarga terkait kemandirian fungsi dalam mengurus diri sendiri dan mobilitas.

Cara pelaksanaannya:

Pemeriksa/perawat menanyakan 10 kegiatan sehari-hari yang tercantum di kuesioner dan memberi skala angka (seperti yang tertera berikut ini).

Selanjutnya dilakukan penjumlahan skor hasil akhir pemeriksaan.

Termasuk yang manakah klien?

Tabel 5.1 penjumlahan skor hasil akhir pemeriksaan.

NO	KRITERIA	DENGAN BANTUAN	MANDIRI	KETERANGAN
1	Makan	5	10	Frekuensi Jumlah Jenis
2	Minum	5	10	Frekuensi Jumlah Jenis
3	Berpindah dari kursi roda ke tempat tidur, sebaliknya	5-10	15	
4	Personal toilet (cuci muka, menyisir rambut, gosok gigi)	0	5	Frekuensi
5	Keluar masuk toilet (mencuci pakaian, menyeka tubuh dan menyiram)	5	10	
6	Mandi	5	15	Frekuensi
7	Jalan di permukaan datar	0	5	
8	Naik turun tangga	5	10	
9	Mengenakan pakaian	5	10	
10	Kontrol bowel (BAB)	5	10	Frekuensi : Konsistensi :
11	Kontrol bladder (BAK)	5	10	Frekuensi Warna :
12	Olah raga / latihan	5	10	Frekuensi: Jenis :
13	Rekreasi / pemanfaatan waktu luang	5	10	Jenis : Frekuensi

Keterangan :

- a. 130 : Mandiri
- b. 65 - 125 : Ketergantungan sebagian
- c. 60 : Ketergantungan total

2. Penilaian Tingkat Kemandirian Dengan Instrumental Activities Of Daily Living (IADL) Lawton

Pemeriksa menanyakan 8 kegiatan sehari-hari yang tercantum di kuesioner dengan tulisan di bold dan melingkari skor angka sesuai jawaban yang disampaikan pasien. Selanjutnya dilakukan penjumlahan skor hasil akhir pemeriksaan.

Tabel 5.2 Penjumlahan Skor Hasil Akhir Pemeriksaan.

	Skor	Hasil
Dapat menggunakan telepon		
Mengoperasikan telepon sendiri dan mencari dan menghubungi nomor	1	
Menghubungi beberapa nomor yang diketahui	1	
Menjawab telepon tetapi tidak menghubungi	1	
Tidak bisa menggunakan telepon sama sekali	0	
Mampu pergi ke suatu tempat		
Berpergian sendiri menggunakan kendaraan umum atau menyetir sendiri	1	
Mengatur perjalanan sendiri	1	
Perjalanan menggunakan transportasi umum jika ada yang menyertai	0	
Tidak melakukan perjalanan sama sekali	0	
Dapat berbelanja		
Mengatur semua kebutuhan belanja sendiri	1	
Perlu bantuan untuk mengantar belanja	0	
Sama sekali tidak mampu belanja	0	
Dapat menyiapkan makanan		
Merencanakan, menyiapkan, dan menghidangkan makanan	1	
Menyiapkan makanan jika sudah tersedia bahan makanan	0	
Menyiapkan makanan tetapi tidak mengatur diet yang cukup	0	
Perlu disiapkan dan dilayani	0	
Dapat melakukan pekerjaan rumah tangga		
Merawat rumah sendiri atau bantuan kadang-kadang	1	
Mengerjakan pekerjaan ringan sehari-hari (merapikan tempat tidur, mencuci piring)	1	
Perlu bantuan untuk semua perawatan rumah sehari-hari	1	
Tidak berpartisipasi dalam perawatan rumah	0	
Dapat mencuci pakaian		
Mencuci semua pakaian sendiri	1	
Mencuci pakaian yang kecil	1	
Semua pakaian dicuci oleh orang lain	0	
Dapat mengatur obat - obatan		

Meminum obat secara tepat dosis dan waktu tanpa bantuan	1	
Tidak mampu menyiapkan obat sendiri	0	
Dapat mengatur keuangan		
Mengatur masalah financial (tagihan, pergi ke bank)	1	
Mengatur pengeluaran sehari-hari, tapi perlu bantuan untuk ke bank untuk transaksi penting	1	
Tidak mampu mengambil keputusan financial atau memegang uang	0	
Total		

Interpretasi:

Dikerjakan oleh orang lain	: 0
Perlu bantuan sepanjang waktu	: 1
Perlu bantuan sesekali	: 2
Independen/mandiri	: 3-8

3. Penilaian Risiko Jatuh Pasien Lanjut Usia

Jatuh didefinisikan sebagai perpindahan tubuh ke bawah, ke tanah atau benda lain, secara tiba-tiba, tidak terkendali, tidak disengaja. Nyaris jatuh adalah kehilangan keseimbangan secara tiba-tiba yang tidak mengakibatkan jatuh atau cedera lainnya. Hal ini termasuk orang yang tergelincir atau tersandung namun mampu mendapatkan kembali kontrol sebelum jatuh. Berdasarkan data yang ada, kejadian jatuh pada lansia semakin meningkat dari tahun ke tahun, yang disebabkan oleh faktor lingkungan dan penyakit yang diderita. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya pencegahan dengan melakukan penilaian risiko jatuh pada pasien lanjut usia dengan menggunakan instrument.

Untuk melakukan penilaian risiko jatuh, dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen Penilaian Risiko Jatuh Pasien Lanjut Usia. Tenaga medis perlu mengidentifikasi gejala/kriteria seperti yang disebutkan dalam instrumen. Jika pada pasien dijumpai gejala/kriteria tersebut, maka pasien mendapat skor sesuai dengan skala yang tercantum. Jika tidak, maka pasien mendapat nilai 0. Selanjutnya seluruh skor dijumlah.

Tabel 5.3 Penilaian Risiko Jatuh Pasien Lanjut Usia

NO	RISIKO	SKALA	HASIL
1	Gangguan gaya berjalan (diseret, menghentak, berayun)	4	
2	Pusing atau pingsan pada posisi tegak	3	
3	Kebingungan setiap saat (contoh: pasien yang	3	

	mengalami demensia)		
4	Nokturia/Inkontinen	3	
5	Kebingungan intermiten (contoh pasien yang mengalami delirium/ <i>Acute confusional state</i>)	2	
6	Kelemahan umum	2	
7	Obat-obat berisiko tinggi (diuretic, narkotik, sedative, antipsikotik, laksatif, vasodilator, antiaritmia, antihipertensi, obat hipoglikemik, antidepresan, neuroleptic, NSAID)	2	
8	Riwayat jatuh dalam 12 bulan terakhir	2	
9	Osteoporosis	1	
10	Gangguan pendengaran dan/atau penglihatan	1	
11	Usia 70 tahun ke atas	1	
Jumlah			

Intepretasi:

Risiko rendah bila skor 1-3 → Lakukan intervensi risiko rendah

Risiko tinggi bila skor ≥ 4 → Lakukan intervensi risiko tinggi

C. Pengkajian Status Mental Gerontik

Status mental dapat diukur melalui beberapa kajian seperti SPMSQ, MMSE, Mini Coq, Clock Drawing test, dan AMT.

1. Identifikasi tingkat kerusakan intelektual dengan menggunakan *Short Portable Mental Status Questioner (SPMSQ)*

Instruksi:

Ajukan pertanyaan 1 – 10 pada daftar ini dan catat semua jawaban.

Catat **jumlah kesalahan total** berdasarkan 10 pertanyaan.

Tabel 5.4 Identifikasi tingkat kerusakan intelektual dengan menggunakan (SPMSQ)

BENAR	SALAH	NO	PERTANYAAN
		01	Tanggal berapa hari ini ?
		02	Hari apa sekarang ini ?
		03	Apa nama tempat ini ?
		04	Dimana alamat anda ?
		05	Berapa umur anda ?
		06	Kapan anda lahir ? (minimal tahun lahir)
		07	Siapa Presiden Indonesia sekarang ?
		08	Siapa Presiden Indonesia sebelumnya ?
		09	Siapa nama Ibu anda ?

		10	Kurangi 3 dari 20 dan pengurangan 3 dari setiap angka baru, semua secara menurun
--	--	----	--

Score =

Interprestasi :

- Salah 0 – 3: Fungsi intelektual utuh
- Salah 4 – 5: Kerusakan intelektual ringan
- Salah 6 – 8: Kerusakan intelektual sedang
- Salah 9 – 10: Kerusakan intelektual berat

2. Identifikasi aspek kognitif dari fungsi mental menggunakan *MMSE (Mini Mental State Exam's)*:

- Orientasi
- Registrasi
- Perhatian
- Kalkulasi
- Mengingat kembali
- Bahasa

Tabel 5.5 Identifikasi aspek kognitif dari fungsi mental menggunakan MMSE

NO	ASPEK KOGNITIF	NILAI MAKSIMAL	NILAI KLIEN	KRITERIA
1	Orientasi	5		Menyebutkan dengan benar : ☐ Tahun ☐ Musim ☐ Tanggal ☐ Hari ☐ Bulan
	Orientasi	5		Dimana kita sekarang berada ? ☐ Negara ☐ Propinsi ☐ Kota ☐ PSTW/RS..... ☐ Wisma/kamar

			1	☐ taruh dilantai Perintahkan pada klien untuk hal berikut (bila aktivitas sesuai perintah nilai 1 point) ☐ " tutup mata anda"
			2	Perintahkan pada klien untuk menulis satu kalimat dan menyalin gambar. ☐ tulis satu kalimat ☐ menyalin gambar

Interprestasi hasil:

24 – 30 : Tidak ada gangguan kognitif

18 – 23 : Gangguan kognitif sedang

0 – 17 : Gangguan kognitif berat

3. Pemeriksaan Mini Cog

Tujuan pemeriksaan *Mini Cog* yaitu menilai kemampuan untuk mengingat kembali nama tiga benda segera setelah disebutkan dan sesudah beberapa saat (kira-kira 3 menit)

Pemeriksaan Mini Cog:

- Mintalah pasien untuk mendengarkan dengan cermat, mengingat, dan kemudian mengulangi menyebutkan tiga kata yang tidak berhubungan (contoh: bola, melati, kursi) yang disebutkan oleh pemeriksa.
- Instruksikan pasien untuk menggambar jam pada selembar kertas kosong atau berikan pasien dengan lingkaran yang telah disediakan pada selembar kertas
- Pasien diminta untuk menggambar jam yang menunjukkan pukul sebelas lewat sepuluh menit (pukul 11.10).
- Minta pasien untuk menyebutkan kembali tiga kata yang telah disebutkan di awal pemeriksaan.
- Bila pasien tidak mampu menyebutkan kata-kata pada awal pemeriksaan, maka tidak perlu ditanyakan kembali. Karena hal tersebut telah menunjukkan hendaya kognitif.

4. Cara pemeriksaan Clock Drawing Test:

- Mintalah responden untuk menggambar sebuah jam bundar lengkap dengan angka- angkanya dan jarum jamnya yang menunjukkan pukul sebelas lewat sepuluh menit.
- Siapkan bahan:
 - 1) Selembar kertas putih kosong, atau selembar kertas dengan gambar

lingkaran, untuk pasien yang tidak mampu menggambar lingkaran)

2) Pensil tanpa penghapus

Tabel 5.6 Penilaian Skor penilaian *Clock Drawing Test* Skor 4 (modifikasi) (CDT4):

- Beri Skor 1 (satu) untuk masing –masing poin di bawah ini jika benar :

1. Gambar lingkaran utuh	1
2. Menulis angka lengkap 1-12	1
3. Angka berurutan dan tepat letaknya	1
4. Jarum jam menunjukkan pukul 11.10	1
Jumlah Total	4

- Jika poin tersebut dilakukan tidak sesuai maka diberikan skor 0

Interpretasi hasil pemeriksaan *Mini Cog* dan *Clock Drawing Test* (CDT4)

- Dikatakan curiga fungsi kognitifnya menurun apabila tidak dapat mengingat satu atau lebih kata yang diberikan sebelumnya dan atau tidak mampu menggambar jam dengan sempurna (skor 4).
- Tetapi apabila dapat mengingat tiga kata yang diberikan sebelumnya dan atau mampu menggambar jam dengan sempurna (skor 4) : kemungkinan fungsi kognitif dalam batas normal.

5. Pemeriksaan tes *Abbreviated Mental Test* (AMT)

Tabel 5.7 Pemeriksaan tes *Abbreviated Mental Test*

		Salah = 0	Benar = 1
A	Berapakah umur Anda?		
B	Jam berapa sekarang?		
C	Di mana alamat rumah Anda?		
D	Tahun berapa sekarang?		
E	Saat ini kita sedang berada di mana?		
F	Mampukah pasien mengenali dokter atau perawat?		
G	Tahun berapa Indonesia merdeka?		
H	Siapa nama presiden RI sekarang?		
I	Tahun berapa Anda lahir?		
J	Menghitung mundur dari 20 sampai 1		
	Jumlah skor:		
K	Perasaan hati (afek): pilih yang sesuai dengan kondisi pasien		

	1. Baik 2. Labil 3. Depresi 4. Gelisah 5. Cemas
--	---

Intepretasi :

Skor 8- 10 : Normal

Skor 4-7 : gangguan ingatan sedang

Skor 0-3 : gangguan ingatan berat

D. Penilaian Depresi Lanjut Usia

1. Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS)

Depresi adalah perasaan sedih dan tertekan yang menetap selama lebih dari dua minggu. Perasaan tertekan sedemikian beratnya, sehingga yang bersangkutan tak dapat melaksanakan fungsi sehari-hari. Lanjut Usia sering menderita depresi karena banyak mengalami kehilangan seperti kehilangan pekerjaan, kehilangan kemampuan fisik, kehilangan harga diri, kematian atau kehilangan pasangan hidup/kerabat/ keluarga dekat dan kepergian anak-anak.

Pasien mungkin mengungkapkan kesepian, kehilangan sesuatu yang dicintai (*lost of love object*), ada perasaan kosong /hampa, pesimis, kuatir masa depan, tak ada kepuasan hidup, merasa hidupnya tidak bahagia, mengeluhkan satu atau lebih gejala fisik (lelah, nyeri).

Pemeriksaan lanjutan akan menunjukkan adanya *mood* depresi yang sering disangkal pasien atau kehilangan minat akan hal-hal yang menjadi kebiasaannya. *Iritabilitas* (cepat marah, cepat tersinggung) kadang-kadang merupakan masalah yang dikemukakan. Rasa bersalah, keluhan fisik dan kecemasan sering tampil sebagai gejala yang menonjol. Skrining depresi dapat dilakukan dengan instrumen *Geriatric Depression Scale* (GDS)

Panduan pengisian instrumen GDS

- Jelaskan pada pasien bahwa pemeriksa akan menanyakan keadaan perasaannya dalam **dua minggu terakhir**. Tidak ada jawaban benar atau salah. **Jawablah ya atau tidak** sesuai dengan perasaan yang paling tepat akhir-akhir ini.
- Bacakan pertanyaan nomor 1 – 15 sesuai dengan kalimat yang tertulis, tunggu jawaban pasien. Jika jawaban kurang jelas, tegaskan lagi apakah pasien ingin menjawab ya atau tidak. Beri tanda (lingkari) jawaban pasien tersebut.
- Setelah semua pertanyaan dijawab, hitunglah **jumlah jawaban yang bercetak tebal**. Setiap jawaban (ya/tidak) yang bercetak tebal diberi nilai satu (1).

Tabel 5.8 Instrumen GDS

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Apakah Anda pada dasarnya puas akan kehidupan Anda ?		1
2	Apakah Anda sudah menghentikan banyak kegiatan dan hal-hal yang menarik minat Anda ?	1	
3	Apakah Anda merasa hidup Anda hampa dan tidak bermakna ?	1	
4	Apakah Anda sering bosan/jenuh ?	1	
5	Apakah Anda biasanya bersemangat/gembira ?		1
6	Apakah Anda takut jangan-jangan sesuatu yang tidak baik akan terjadi pada diri Anda ?	1	
7	Apakah Anda biasanya merasa senang dan bahagia setiap waktu ?		1
8	Apakah Anda sering merasa tidak berdaya ?	1	
9	Apakah Anda lebih suka tinggal di rumah, daripada pergi ke luar dan melakukan hal-hal yang baru ?	1	
10	Apakah Anda merasa mengalami kesulitan untuk mengingat daripada biasanya ?	1	
11	Apakah Anda menganggap sesuatu yang luar biasa bahwa Anda hidup sekarang ?		1
12	Apakah menurut Anda keadaan Anda sekarang rasanya kurang berharga ?	1	
13	Apakah Anda merasa penuh energi ?		1
14	Apakah Anda merasa situasi Anda tanpa harapan ?	1	
15	Apakah Anda merasa bahwa kebanyakan orang lebih berhasil daripada Anda ?	1	

Untuk jawaban yang sesuai dengan yang di **BOLD** diberi skor 1

Intepretasi:

- 0-5 : menunjukkan normal (tidak ada gangguan depresi)
- 5-8 : menunjukkan depresi ringan
- 9-11 : menunjukkan depresi sedang
- 12-15 : menunjukkan depresi berat.

E. Penilaian Status Nutrisi

Penilaian Risiko Malnutrisi Pasien Lanjut Usia Dengan *Mini Nutritional Assessment (MNA)*.

Mini Nutritional Assessment (MNA) merupakan salah satu instrumen untuk mendeteksi adanya risiko malnutrisi atau adanya malnutrisi pada kelompok lanjut usia.

Pemeriksaan dengan Instrumen MNA terdiri dari dua tahap, yaitu tahap pertama (penapisan/skrining), dan tahap kedua (penilaian).

Apabila skor pada tahap pertama <11, akan dilanjutkan ke tahap kedua. Seseorang diklasifikasikan malnutrisi apabila jumlah total skor <17, dan berisiko malnutrisi apabila total skor antara 17–23,5.

Tabel 5.9 Penilaian Status Nutrisi

	Hasil Penilaian
A. Apakah anda mengalami penurunan asupan makanan dalam 3 bulan terakhir disebabkan kehilangan nafsu makan, gangguan saluran cerna, kesulitan mengunyah atau menelan? 0 = kehilangan nafsu makan berat (severe) 1 = kehilangan nafsu makan sedang (moderate) 2 = tidak kehilangan nafsu makan	
B. Kehilangan berat badan dalam tiga bulan terakhir? 0 = kehilangan BB > 3 kg 1 = tidak tahu 2 = kehilangan BB antara 1 – 3 kg 3 = tidak mengalami kehilangan BB	
C. Kemampuan melakukan mobilitas? 0 = di ranjang saja atau di kursi roda 1 = dapat meninggalkan ranjang atau kursi roda namun tidak bisa pergi/jalan-jalan ke luar 2 = dapat berjalan atau pergi dengan leluasa	
F. Menderita stress psikologis atau penyakit akut dalam tiga bulan terakhir? 0 = ya 2 = tidak	
E. Mengalami masalah neuropsikologis? 0 = demensia atau depresi berat 1 = demensia sedang (<i>moderate</i>) 2 = tidak ada masalah psikologis	
F. Nilai IMT (Indeks Massa Tubuh)? 0 = IMT < 19 kg/m² 1 = IMT 19 - 21 2 = IMT 21 – 23 3 = IMT > 23	

SUB-TOTAL	
------------------	--

Skor Skrining:

1. Sub total maksimal: 14
2. Jika nilai ≥ 12 artinya tidak mempunyai risiko,
3. Jika ≤ 11 artinya berisiko mengalami malnutrisi

Jika hasil skrining $\leq 11 \Rightarrow$ dilanjutkan ke formulir Penilaian

Tabel 5.10 Formulir Penilaian

	Hasil Penilaian
G. Apakah anda tinggal mandiri? (bukan di panti/Rumah Sakit)? 0 = tidak 1 = ya	
H. Apakah anda menggunakan lebih dari tiga macam obat per hari? 0 = ya 1 = tidak	
I. Apakah ada luka akibat tekanan atau luka di kulit? 0 = ya 1 = tidak	
J. Berapa kali anda mengonsumsi makan lengkap / utama per hari? 0 = 1 kali 1 = 2 kali 2 = 3 kali	
K. Berapa banyak anda mengonsumsi makanan sumber protein? • Sedikitnya 1 porsi <i>dairy</i> produk (seperti susu, keju, yogurt) per hari · ya/tidak • 2 atau lebih porsi kacang-kacangan atau telur per minggu · ya / tidak • Daging ikan atau unggas setiap hari · ya / tidak 0.0 = jika 0 atau hanya ada 1 jawaban ya 0.5 = jika terdapat 2 jawaban ya 1.0 = jika terdapat 3 jawaban ya	
L. Apakah anda mengonsumsi buah atau sayur sebanyak 2 porsi atau lebih per hari? 0 = tidak 1 = ya	

M. Berapa banyak cairan (air, jus, kopi, teh, susu) yang dikonsumsi per hari? 0.0 = kurang dari 3 gelas 0.5 = 3 – 5 gelas 1.0 = lebih dari 5 gelas	
N. Bagaimana cara makan? 0 = harus disuapi 1 = bisa makan sendiri dengan sedikit kesulitan 2 = makan sendiri tanpa kesulitan apapun juga	
O. Pandangan sendiri mengenai status gizi anda? 0 = merasa malnutrisi 1 = tidak yakin mengenai status gizi 2 = tidak ada masalah gizi	
P. Jika dibandingkan dengan kesehatan orang lain yang sebaya/seumur, bagaimana anda mempertimbangkan keadaan anda dibandingkan orang tersebut? 0 = tidak sebaik dia 0.5 = tidak tahu 1.0 = sama baiknya 2.0 = lebih baik	
Q. Lingkar lengan atas (cm)? 0 = < 21 cm 0.5 = 21 – 22 cm 1,0 = ≥22 cm	
R. Lingkar betis (cm)? 0 < 31 cm 1 > 31 cm	
TOTAL	

Intepretasi:

17 – 23,5 : risiko malnutrisi

Kurang dari 17 : malnutrisi

Sebagai peningkatan pengetahuan mahasiswa dalam hal melakukan pengkajian lansia, ada pengkajian yang dapat dilakukan kita sebagai tenaga kesehatan saat di masyarakat. Pengkajian tersebut dikenal dengan namanya SKILAS. SKILAS merupakan langkah skrining awal di setiap alur asuhan mengenai enam kondisi (mobilitas, nutrisi, penglihatan, pendengaran, fungsi kognitif dan psikologis) yang relevan di seluruh domain kapasitas intrinsik. Strategi untuk menjangkau lansia yang ada di komunitas, seperti kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan masyarakat

dan penilaian mandiri menggunakan teknologi ponsel, dapat digunakan untuk melakukan skrining tersebut.

Tabel 5.11 Skrining Lansia Sederhana (Skilas)

Kapasitas Instrinsik	Pertanyaan	Hasil	Interpretasi
Penurunan Kognitif	1. Orientasi tempat: mengingat tiga kata, contoh meja, kursi, jam 2. Orientasi waktu dan tempat, contoh "Tanggal berapa hari ini?"; "Dimana saat ini?" 3. Ulangi ketiga kata tadi	☐ Salah pada salah satu pertanyaan ☐ Tidak dapat mengulang ketiga kata	Jika lansia tidak dapat menjawab salah satu dari dua pertanyaan tentang orientasi ATAU tidak dapat mengingat ketiga kata, kemungkinan penurunan kognitif dan diperlukan penilaian lebih lanjut dengan menggunakan instrumen MMSE dan Mini-Cog
Keterbatasan Mobilisasi	3. Lansia dapat berdiri dari kursi sebanyak lima kali tanpa bantuan tangan 4. Lansia dapat berdiri dari kursi sebanyak 5 kali dalam 14 detik	☐ Tidak ☐ Ya, dorong lansia untuk mempertahankan gaya hidup sehat	Jika lansia tidak dapat melakukan tes sederhana berdiri dari kursi, maka diarahkan untuk pemeriksaan lebih lanjut menggunakan instrumen <i>Short Physical</i>

			dilakukan pemeriksaan lanjutan dengan menggunakan skrining audiometri atau tes aplikasi otomatis berbasis digital <i>in-noise</i>
Gejala Depresi	Selama dua minggu terakhir, apakah lansia merasa terganggu oleh: -Perasaan sedih, tertekan, atau putus asa -Sedikit minat atau kesenangan dalam melakukan sesuatu	☐ Ya ☐ Ya	Jika lansia menjawab (Ya) pada salah satu atau kedua pertanyaan, maka dibutuhkan penilaian lebih lanjut mengenai gejala depresinya

G. Latihan Soal

Pilihan Ganda

- Kemandirian lansia dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari dapat dinilai dengan pemeriksaan.....
A. Geriatric Depression Scale (GDS)
B. MMSE
C. SPMSQ
D. Barthel Index
E. TUG Test
- Ibu L usia 67 tahun tinggal dengan anak, mertua dan cucu. Dari hasil pemeriksaan khusus lansia didapatkan keluhan merasa tidak berdaya, merasa tidak berharga. Keluhan tersebut dapat ditemukan saat perawat melakukan pemeriksaan lansia.....
A. GDS

- B. MMSE
 - C. Pengkajian resiko jatuh
 - D. MNA
 - E. Barthel Index
3. Ibu F usia 80 tahun tinggal dengan anak, mertua dan cucu. Dari hasil pemeriksaan khusus gerontik, ditemukan nilai GDS : 12. Hasil tersebut menunjukkan....
- A. Fungsi kognitif baik
 - B. Fungsi kognitif buruk
 - C. Tidak ada gangguan depresi
 - D. Kemungkinan ada gangguan depresi
 - E. Gangguan depresi
4. Pemeriksaan Barthel Index memiliki tujuan....
- A. Penilaian kognitif lansia
 - B. Penilaian risiko jatuh lansia
 - C. Penilaian tingkat depresi lansia
 - D. Penilaian tingkat kemandirian lansia
 - E. Penilaian tingkat status nutrisi lansia
5. Pemeriksaan MMSE memiliki tujuan....
- A. Penilaian kognitif lansia
 - B. Penilaian risiko jatuh lansia
 - C. Penilaian tingkat depresi lansia
 - D. Penilaian tingkat kemandirian lansia
 - E. Penilaian tingkat status nutrisi lansia

Essay

1. Pemeriksaan MNA memiliki tujuan menilai kemampuan lansia dalam hal?
2. Hasil pemeriksaan MMSE pada lansia: 15. Hasil tersebut menunjukkan?
3. Seorang lansia sedang terbaring di tempat tidur, kondisi lemah, beberapa aktifitas dibantu oleh petugas panti. Hasil pemeriksaan ADL didapatkan nilai : 14. Hal tersebut menunjukkan?
4. Lansia dilakukan skrining nutrisi, hasil pengkajian yang didapatkan memiliki skor: 7. Hal tersebut menunjukkan lansia?
5. Seorang lansia mengalami gangguan mobilitas. Seorang perawat akan melakukan tindakan untuk mengatasi masalah mobilitasnya. Namun sebelum dilakukan tindakan, perawat melakukan pengkajian resiko jatuh. Hasil pengkajian

tersebut memiliki skor: 8. Berdasarkan hasil tersebut, dapat dibuat kesimpulan lansia mengalami?

Kunci Jawaban

1. D
2. A
3. E
4. D
5. A

H. Rangkuman Materi

Pengkajian gerontik merupakan proses sistematis dalam menilai kondisi biopsikososial, kognitif, emosional, dan fungsional pada lanjut usia (lansia). Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai status kesehatan lansia, mengidentifikasi masalah aktual maupun potensial, serta menentukan intervensi keperawatan yang tepat. Salah satu aspek penting dalam pengkajian gerontik adalah penilaian terhadap **fungsi kognitif, kondisi psikologis (terutama depresi), serta status nutrisi**.

Pengkajian kognitif dan status mental meliputi pengkajian AMT, *Mini Cog* dan *Clock Drawing Test (CDT4)*, *MMSE*, *SPMSQ*. Penilaian secara psikologis berupa pengkajian Geriatric Depression Scale (GDS). Sedangkan pengkajian status nutrisi berupa Mini Nutritional Assessment (MNA).

Secara keseluruhan, pengkajian gerontik merupakan langkah penting dalam asuhan keperawatan lansia. Melalui penggunaan instrumen-instrumen ini secara terpadu, perawat dapat mengenali perubahan yang terjadi pada lansia secara menyeluruh dan menyusun rencana intervensi yang tepat untuk meningkatkan kualitas hidup lansia.

I. Glosarium

Antipsikotik: obat yang digunakan untuk mengurangi gejala psikosis

Anti aritmia: obat yang digunakan untuk mencegah gangguan irama jantung

Cemas: tidak tenteram hati karena gelisah, kuatir

Diuretic: obat pendorong untuk memproduksi air seni

Demensia: gangguan kesehatan yang menyebabkan penurunan daya ingat

Hipotensi ortostatik: kondisi tekanan darah rendah akibat perubahan posisi tubuh misalnya duduk, berbaring

Inkontinen: ketidakmampuan mengendalikan kandung kemih sehingga terjadi pengeluaran urine secara tidak sengaja

Indeks Massa Tubuh (IMT): metode yang digunakan untuk mengetahui status gizi

Labil: tidak stabil, mudah berubah

Laksatif: obat yang digunakan untuk mengeluarkan tinja dari saluran pencernaan, pencahar

Neuroleptic: obat untuk mengurangi gejala psikotik

Nokturia: buang air kecil berlebihan pada malam hari

Osteoporosis: keadaan tulang yang menjadi keropos

Sedativa: zat yang dapat meredakan keatifan atau kegembiraan, penenang

Vasodilator: zat yang dapat menyebabkan pelebaran pembuluh darah

J. Referensi

Kementerian Kesehatan. (2017). *Juknis Instrumen: Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)*.

Miller, C.A. (2023). *Nursing for wellness in older adults*. 9th Edition. Philadelphia: Wolters Kluwer

WHO. (2019). *Asuhan Terpadu untuk Lansia (Integrated care for older people - ICOPE): Panduan penilaian dan alur layanan berbasis individu di layanan kesehatan primer*.

BAB 6

APLIKASI ASUHAN KEPERAWATAN PADA LANSIA DALAM KONTEKS INDIVIDU

Tujuan Instruksional Umum:

Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip pemberian asuhan keperawatan, menerapkan pemberian asuhan keperawatan pada lansia dengan kasus tertentu dan melaksanakan perawat sesuai kebutuhan lansia.

Tujuan Instruksional Khusus:

- Mahasiswa mampu memahami prinsip pemberian asuhan keperawatan
- Mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan pada lansia dengan kasus tertentu
- Mahasiswa mampu melaksanakan peran perawat dalam asuhan individu lansia.

Capaian Pembelajaran:

Kognitif: Mahasiswa memahami dan menganalisis proses keperawatan pada lansia

Psikomotor: Mahasiswa mampu melakukan tindakan keperawatan sesuai kebutuhan lansia

Afektif: mahasiswa mampu menunjukkan sikap peduli penuh kasih, empati dan menerapkan etika profesional dalam berinteraksi dengan lansia dan keluarga

Pendahuluan:

Lanjut usia merupakan fase akhir dalam siklus kehidupan manusia yang ditandai dengan perubahan secara biologi, psikologi, sosial dan spiritual. individu. Seiring dengan peningkatan angka harapan hidup, populasi lansia di seluruh dunia terus bertambah, termasuk di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia tercatat 10,8% dari total populasi dan diproyeksikan mengalami peningkatan tiap tahun (Badan Pusat Statistik, 2021). Kondisi ini tentu menimbulkan tantangan bagi dunia kesehatan, khususnya dalam bidang keperawatan gerontik (Azizah, 2020).

Proses penuaan sering kali disertai penurunan fungsi organ tubuh, meningkatnya risiko penyakit kronis, perubahan psikologi seperti mudah cemas atau depresi, serta

keterbatasan sosial akibat berkurangnya partisipasi dalam masyarakat (Potter, Perry, Stockert & Hall, 2021). Lansia tidak hanya menghadapi masalah kesehatan fisik tetapi juga harus menyesuaikan diri dengan perubahan peran keluarga, kehilangan pasangan hidup, maupun keterbatasan ekonomi (Nugraha & Pratiwi, 2020). Kompleksitas permasalahan yang dihadapi menjadikan lansia sebagai kelompok yang membutuhkan perhatian khusus dalam pelayanan kesehatan (WHO, 2021).

Perawat berperan dalam memberikan asuhan kepada lansia. Asuhan keperawatan tidak hanya berfokus pada aspek fisik dan penyakit yang diderita tetapi mencakup aspek kognitif, emosional, sosial dan spiritual (Black & Hawks, 2020). Pendekatan yang digunakan haruslah bersifat holistik, humanistik serta menempatkan lansia sebagai individu yang unik dengan kebutuhan dan pengalaman hidup yang berbeda (Friedman, Bowden & Jones, 2020).

Salah satu tantangan dalam pemberian asuhan keperawatan gerontik adalah bagaimana cara memberikan asuhan kepada lansia sesuai dengan penyakit yang dialami. Aplikasi asuhan keperawatan pada lansia harus dilakukan dalam konteks individu dengan menyesuaikan kondisi kesehatan, latar belakang budaya, nilai, preferensi serta kemampuan lansia (WHO, 2021; Susanti & Lestari, 2020). Dengan demikian, perawat tidak hanya sekadar memberikan perawatan tetapi turut serta melakukan pemberdayaan pada lansia agar lansia dapat mempertahankan tingkat kemandirian dan memiliki kualitas hidup yang optimal (Mulyani & Hartati, 2021).

Dalam bab ini akan disajikan prinsip pemberian asuhan keperawatan pada lansia, kasus-kasus yang ditemukan pada lansia mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi dan peran perawat dalam pemenuhan kebutuhan lansia. Susunan bab ini meliputi bagian pendahuluan, tujuan instruksional (umum dan khusus), capaian pembelajaran, serta materi yang terbagi ke dalam subbab disertai latihan soal.

Uraian Materi

Aplikasi asuhan keperawatan lansia dalam konteks individu berisi tentang prinsip pemberian asuhan keperawatan, studi kasus pada lansia dan peran perawat dalam asuhan keperawatan individu lansia.

A. Prinsip Pemberian Asuhan Keperawatan

1. Individualisasi Asuhan Berpusat pada Klien

Setiap lansia adalah individu yang unik dengan latar belakang, pengalaman hidup, budaya serta kondisi kesehatan yang berbeda. Perawat perlu menempatkan lansia sebagai pusat dari proses pelayanan. Lansia diberi ruang untuk ikut menentukan arah pengobatan dan perawatan, sehingga intervensi yang diberikan tidak terbatas pada pedoman medis, melainkan juga memperhatikan pandangan, nilai, dan tujuan hidup pasien. Dengan cara ini, lansia merasa lebih dihargai, berdaya, dan memiliki kontrol terhadap kehidupannya, yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan dan kualitas hidup. Oleh karena itu, asuhan keperawatan harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap lansia. Pendekatan yang bersifat seragam tidak selalu efektif sebab masalah kesehatan dan psikososial yang dialami lansia dapat berbeda. Sebagai contoh, lansia dengan hipertensi mungkin lebih membutuhkan edukasi diet rendah garam dan manajemen stres, sementara lansia dengan demensia lebih membutuhkan stimulasi kognitif dan dukungan keluarga. Individualisasi asuhan memungkinkan perawat memberikan intervensi yang lebih tepat sasaran, efektif dan bermakna bagi lansia.

2. Pendekatan holistik

Konsep holistik dalam keperawatan lansia berarti kita melihat individu sebagai satu kesatuan yang utuh, bukan hanya dari aspek fisik. Lansia harus dipandang dari dimensi bio-psiko-sosial-spiritual.

- a. Biologis: penanganan penyakit kronis, pencegahan komplikasi, serta peningkatan fungsi fisik.
- b. Psikologis: pendampingan emosional, stimulasi kognitif, manajemen stres, dan dukungan menghadapi perubahan psikologis.
- c. Sosial: peningkatan interaksi sosial melalui aktivitas kelompok, peran keluarga dan keterlibatan komunitas.
- d. Spiritual: memberikan kesempatan untuk beribadah, diskusi makna hidup dan penerimaan terhadap proses penuaan serta kematian

Dengan pendekatan holistik, lansia dapat merasakan kepuasan hidup yang lebih baik meskipun menghadapi keterbatasan fisik. Pendekatan ini mendukung terwujudnya konsep *healthy aging* yang diusung WHO (2020).

3. Humanistik dan Empatik

Asuhan keperawatan pada lansia harus menempatkan martabat manusia sebagai dasar utama. Lansia bukan hanya objek perawatan, tetapi subjek yang memiliki hak untuk menentukan pilihan hidupnya. Prinsip humanistik menekankan bahwa :

- a. Lansia memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai kesehatannya.
- b. Perawat perlu bersikap empatik, sabar, dan penuh penghargaan terhadap pengalaman hidup manusia.
- c. Komunikasi terapeutik harus dijaga dengan baik agar lansia merasa dihargai dan didengarkan

Dengan pendekatan humanistik dan empatik, lansia tidak merasa diperlakukan sebagai beban keluarga atau masyarakat, melainkan sebagai individu yang bermakna.

4. Peningkatan Kemandirian

Salah satu tujuan utama asuhan keperawatan lansia adalah mempertahankan serta meningkatkan kemandirian dalam aktivitas sehari-hari (*activity daily living*) meliputi kemampuan dalam makan, mandi, berpakaian, pergi ke toilet, berkemih, berpindah) dan aktivitas instrumental hidup sehari-hari (*instrumental activity daily living*) meliputi menggunakan telepon, berbelanja, menyiapkan makanan, mengelola obat-obatan, membersihkan dan merawat rumah, berpakaian, transportasi, mengelola keuangan). Meskipun lansia mengalami keterbatasan secara fisik dan secara kognitif, perawat harus berupaya agar lansia tetap mampu melakukan hal-hal sederhana seperti makan, berpakaian, berjalan dengan alat bantu, atau melakukan perawatan diri.

Peningkatan kemandirian memiliki manfaat penting, antara lain :

- a. Mengurangi ketergantungan pada orang lain.
- b. Meningkatkan rasa percaya diri.
- c. Mengurangi risiko depresi akibat rasa tidak berdaya.
- d. Meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

5. Pendekatan kolaboratif

Asuhan keperawatan pada lansia tidak bisa dilakukan oleh perawat saja tetapi diperlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan keluarga sebagai pendukung utama dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, tim kesehatan seperti dokter, fisioterapis, ahli gizi, psikolog, pekerja sosial dan komunitas seperti

posyandu lansia, kelompok sosial, atau organisasi keagamaan yang memberi dukungan moral dan sosial. Kolaborasi ini menciptakan lingkungan yang kondusif untuk lansia agar dapat hidup lebih sehat, aktif, dan bermakna.

6. Prinsip Etik dan Legal dalam Asuhan Keperawatan Lansia

Selain prinsip di atas, perawat juga harus berpegang pada etika keperawatan, yaitu *autonomi, beneficence, non-maleficence, justice, veracity, dan fidelity*. Etika berfungsi sebagai panduan moral dalam interaksi antara perawat dan klien.

a. Autonomi

Perawat wajib menghargai hak lansia dalam membuat keputusan terkait kesehatannya. Sebagai contoh, pada lansia dengan keterbatasan kognitif, perawat tetap memberikan informasi sederhana dan jelas agar lansia merasa dilibatkan (Potter et. al., 2021).

b. *Beneficence*

Intervensi keperawatan yang diberikan bertujuan untuk kebaikan lansia seperti meningkatkan kenyamanan, mencegah komplikasi, dan memperbaiki kualitas hidup (Stanhiye & Lancaster, 2020).

c. *Non-maleficence*

Perawat harus menghindari tindakan yang dapat merugikan atau membahayakan lansia baik secara fisik maupun psikologis. Misalnya, memastikan keamanan lingkungan agar lansia tidak jatuh.

d. *Justice*

Pelayanan diberikan tanpa diskriminasi berdasarkan usia, jenis kelamin, status sosial maupun kondisi kesehatan. Hal ini sejalan dengan prinsip *age-friendly care* yang ditekankan WHO (2020).

e. *Veracity*

Kejujuran sangat penting dalam memberikan informasi tentang kondisi kesehatan lansia. Informasi yang disampaikan harus akurat agar lansia dan keluarga dapat membuat keputusan yang tepat.

f. *Fidelity*

Perawat memiliki tanggung jawab menjaga kepercayaan lansia, termasuk memegang teguh janji, bersikap konsisten, dan menjaga kerahasiaan data kesehatan (Watson & Woodward, 2022).

Selain etika, aspek hukum juga berperan penting dalam memberikan perlindungan bagi lansia maupun perawat.

a. Persetujuan tindakan (*informed consent*)

Setiap tindakan medis dan keperawatan harus mendapatkan persetujuan lansia atau keluarga. Persetujuan harus diberikan secara sadar, sukarela, dan

berdasarkan informasi yang jelas. Bila lansia memiliki keterbatasan kognitif, keluarga dapat menjadi pengambil keputusan. Hal ini sesuai yang tertera pada Undang-undang No. 36 tahun 2009.

b. Hak Lansia

Berdasarkan regulasi yang tertuang dalam UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia, para lansia dijamin haknya untuk memperoleh layanan kesehatan, perlindungan sosial, dan kesempatan aktif di masyarakat. Ketentuan ini mempertegas peran perawat dalam melaksanakan asuhan yang berkeadilan dan bermartabat. Hal ini memperkuat kewajiban perawat dalam memberikan asuhan yang adil dan bermartabat.

c. Perlindungan Hukum bagi Perawat

Perawat bertanggung jawab memberikan pelayanan sesuai standar profesi. Tindakan yang lalai atau di luar kewenangan dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Oleh karena itu, kepatuhan pada kode etik keperawatan dan regulasi hukum mutlak diperlukan (Kemenkes RI, 2021)

d. Dokumentasi Keperawatan

Setiap tindakan keperawatan harus didokumentasikan secara akurat, lengkap, dan sesuai standar. Dokumentasi tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi antar tenaga kesehatan, tetapi juga memiliki nilai legal sebagai bukti pertanggungjawaban profesional (Potter et. al., 2021).

e. Kerahasiaan Informasi

Perawat wajib menjaga kerahasiaan data kesehatan lansia. Informasi hanya dapat dibuka dengan izin lansia, kecuali untuk kepentingan medis atau perintah hukum.

Aspek etik dan legal merupakan fondasi penting dalam pemberian asuhan keperawatan pada lansia. Dengan mengintegrasikan prinsip etik dan legal, asuhan keperawatan yang diberikan berkeadilan dan menjunjung tinggi martabat manusia.

B. Aplikasi Kasus Asuhan Keperawatan pada Lansia

1. Kasus I : Lansia dengan Hipertensi

Lansia perempuan, usia 68 tahun mengeluh kadang-kadang merasa pusing, memiliki riwayat hipertensi sejak tahun 2018. Hipertensi disebabkan karena suka konsumsi makanan yang asin. Saat ini, lansia konsumsi obat rutin amlodipin 5 gram dan vitamin B kompleks. Hasil pengukuran tanda vital : tekanan darah 145/90 mmHg, nadi 80 x/menit, frekuensi napas 19 x/menit, suhu 36⁰C.

Pengkajian :

- a. Aspek fisik : tingkat kemandirian diukur menggunakan indeks katz diperoleh mandiri dalam hal mandi, makan, kontinen, toileting, berpakaian dan berpindah); berat badan 54 kg dengan tinggi badan 147 cm (IMT = 25 (normal)); postur tulang belakang tegap, lansia memerlukan waktu ≥ 14 detik sehingga 87% berisiko tinggi untuk jatuh; kualitas tidur kurang karena sering terjaga dan sulit tidur.
- b. Aspek psikologi : fungsi intelektual utuh, tidak ada gangguan kognitif, lansia tidak mengalami depresi.
- c. Aspek sosial : komunikasi dengan keluarga berjalan baik, hubungan dengan sebaya baik, tidak pernah bermasalah dengan masyarakat sekitar.
- d. Aspek spiritual : lansia berpartisipasi aktif dalam kegiatan keagamaan, selalu beribadah.

Diagnosa keperawatan

- a. Risiko perfusi serebral tidak efektif dibuktikan dengan hipertensi.
- b. Gangguan pola tidur berhubungan dengan kurangnya kontrol tidur dibuktikan dengan mengeluh sering terjaga dan sulit tidur.
- c. Risiko jatuh dibuktikan dengan usia ≥ 65 tahun.

Intervensi keperawatan:

- a. L.02014 Perfusi Serebral

Perfusi serebral meningkat dengan kriteria hasil sakit kepala menurun, tekanan darah sistolik membaik, tekanan darah diastolik membaik.

I.02060 Pemantauan Tanda Vital

- 1) Monitor tekanan darah
- 2) Dokumentasikan hasil pemantauan
- 3) Jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan

- b. L.05045 Pola Tidur

Pola tidur membaik dengan kriteria hasil keluhan sulit tidur menurun dan keluhan sering terjaga menurun.

I.05174

- 1) Identifikasi pola aktivitas dan tidur
- 2) Lakukan prosedur untuk meningkatkan kenyamanan
- 3) Ajarkan relaksasi autogenik atau cara nonfarmakologi lainnya

- c. L.14138 Tingkat Jatuh

Tingkat jatuh menurun dengan kriteria hasil jatuh dari tempat tidur menurun, jatuh saat berdiri menurun, dan jatuh saat berjalan menurun.

I.14540 Pencegahan Jatuh

- 1) Identifikasi faktor risiko jatuh
- 2) Gunakan alat bantu berjalan

3) Anjurkan menggunakan alas kaki yang tidak licin

2. Kasus II : Lansia dengan Diabetes Melitus

Lansia perempuan, usia 60 tahun mengatakan sering merasa haus dan lapar. Lansia memiliki riwayat diabetes melitus sejak 10 tahun yang lalu setelah memiliki anak ketiga. Lansia sering merasa lelah dan mudah lemas. Lansia mengatakan jarang memeriksakan kadar gula darah secara rutin dan jarang minum obat rutin. Kadar glukosa darah 347 mg/dl (diukur setelah makan). Tiga minggu yang lalu lansia mengeluh penglihatan kabur dan kaki terasa kebas. Kekuatan otot tangan kanan dan kiri 5 sedangkan kaki kanan dan kiri 4. Rentang gerak maksimal terbatas, lutut terasa gemetar, saat berjalan atau berdiri terlalu lama mengeluh nyeri dan sempoyongan sehingga takut jatuh.

Pengkajian

- a. Aspek fisik : tingkat kemandirian diperoleh kategori A dengan interpretasi lansia dapat melakukan enam aktivitas meliputi mandi, berpakaian, makan, kontinen, toileting, dan berpindah. Lansia mampu naik dan turun tangga secara mandiri. Lansia membutuhkan waktu 16 detik untuk melakukan pengkajian risiko jatuh. Lansia memiliki kualitas tidur kurang karena merasakan nyeri hilang timbul pada tumit dengan skala nyeri 2 sehingga sering terbangun untuk buang air kecil saat malam hari.
- b. Aspek psikologis : fungsi intelektual utuh, tidak terdapat gangguan kognitif, orientasi maksimal, registrasi baik, atensi dan kalkulasi baik, pengenalan kembali baik, dan bahasa baik.
- c. Aspek sosial : hubungan dengan keluarga baik, ada komunikasi dan perhatian yang diberikan oleh keluarga pada lansia.
- d. Aspek spiritual : lansia mengatakan rajin beribadah dan rutin mengikuti acara keagamaan di wilayahnya.

Diagnosa Keperawatan

- a. Risiko jatuh dibuktikan dengan perubahan kadar glukosa darah.
- b. Ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan hiperinsulinemia dibuktikan dengan mengeluh lapar, gemetar, haus meningkat, jumlah urin meningkat, kadar glukosa dalam darah tinggi.
- c. Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri dibuktikan dengan kekuatan otot menurun, gerakan terbatas.

Intervensi keperawatan

- a. L.14136 Tingkat Cedera

Tingkat cedera menurun dengan kriteria hasil gangguan mobilitas menurun, kejadian cedera menurun.

- I.12416 Edukasi Pengurangan Risiko

- 1) Identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi
 - 2) Sediakan materi dan media pendidikan kesehatan
 - 3) Berikan kesempatan untuk bertanya
 - 4) Ajarkan pencegahan cedera
- b. L.03022 Kestabilan Kadar Glukosa Darah
- Ketidakstabilan kadar glukosa darah meningkat dengan kriteria hasil gemetar menurun, kadar glukosa dalam darah membaik, rasa lapar menurun, rasa haus menurun, lelah menurun.
- I.03115 Manajemen Hiperglikemia
- 1) Identifikasi kemungkinan penyebab hiperglikemia
 - 2) Monitor kadar gula darah jika perlu
 - 3) Konsultasi dengan medis jika tanda dan gejala hiperglikemia tetap ada atau memburuk
 - 4) Anjurkan kepatuhan terhadap diet dan olahraga
 - 5) Ajarkan pengelolaan diabetes
 - 6) Kolaborasi pemberian insulin, jika perlu
- c. L.05042 Mobilitas Fisik
- Mobilitas fisik meningkat dengan kriteria hasil kekuatan otot meningkat, gerakan terbatas menurun.
- I.05184 Teknik Latihan Penguatan Otot
- 1) Identifikasi risiko latihan
 - 2) Monitor efektifitas latihan
 - 3) Berikan instruksi tertulis tentang pedoman dan bentuk gerakan untuk setiap gerakan otot
 - 4) Jelaskan fungsi otot, fisiologi olahraga, dan konsekuensi tidak digunakannya otot
 - 5) Kolaborasi dengan tim kesehatan lain, misal terapis aktivitas

3. Kasus III : Lansia dengan Anoreksia Geriatri

Lansia laki-laki, usia 62 tahun dirawat di bangsal geriatri. Selama satu minggu keluarga mengatakan lansia mengalami penurunan nafsu makan. Setiap hari hanya makan bubur satu porsi dan satu gelas teh hangat. Lansia mengatakan sulit menelan dan menguyah, cepat kenyang dan lemas, badan lesu, aktivitas hanya di atas tempat tidur. Lansia mengeluh mudah lelah. Berat badan sebelum sakit 50 kg, setelah sakit 44 kg. Tingkat kesadaran compos mentis, gelisah, tekanan darah 130/90 mmHg, nadi 65 x/menit, frekuensi napas 24 x/menit. Hasil pemeriksaan fisik diperoleh mukosa mulut agak kering, konjungtiva anemis, kekuatan otot tangan kanan dan kiri 4, kekuatan otot kaki kanan dan kiri 4. Lansia

memiliki riwayat hipertensi 10 tahun yang lalu dan pernah rawat inap karena stroke.

Pengkajian :

- a. Aspek fisik : aktivitas sehari-hari seluruhnya dibantu oleh keluarga sehingga masuk dalam kategori ketergantungan. Kualitas tidur baik karena sebagian aktivitas dilaksanakan di atas tempur tidur.
- b. Aspek psikologi : lansia mengingat nama dan tanggal lahir, lansia masih memiliki fungsi kognitif yang baik. Lansia sering bercengkrama dengan keluarga, tetapi cenderung diam.
- c. Aspek sosial : keluarga sangat khawatir akan kondisi lansia. Keluarga mengatakan selama sakit, lansia diam saja tetapi jika diajak berbicara mau merespon.
- d. Aspek spiritual : lansia menjalankan ibadah sesuai keyakinannya.

Diagnosa keperawatan

- a. Defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan mencerna makanan dibuktikan dengan berat badan menurun minimal 10% di bawah rentang ideal, nafsu makan menurun.
- b. Gangguan menelan berhubungan dengan gangguan serebrovaskuler dibuktikan dengan mengeluh sulit menelan, sulit mengunyah.
- c. Intoleran aktivitas berhubungan dengan tirah baring dibuktikan dengan mengeluh lelah, merasa lemah.

Intervensi keperawatan

- a. L.03030 Status Nutrisi

Status nutrisi membaik dengan kriteria porsi makanan yang dihabiskan meningkat, kekuatan otot pengunyah meningkat, kekuatan otot menelan meningkat, perasaan cepat kenyang menurun, nafsu makan membaik.

I.03119 Manajemen Nutrisi

- 1) Identifikasi status nutrisi
- 2) Identifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutrisi
- 3) Lakukan oral hygiene, bila perlu
- 4) Berikan makanan tinggi serat untuk mencegah konstipasi
- 5) Ajarkan diet yang diprogramkan
- 6) Kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrisi yang dibutuhkan, jika perlu

- b. L.06052 Status Menelan

Status menelan membaik dengan kriteria hasil kemampuan mengunyah meningkat, usaha menelan meningkat, gelisah menurun.

I.03125 Pemberian Makanan

- 1) Identifikasi kemampuan menelan
 - 2) Berikan posisi duduk atau semi fowler saat makan
 - 3) Berikan makanan hangat jika memungkinkan
 - 4) Anjurkan keluarga membantu memberi makan kepada lansia
 - 5) Kolaborasi pemberian antiemetik sebelum makan, bila perlu
- c. L.05047 Toleransi Aktivitas
- Toleransi aktivitas meningkat dengan kriteria hasil kemudahan melakukan aktivitas sehari-hari, keluhan lelah menurun.
- 1) Identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan
 - 2) Monitor kelelahan fisik dan emosional
 - 3) Lakukan latihan rentang gerak pasif dan/atau aktif
 - 4) Anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap
 - 5) Kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan

4. Kasus IV : Lansia dengan Demensia

Lansia perempuan, 65 tahun, dirawat oleh keluarga. Keluarga mengatakan lansia lupa saat ditanya habis melakukan apa, tidak bisa mengancingkan baju dan tidak bisa menghidupkan televisi. Ketika diajak keluar rumah, lansia harus didampingi, keluarga takut jika lansia pergi sendiri tidak bisa pulang ke rumah.

Pengkajian

- a. Aspek fisik : lansia memiliki keterbatasan dalam berpakaian, mandi dibantu oleh keluarga, makan disuapi, tidak dapat menahan kencing sebelum sampai toilet namun dapat berpindah secara mandiri dan mampu pergi ke toilet. Lansia memiliki kualitas tidur yang baik, tidak mengalami permasalahan dalam pola tidur.
- b. Aspek psikologi : hasil pengkajian MMSE kemungkinan terdapat gangguan kognitif, lansia tidak dapat melakukan perhitungan sederhana, lupa kata yang baru saja diucapkan, tidak bisa menyebutkan nama benda yang diminta. SPMSQ diinterpretasikan kerusakan intelektual sedang.
- c. Aspek sosial : lansia cenderung mengurung diri di kamar, jarang berbicara dengan keluarga, tidak betah bercakap-cakap lama. Hasil pengkajian depresi menggunakan *inventaris depresi beck* (IDB), lansia mengalami depresi ringan. Keluarga over protektif karena kondisi lansia.
- d. Aspek spiritual : lansia bersama keluarga pergi bersama untuk beribadah.

Diagnosa keperawatan

- a. Gangguan memori berhubungan dengan proses penuaan dibuktikan dengan tidak mampu mengingat peristiwa, lupa melakukan perilaku pada waktu yang telah dijadwalkan.

- b. Inkontinensia urine fungsional berhubungan dengan dibuktikan dengan mengompol sebelum mencapai toilet.
- c. Defisit perawatan diri berhubungan dengan gangguan psikologis dibuktikan dengan tidak mampu mandi, berpakaian.

Intervensi keperawatan

a. I.09096 Tingkat Demensia

Tingkat demensia menurun dengan kriteria hasil kemampuan mengingat peristiwa saat ini membaik, kemampuan mempertahankan percakapan, interaksi sosial membaik.

I.06188 Latihan Memori

- 1) Monitor perilaku dan perubahan memori selama terapi
- 2) Stimulasi memori dengan mengulang pikiran yang terakhir kali diucapkan, jika perlu
- 3) Stimulasi memori menggunakan memori pada peristiwa yang baru saja terjadi, jika perlu
- 4) Ajarkan teknik memori yang tepat
- 5) Rujuk pada terapi okupasi, jika perlu

b. L.04036 Kontinensia Urine

Kontinensia urine membaik dengan kriteria hasil kemampuan mengontrol pengeluaran urine meningkat, sensasi berkemih membaik.

I.04163 Perawatan Inkontinensia Urine

- 1) Identifikasi perasaan dan persepsi lansia inkontinensia urine yang dialaminya
- 2) Berikan pujian atas keberhasilan mencegah inkontinensia
- 3) Jelaskan program penanganan inkontinensia urine
- 4) Rujuk ke ahli inkontinensia, jika perlu

c. L.11103 Perawatan Diri

Perawatan diri meningkat dengan kriteria hasil kemampuan mandi meningkat, kemampuan mengenakan pakaian meningkat, kemampuan makan meningkat.

I.11348 Dukungan Perawatan Diri

- 1) Monitor tingkat kemandirian
- 2) Dampingi dalam melakukan perawatan diri sampai mandiri
- 3) Fasilitasi kemandirian
- 4) Anjurkan melakukan perawatan diri secara konsisten sesuai kemampuan

C. Peran perawat dalam asuhan individu lansia

Perawat perlu mengintegrasikan peran sebagai educator, care provider, advokat, kolaborator dan berbagai peran lainnya agar kebutuhan lansia terpenuhi secara optimal.

1. Peran dalam Aspek Fisik

Proses penuaan menimbulkan perubahan nyata pada fungsi organ dan kemampuan fungsional lansia. Perawat berperan penting dalam mempertahankan dan meningkatkan kapasitas fisik agar lansia tetap mandiri.

Peran perawat meliputi:

- a. Care provider: memberikan asuhan keperawatan dasar seperti pemantauan tanda vital, manajemen nyeri, perawatan luka, dan pemeliharaan kebersihan diri.
- b. Educator: memberikan edukasi tentang pola makan sehat, aktivitas fisik teratur, dan kepatuhan terapi penyakit kronis.
- c. Kolaborator: bekerja sama dengan fisioterapis, ahli gizi, dan dokter untuk meningkatkan status kesehatan fisik lansia.
- d. Rehabilitator: melatih mobilitas melalui senam lansia, Latihan pernapasan, atau Latihan kekuatan ringan agar tidak mudah jatuh dan tetap aktif.

2. Peran dalam Aspek Psikologis

Lansia kerap mengalami kecemasan, depresi, atau penurunan fungsi kognitif. Perawat harus mendampingi agar lansia merasa dihargai dan tidak terisolasi.

Peran perawat meliputi:

- a. Counselor: memberikan konseling sederhana untuk mengatasi perasaan kesepian, kehilangan pasangan, atau stress akibat perubahan peran sosial.
- b. Motivator: mendorong lansia untuk tetap aktif dalam kegiatan sosial, hobi, dan aktivitas sehari-hari.
- c. *Screening*: melakukan deteksi dini gangguan kognitif menggunakan instrument seperti *mini mental state examination* (MMSE) atau *short portable mental status questionnaire* (SPMSQ) serta merujuk bila diperlukan.
- d. Supporter: memberi dukungan emosional, menjadi pendengar aktif dalam kegiatan sosial, hobi, dan aktivitas sehari-hari

3. Peran dalam Aspek Spiritual

Spiritualitas merupakan kebutuhan mendasar lansia yang membantu mereka menemukan makna hidup, menerima penuaan, dan menghadapi kematian dengan tenang.

Peran perawat meliputi:

- a. *Caring healer*: mengaplikasikan teori Caring oleh Jean Watson yang menekankan penghargaan terhadap martabat manusia, kepedulian, dan hubungan transpersonal.
- b. Fasilitator spiritual: memfasilitasi lansia untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya, seperti mengingatkan waktu ibadah atau membantu menyiapkan alat ibadah.
- c. *Comforter*: memberikan kenyamanan batin melalui pendekatan empatik. Sentuhan manusiawi dan komunikasi penuh kasih.
- d. Pendamping akhir hayat: mendampingi lansia dalam menghadapi fase terminal agar tetap bermartabat (*dying with dignity*).

4. Peran dalam Aspek Sosio-Ekonomi

Aspek ini mempengaruhi kualitas hidup lansia, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar, akses layanan kesehatan, dan keberfungsian sosial.

Peran perawat meliputi:

- a. Advokat: membela hak lansia untuk memperoleh pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi usia.
- b. Fasilitator sosial: menghubungkan lansia dengan program yang ada di komunitas seperti posyandu lansia, kelompok senam, atau kegiatan sosial lain.
- c. *Empowerer*: memberdayakan lansia agar tetap produktif sesuai kemampuan, misalnya dalam kegiatan kerajinan, berkebun, atau usaha kecil, sehingga meningkatkan kemandirian ekonomi.
- d. Kolaborator: bekerja sama dengan pekerja sosial, keluarga, dan organisasi Masyarakat untuk menjamin lansia mendapatkan dukungan sosial-ekonomi.

D. Latihan Soal

1. Seorang lansia, 80 tahun dirawat di bangsal geriatric karena serangan stroke dan mengalami penurunan kesadaran. Keluarga mengatakan saat di rumah dan diberikan makanan melalui mulut, lansia selalu tersedak. Saat ini terpasang selang NGT di hidung sebelah kanan. Perawat datang ke kamar lansia tersebut dan memberikan makan secara parenteral diawali dengan menjelaskan tujuan dan prosedur pemberian makan kepada pasien. Aspek legal etik yang dilakukan perawat sesuai kasus adalah....
 - A. *Justice*
 - B. *Fidelity*
 - C. *Veracity*
 - D. *Autonomi*
 - E. *Beneficience*

2. Seorang lansia, 75 tahun mengeluh mual, muntah 3x hari ini dan tidak memiliki makan, berat badan turun 5,5 kg yang semulanya 48 menjadi 42 kg. Lansia mengatakan badannya sangat lemas dan tidak mampu melakukan aktivitas seperti biasanya, hanya berbaring di tempat tidur. Diagnosa keperawatan prioritas sesuai kasus adalah....
- A. Nausea
 - B. Keletihan
 - C. Defisit nutrisi
 - D. Risiko defisit nutrisi
 - E. Gangguan rasa nyaman
3. Seorang lansia, 68 tahun tinggal bersama keluarga. Kondisi saat ini lansia mengalami kontraktur karena terlalu lama berbaring di tempat tidur dan jarang dimiringkan ke kanan dan kiri. Perawat home care datang melakukan pengkajian secara komprehensif dan segera memberikan perawatan sesuai dengan kebutuhan lansia dan memonitor perkembangan lansia setelah diberikan intervensi. Peran perawat yang tergambar sesuai kasus adalah....
- A. Motivator
 - B. *Conseulor*
 - C. Kolaborator
 - D. Rehabilitator
 - E. *Care provider*
4. Seorang lansia, 65 tahun dirawat di bangsal geriatri karena anoreksia geriatri. Perawat telah menjelaskan bahwa perlu dilakukan pemasangan NGT untuk membantu pemenuhan nutrisi. Lansia menolak karena sudah pernah dilakukan pemasangan alat tersebut satu tahun yang lalu karena kondisi yang sama sehingga merasa tidak nyaman. Prinsip etik yang diterapkan dalam kasus adalah....
- A. Justice
 - B. Fidelity
 - C. Veracity
 - D. Autonomi
 - E. Beneficience
5. Seorang lansia, 76 tahun dirawat di panti wreda. Saat dikaji, lansia sering lupa waktu, tidak mengenali anggota keluarga yang datang berkunjung, dan terlihat bingung saat berada di lingkungan baru. Lansia juga sering meninggalkan

makanan di meja tanpa menyadari belum dimakan. Apakah tindakan selanjutnya yang dilakukan perawat?

- A. Monitor perilaku dan perubahan memori selama terapi
- B. Stimulasi memori dengan mengulang pikiran yang terakhir kali diucapkan, jika perlu
- C. Stimulasi memori menggunakan memori pada peristiwa yang baru saja terjadi
- D. Ajarkan teknik memori yang tepat
- E. Rujuk pada terapi okupasi

Kunci Jawaban

1. Jawaban E. *Beneficience*

Perawat melakukan perbuatan baik sesuai kebutuhan lansia.

2. Jawaban C. Defisit nutrisi

Pada data ada penurunan berat badan lebih dari 10% ditambah dengan tidak memiliki nafsu makan. Tanda gejala ini menjelaskan bahwa lansia memiliki nutrisi yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolisme.

3. Jawaban E. Care provider

Perawat sebagai care provider memberikan asuhan keperawatan menggunakan pendekatan proses keperawatan, meliputi pengkajian sampai dengan evaluasi.

4. Jawaban D. Autonomi

Autonomi berarti setiap individu, termasuk lansia, memiliki hak untuk membuat keputusan sendiri mengenai perawatan kesehatannya setelah mendapatkan informasi yang lengkap dan jelas dari tenaga kesehatan.

5. Jawaban C. Stimulasi memori menggunakan memori pada peristiwa yang baru saja terjadi

Perawat sudah melakukan pengkajian dan monitoring kognitif pada lansia sehingga intervensi selanjutnya yang dilakukan adalah intervensi keperawatan terapeutik.

E. Rangkuman Materi

Asuhan keperawatan pada lansia merupakan proses pemberian pelayanan yang berfokus pada individu, dengan memperhatikan perubahan biologis, psikologis, sosial, dan spiritual yang terjadi akibat proses penuaan. Lansia tidak hanya dipandang sebagai pasien dengan penyakit tertentu, tetapi sebagai individu yang memiliki kebutuhan holistik dan hak untuk dihargai martabatnya. Aplikasi asuhan keperawatan pada lansia dalam konteks individu bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, mempertahankan kemandirian, serta memberikan makna positif terhadap proses penuaan. Perawat memiliki peran strategis dalam

memastikan lansia tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga dapat menikmati hidup dengan bermartabat, sehat, dan sejahtera, termasuk penerapan aspek etik dan legal yang menjadi landasan penting dalam praktik keperawatan lansia.

F. Glosarium

Autonomi: menghargai individu saat mengambil keputusan setelah mendapatkan informasi yang jelas.

Beneficience: peran perawat melakukan kebaikan yang bermanfaat demi pemulihan.

Caring healer: peran perawat sebagai penyembuh.

Comforter: peran perawat sebagai pemberi kenyamanan baik secara fisik, psikologis maupun spiritual.

Demensia: sindrom klinis berupa penurunan fungsi kognitif.

Empowerer: peran perawat dalam mengembangkan potensi dan memberikan kesempatan lansia meningkatkan kemandirian.

Fidelity: setia terhadap komitmen dan bertanggungjawab sebagai perawat.

Holistik: melihat individu secara keseluruhan.

Humanistik: memandang individu sebagai sesuatu yang unik.

Justice: berlaku adil tanpa diskriminasi.

Kontinen: tidak mampu buang air kecil.

Inkontinensa urine: keluarnya urine secara tidak sadar.

Non-Maleficience Toileting: pergi ke toilet.

Screening: deteksi dini untuk menemukan masalah kesehatan.

Supporter: peran perawat dalam mendampingi lansia.

Veracity: jujur, terbuka dan jelas dalam memberikan informasi.

G. Referensi

Azizah, L. M. (2020). Keperawatan gerontik: Konsep dan praktik asuhan keperawatan pada lanjut usia. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Badan Pusat Statistik. (2021). Statistik penduduk lanjut usia 2021. Jakarta: BPS RI.

Black, B. P., & Hawks, J. H. (2020). Medical-surgical nursing: Clinical management for positive outcomes (10th ed.). Elsevier.

Friedman, M. M., Bowden, V. R., & Jones, E. G. (2020). Family nursing: Research, theory, and practice (6th ed.). Pearson.

Kementerian Kesehatan RI. (2021). Standar Profesi dan Etik Keperawatan di Indonesia. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

- Livana, P. H., & Sutrisno. (2020). *Keperawatan Gerontik: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mulyani, S., & Hartati, T. (2021). Hubungan aktivitas fisik dengan kualitas hidup lansia. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 24(3), 175–182. <https://doi.org/10.7454/jki.v24i3.947>
- Nugraha, D. P., & Pratiwi, I. (2020). Faktor yang memengaruhi depresi pada lansia: Tinjauan literatur. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 9(1), 12–20. <https://doi.org/10.36565/jik.v9i1.123>
- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P. A., & Hall, A. M. (2021). *Fundamentals of Nursing* (10th ed.). St. Louis, MO: Elsevier.
- Stanhope, M., & Lancaster, J. (2020). *Public Health Nursing: Population-Centered Health Care in the Community* (10th ed.). St. Louis, MO: Elsevier.
- Susanti, H., & Lestari, R. (2020). Peran keluarga dalam meningkatkan kualitas hidup lansia dengan hipertensi. *Jurnal Ners*, 15(2), 220–228. <https://doi.org/10.20473/jn.v15i2.2020.220-228>
- Tim Pokja SIKI DPP PPNI. (2018). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia: Definisi dan Tindakan Keperawatan*. Jakarta: Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- Tim Pokja SIKI DPP PPNI. (2019). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia: Definisi dan Tindakan Keperawatan*. Jakarta: Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- Tim Pokja SLKI DPP PPNI. (2017). *Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan*. Jakarta: Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Watson, J., & Woodward, T. (2022). Jean Watson's Theory of Human Caring. In M. R. Alligood (Ed.), *Nursing Theorists and Their Work* (10th ed., pp. 87–110). St. Louis, MO: Elsevier.
- World Health Organization (WHO). (2020). *Decade of Healthy Ageing: Baseline report*. Geneva: World Health Organization.
- World Health Organization. (2021). *Decade of healthy ageing: Baseline report*. Geneva: WHO. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240017900>

BAB 7

APLIKASI ASUHAN KEPERAWATAN PADA LANSIA DALAM KONTEKS KELOMPOK

Tujuan Intruksional:

- **Menjelaskan Konsep Keperawatan Kelompok Lansia:** Mahasiswa dapat menjelaskan dasar konsep keperawatan kelompok lansia, perbedaan antara perawatan individu dan kelompok, serta prinsip-prinsip yang digunakan dalam perawatan kelompok lansia.
- **Mengevaluasi Kebutuhan Kesehatan Lansia dalam Kelompok:** Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan kesehatan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual dari lansia dalam kelompok, serta memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan mereka.
- **Menyusun Rencana Asuhan Keperawatan Kelompok Lansia:** Mahasiswa dapat menyusun rencana intervensi keperawatan yang melibatkan pendekatan kelompok untuk mengatasi masalah kesehatan lansia, termasuk program pencegahan, promosi kesehatan, dan pengelolaan penyakit kronis.
- **Mengimplementasikan Asuhan Keperawatan Kelompok Lansia:** Mahasiswa dapat melaksanakan intervensi keperawatan untuk lansia dalam konteks kelompok, dengan mempertimbangkan dinamika kelompok dan kebutuhan individual lansia dalam kelompok tersebut.
- **Melakukan Evaluasi Keperawatan Kelompok Lansia:** Mahasiswa dapat melakukan evaluasi terhadap efektivitas intervensi yang diterapkan dalam kelompok lansia, dengan menggunakan indikator yang sesuai untuk menilai perubahan kondisi fisik, psikologis, dan sosial lansia.
- **Mengidentifikasi Tantangan dan Solusi dalam Keperawatan Kelompok Lansia:** Mahasiswa dapat mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam mengelola asuhan keperawatan kelompok lansia dan merumuskan solusi yang sesuai untuk mengatasi tantangan tersebut.

Capaian Pembelajaran:

- **Memahami Konsep Dasar Keperawatan Kelompok Lansia:**
 1. Mampu menjelaskan definisi dan prinsip dasar keperawatan kelompok lansia.

2. Mampu mengidentifikasi perbedaan antara keperawatan individu dan kelompok dalam konteks lansia.
- **Mengidentifikasi Kebutuhan Kesehatan Lansia dalam Kelompok:**
 1. Mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan lansia dalam kelompok, termasuk perubahan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual.
 2. Mampu melakukan pengkajian kelompok untuk menentukan kebutuhan kesehatan lansia dalam konteks kelompok.
 - **Menyusun Rencana Asuhan Keperawatan untuk Kelompok Lansia:**
 1. Mampu menyusun rencana asuhan keperawatan kelompok yang mencakup tujuan, intervensi, dan evaluasi yang sesuai untuk kelompok lansia berdasarkan hasil pengkajian.
 2. Mampu merancang program promosi kesehatan dan pencegahan penyakit untuk kelompok lansia.
 - **Mengimplementasikan Intervensi Keperawatan Kelompok Lansia:**
 1. Mampu melaksanakan intervensi keperawatan dalam kelompok lansia, termasuk kegiatan yang mengoptimalkan partisipasi aktif anggota kelompok.
 2. Mampu memberikan dukungan fisik, psikologis, dan sosial kepada lansia dalam kelompok untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.
 - **Mengevaluasi Efektivitas Asuhan Keperawatan Kelompok Lansia:**
 1. Mampu mengevaluasi keberhasilan intervensi yang dilakukan dalam kelompok lansia, dengan menggunakan indikator-indikator yang relevan (misalnya: peningkatan mobilitas, penurunan tingkat kecemasan).
 2. Mampu mengidentifikasi perubahan fisik, psikologis, dan sosial yang dialami oleh lansia dalam kelompok dan menilai dampak asuhan keperawatan.
 - **Mengidentifikasi Tantangan dalam Keperawatan Kelompok Lansia dan Solusi yang Tepat:**
 1. Mampu mengidentifikasi tantangan yang sering muncul dalam perawatan kelompok lansia, seperti perbedaan kondisi fisik antar anggota kelompok atau masalah komunikasi dalam kelompok.
 2. Mampu merumuskan solusi praktis dan strategi untuk mengatasi tantangan tersebut dalam konteks kelompok.

Pendahuluan:

"**Aplikasi Asuhan Keperawatan Pada Lansia Dalam Konteks Kelompok**" ini disusun sebagai kajian yang bertujuan untuk memberikan pemahaman serta keterampilan praktis dalam memberikan asuhan keperawatan pada lansia, khususnya dalam konteks kelompok. hadir sebagai sarana untuk membantu mahasiswa memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip dasar asuhan keperawatan

kelompok lansia. Kami berusaha menyajikan informasi yang komprehensif dan aplikatif berdasarkan pengalaman serta pemahaman mendalam di bidang keperawatan lansia. terdiri dari enam bab yang berfokus pada topik-topik penting, mulai dari pemahaman kebutuhan kesehatan lansia, penyusunan rencana asuhan, implementasi intervensi, hingga evaluasi efektivitas asuhan yang diterapkan dalam kelompok. didesain dengan pendekatan pembelajaran aktif, yang mengajak pembaca untuk tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis melalui latihan, studi kasus, dan refleksi. Dengan demikian, diharapkan ini tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga keterampilan yang dapat diterapkan langsung dalam praktek perawatan kelompok lansia. Diharapkan, ini dapat menjadi panduan yang berguna bagi mahasiswa, tenaga pengajar, dan profesional kesehatan yang ingin meningkatkan kualitas asuhan keperawatan lansia dalam konteks kelompok.

Uraian Materi

Pada bab "Aplikasi Asuhan Keperawatan Pada Lansia Dalam Konteks Kelompok" ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh serta keterampilan praktis dalam memberikan asuhan keperawatan pada lansia, terutama dalam pengaturan kelompok. Buku ini terdiri dari enam bab yang membahas berbagai aspek penting yang perlu dikuasai oleh mahasiswa dan tenaga kesehatan dalam merawat lansia dalam kelompok.

Pada Bab 1, mahasiswa akan mempelajari Konsep Keperawatan Kelompok Lansia, yang akan mengupas dasar-dasar keperawatan kelompok lansia, serta perbedaan utama antara perawatan individu dan kelompok. Bab ini akan memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam perawatan kelompok lansia, serta bagaimana perawatan kelompok dapat meningkatkan kesejahteraan lansia secara fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Dengan pemahaman ini, mahasiswa diharapkan dapat mengidentifikasi cara-cara untuk mendukung dinamika kelompok yang sehat.

Bab 2 berfokus pada Mengidentifikasi Kebutuhan Kesehatan Lansia dalam Kelompok. Di bab ini, mahasiswa akan dilatih untuk mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan kesehatan lansia dalam kelompok, yang meliputi aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Mahasiswa akan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan lansia, seperti kondisi medis yang ada, dukungan sosial, dan lingkungan hidup. Keterampilan ini sangat penting untuk merancang perawatan yang komprehensif dan tepat sasaran.

Pada Bab 3, mahasiswa akan diajarkan cara Menyusun Rencana Asuhan Keperawatan Kelompok Lansia. Mahasiswa akan belajar untuk merancang rencana asuhan keperawatan yang melibatkan pendekatan kelompok dalam menangani masalah kesehatan lansia, termasuk program pencegahan, promosi kesehatan, dan pengelolaan penyakit kronis. Rencana asuhan ini akan berfokus pada pengelolaan masalah kesehatan yang spesifik, dengan pendekatan berbasis bukti yang dapat diterapkan dalam konteks kelompok.

Bab 4 membahas tentang Mengimplementasikan Asuhan Keperawatan Kelompok Lansia. Di sini, mahasiswa akan dilatih untuk melaksanakan intervensi keperawatan dalam kelompok, dengan mempertimbangkan dinamika kelompok dan kebutuhan individual lansia dalam kelompok tersebut. Mereka akan memahami bagaimana menjalankan intervensi yang sesuai, baik untuk kelompok secara keseluruhan maupun untuk individu dalam kelompok tersebut, agar hasil perawatan dapat optimal. Mahasiswa juga akan mempelajari teknik-teknik dalam berkomunikasi dan mengelola interaksi antara anggota kelompok.

Pada Bab 5, mahasiswa akan mempelajari cara Melakukan Evaluasi Keperawatan Kelompok Lansia. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai efektivitas intervensi yang telah diterapkan, baik dari segi perubahan kondisi fisik, psikologis, maupun sosial lansia dalam kelompok. Mahasiswa akan diberikan pengetahuan mengenai penggunaan indikator yang tepat dalam evaluasi serta cara menganalisis hasil intervensi untuk memberikan umpan balik yang konstruktif dan merencanakan tindakan perbaikan jika diperlukan.

Terakhir, Bab 6 membahas Mengidentifikasi Tantangan dan Solusi dalam Keperawatan Kelompok Lansia. Mahasiswa akan belajar untuk mengidentifikasi tantangan yang mungkin muncul dalam perawatan kelompok lansia, seperti masalah komunikasi, perbedaan kebutuhan individu, atau keterbatasan sumber daya. Selain itu, mereka juga akan dilatih untuk merumuskan solusi yang efektif untuk mengatasi tantangan tersebut, dengan pendekatan yang kreatif dan berbasis pada praktik terbaik dalam keperawatan.

A. Memahami Konsep Dasar Keperawatan Kelompok Lansia

1. Menjelaskan Definisi dan Prinsip Dasar Keperawatan Kelompok Lansia

Keperawatan gerontik merupakan asuhan keperawatan bagi lansia sebagai individu, anggota keluarga, maupun kelompok masyarakat (Hirschfeld, 1979). Keperawatan merupakan profesi yang melibatkan banyak bidang tenaga profesional baik kesehatan maupun bidang yang lain yang diatur oleh norma dan aturan yang disepakati (Camaño & Piqué, 1999). Hakikat keperawatan gerontik adalah penerimaan tulus terhadap lansia, bukan hanya sekedar keterampilan teknis tetapi seni merawat dengan empati dan kesadaran penuh akan keadaannya yang penuh dengan kekurangan pada aspek kehidupannya (Schumacher, 2001). Keperawatan merupakan seni, ilmu, dan praktik berkembang selaras dengan kebutuhan masyarakat (Wilson, 2006). Keperawatan gerontik adalah proses dinamis antara perawat dan pasien yang terjadi pada level pelayanan baik di rumah sakit, komunitas, maupun perawat di rumah yang tujuan utamanya adalah perubahan fisiologis dan peran sosial yang khas pada usia lanjut ("Gerontological Nursing Is a Dynamic Procedure," 2022). Keperawatan gerontologi membahas kebutuhan fisiologis, sosial, psikologis, perkembangan, ekonomi, budaya, spiritual, dan advokasi yang unik lansia dan praktik keperawatannya berfokus pada proses penuaan dan perlindungan, promosi, pemulihan dan optimalisasi kesehatan dan fungsi umum meliputi pencegahan penyakit, cedera, fasilitasi penyembuhan, pengurangan penderitaan melalui diagnosis dan pengobatan sesuai respon fisiologis manusia dan memberikan advokasi dalam perawatan melalui pengasuhan keluarga, kelompok,

komunitas, dan populasi (Vetter, 2020). Ditarik kesimpulan oleh penulis bahwa keperawatan kelompok lansia adalah pendekatan yang mengutamakan pemberian asuhan keperawatan secara kolektif kepada sekelompok lansia, dengan fokus pada kebutuhan kesehatan fisik, psikologis, sosial, dan emosional mereka. Dalam konteks ini, perawat tidak hanya memberikan perawatan individu, tetapi juga memperhatikan dinamika sosial dalam kelompok. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung peningkatan kualitas hidup lansia melalui interaksi sosial yang positif, promosi kesehatan, dan dukungan emosional bersama-sama. Keperawatan kelompok lansia juga memberikan kesempatan bagi lansia untuk saling berbagi pengalaman, yang dapat memperkuat rasa memiliki dan mengurangi perasaan kesepian. Peran Perawat dalam Pelaksanaan Asuhan Kelompok adalah sebagai Koordinasi antar organisasi (rumah sakit, lembaga lokal, sukarelawan), Pelayanan berupa edukasi, promosi kesehatan, rehabilitasi, dan pelatihan caregiver, Monitoring dan evaluasi terhadap hasil layanan dan kondisi lansia (Sudo et al., 2023)

Prinsip dasar dari keperawatan kelompok lansia adalah holistik, di mana perawat harus mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan lansia, baik fisik, mental, maupun sosial. Perawatan yang holistik memastikan bahwa tidak hanya kebutuhan fisik yang dipenuhi, tetapi juga aspek psikologis dan sosial yang sering kali terabaikan pada lansia. Misalnya, perawat dapat memfasilitasi kelompok untuk melakukan aktivitas bersama yang mengarah pada peningkatan fungsi fisik, seperti senam bersama, sekaligus memberikan ruang untuk diskusi sosial yang membantu mengurangi isolasi sosial. Dalam pengelolaan kelompok, perawat berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan proses interaksi antar anggota kelompok dengan bijaksana, menjaga keseimbangan antara kebutuhan individu dan kelompok.

Berikut kami jelaskan yang menjadi prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam keperawatan kelompok lansia, penting dalam keperawatan kelompok lansia adalah partisipasi aktif. Lansia diharapkan untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan kelompok, baik itu diskusi, aktivitas fisik, atau aktivitas sosial lainnya. Partisipasi ini tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan fisik, tetapi juga dapat memperkuat keterikatan emosional di antara anggota kelompok. Melalui partisipasi aktif, lansia dapat merasakan otonomi dan kontrol atas kesejahteraan mereka, yang merupakan faktor penting dalam menjaga kualitas hidup yang tinggi pada usia lanjut. Keberhasilan intervensi perawatan kelompok sering kali tergantung pada seberapa besar tingkat keterlibatan dan dukungan yang diberikan oleh anggota kelompok satu sama lain. Mekanisme dampak positif dari partisipasi sosial terhadap kesehatan memberikan stimulus positif untuk

kesehatan fisik dan mental sehingga secara tidak langsung mendorong perbaikan kesehatan(Lin et al., 2024).

Keperawatan kelompok lansia juga melibatkan pendekatan kolaboratif, di mana perawat bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti keluarga, tenaga medis lainnya, dan komunitas, untuk memberikan perawatan yang optimal. Kolaborasi ini memastikan bahwa perawatan yang diberikan bersifat terintegrasi, meliputi aspek medis, sosial, dan psikologis yang mempengaruhi kesejahteraan lansia. Di dalam kelompok, lansia juga dapat memperoleh dukungan dari sesama lansia yang memiliki pengalaman serupa, yang dapat meningkatkan perasaan saling memahami dan mengurangi perasaan terisolasi. Dengan kolaborasi yang efektif, semua aspek kebutuhan lansia dapat dipenuhi secara maksimal, sehingga menciptakan lingkungan yang mendukung penuaan yang sehat dan bahagia.(Little & Little, 2014)

Terakhir, dalam keperawatan kelompok lansia, penilaian berkelanjutan menjadi salah satu prinsip penting. Perawat harus selalu melakukan evaluasi terhadap kondisi fisik dan emosional anggota kelompok, serta menyesuaikan intervensi yang diberikan sesuai dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi pada masing-masing lansia. Penilaian yang berkelanjutan memungkinkan perawat untuk mendeteksi masalah kesehatan atau sosial yang mungkin muncul dalam kelompok dan segera mengambil langkah untuk mengatasinya. Hal ini memastikan bahwa setiap anggota kelompok mendapatkan perhatian yang sesuai dengan kebutuhan mereka, dan perawatan tetap relevan dan efektif sepanjang waktu.

Dalam keperawatan kelompok lansia, pentingnya pendekatan yang holistik dan terintegrasi menjadi semakin jelas. Pemberian perawatan tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga mencakup dukungan emosional dan sosial. Lansia, yang sering kali mengalami penurunan fungsi fisik dan menghadapi tantangan emosional serta sosial, memerlukan perawatan yang menggabungkan semua aspek tersebut untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Keperawatan kelompok memungkinkan perawat untuk memfasilitasi interaksi sosial yang positif, mempromosikan aktivitas fisik yang sesuai, serta memberikan ruang bagi lansia untuk berbagi pengalaman, yang pada gilirannya mendukung kesejahteraan mereka secara menyeluruh (Touhy & Jett, 2020)

2. Mengidentifikasi Perbedaan antara Keperawatan Individu dan Kelompok dalam Konteks Lansia

Keperawatan individu dan kelompok memiliki pendekatan yang berbeda meskipun keduanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan lansia. Keperawatan individu berfokus pada perawatan yang disesuaikan dengan

kebutuhan spesifik setiap lansia. Setiap rencana perawatan individu disusun berdasarkan kondisi fisik, psikologis, dan sosial lansia tersebut, dengan memperhatikan aspek-aspek seperti riwayat medis, gangguan kesehatan yang ada, serta preferensi dan kebutuhan emosional mereka. Dalam keperawatan individu, perawat berinteraksi langsung dengan satu pasien, melakukan pengkajian mendalam, serta memberikan perawatan yang dipersonalisasi. Pendekatan ini memungkinkan perawat untuk memberikan perhatian penuh pada kondisi setiap lansia, tetapi juga dapat membatasi kesempatan bagi lansia untuk mendapatkan dukungan sosial atau pengalaman interaksi kelompok yang dapat memperkaya kehidupan mereka.(Vetter, 2020)

Berbeda dengan keperawatan individu, keperawatan kelompok lansia mencakup pendekatan yang mengutamakan kebutuhan sosial dan emosional yang seringkali terabaikan dalam setting perawatan individu. Dalam perawatan kelompok, lansia dirawat dalam kelompok yang lebih besar, memungkinkan mereka untuk berbagi pengalaman, berinteraksi, dan saling mendukung satu sama lain. Interaksi ini tidak hanya bermanfaat secara sosial, tetapi juga memberikan dukungan emosional yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup lansia. Keperawatan kelompok memungkinkan perawat untuk melibatkan lansia dalam kegiatan bersama, seperti senam bersama, diskusi kelompok, atau kegiatan seni, yang secara tidak langsung memberikan manfaat tambahan bagi kesejahteraan fisik dan mental mereka. Pendekatan ini juga memfasilitasi perawatan yang lebih efisien dalam skala yang lebih besar, mengingat perawat dapat memberikan layanan kepada lebih banyak lansia secara bersamaan.(Vetter, 2020)

Keperawatan kelompok lansia juga menawarkan keunggulan dalam hal pendekatan kolektif terhadap masalah kesehatan umum. Misalnya, dalam sebuah kelompok, lansia dengan kondisi medis yang sama dapat saling berbagi pengalaman dan strategi untuk mengelola penyakit mereka, seperti diabetes atau hipertensi. Dalam setting kelompok, perawat dapat memberikan edukasi kesehatan kepada seluruh kelompok secara bersamaan, yang mempercepat proses pembelajaran dan pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan kesehatan yang tepat. Selain itu, lansia dalam kelompok sering kali merasa lebih didukung dan termotivasi untuk mengikuti program perawatan yang disarankan, karena mereka merasa bagian dari komunitas yang saling membantu. Hal ini kontras dengan keperawatan individu, di mana lansia mungkin merasa lebih terisolasi atau kesulitan mengikuti perawatan tanpa adanya dukungan sosial.

Namun, meskipun ada banyak keuntungan dari keperawatan kelompok, tantangannya juga cukup besar. Keterbatasan dalam personel atau pengaturan

yang tidak memadai dapat menghambat efektivitas perawatan kelompok. Perawat perlu memiliki keterampilan manajerial untuk mengelola dinamika kelompok dan memastikan bahwa setiap anggota kelompok mendapatkan perhatian yang cukup. Selain itu, tidak semua lansia merasa nyaman atau siap untuk berpartisipasi dalam kegiatan kelompok. Beberapa lansia mungkin merasa cemas atau terintimidasi dengan adanya banyak orang di sekitar mereka. Oleh karena itu, penting bagi perawat untuk mengenali dan menghargai preferensi pribadi lansia dan memastikan bahwa perawatan kelompok dilakukan dengan cara yang tidak memaksakan dan tetap menghormati kebutuhan individu.

Secara keseluruhan, baik keperawatan individu maupun kelompok memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Keperawatan individu memberikan perhatian yang lebih mendalam dan khusus, sementara keperawatan kelompok memberikan manfaat sosial dan psikologis yang tidak dapat dicapai dalam perawatan individu. Keberhasilan dalam mengidentifikasi perbedaan dan memanfaatkan kekuatan masing-masing pendekatan sangat penting dalam merancang program perawatan yang optimal untuk lansia. Dengan memadukan pendekatan individu dan kelompok, perawat dapat memberikan perawatan yang lebih komprehensif dan meningkatkan kualitas hidup lansia secara keseluruhan.

Keperawatan kelompok lansia memberikan kesempatan bagi lansia untuk saling berbagi pengalaman dan mendukung satu sama lain, yang tidak hanya memperbaiki aspek fisik, tetapi juga aspek psikologis dan sosial mereka. Hal ini sejalan dengan konsep perawatan berbasis komunitas, di mana lansia dapat merasakan manfaat dari interaksi sosial yang mendalam dan mendukung kesejahteraan mental mereka. Interaksi dalam kelompok dapat mempercepat adaptasi lansia terhadap kondisi medis mereka, memotivasi mereka untuk lebih aktif dalam merawat diri, dan mengurangi perasaan kesepian. Keperawatan kelompok juga memungkinkan perawat untuk menyediakan edukasi kesehatan dengan lebih efisien kepada lansia dalam setting yang lebih terstruktur dan kolaboratif (Touhy & Jett, 2020).

B. Mengidentifikasi Kebutuhan Kesehatan Lansia dalam Kelompok

1. Menganalisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesehatan Lansia dalam Kelompok, Termasuk Perubahan Fisik, Psikologis, Sosial, dan Spiritual

Pada masa penuaan, lansia mengalami berbagai perubahan fisik yang mempengaruhi kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Diantaranya perubahan utama yang terjadi adalah penurunan fungsi tubuh, seperti berkurangnya kekuatan otot, penurunan kepadatan tulang, dan penurunan elastisitas kulit, Sistem kardiovaskular dan pernapasan juga mengalami perubahan, seperti halnya

penurunan efisiensi jantung dalam memompa darah atau penurunan kapasitas paru-paru(Astuti et al., 2024). Dalam konteks kelompok, perubahan fisik ini dapat memengaruhi kemampuan lansia untuk berpartisipasi dalam kegiatan kelompok, seperti olahraga atau interaksi sosial yang memerlukan mobilitas. Perawat yang bekerja dengan kelompok lansia perlu memahami perubahan ini dan merancang program perawatan yang mengakomodasi keterbatasan fisik sambil tetap mendorong partisipasi aktif dari anggota kelompok(C. A. . Miller, 2023)

Selain perubahan fisik, lansia juga mengalami perubahan psikologis yang dapat memengaruhi kesehatan mereka dalam kelompok. Gangguan seperti depresi, kecemasan, dan penurunan kognitif (misalnya, demensia atau Alzheimer) adalah kondisi umum pada lansia yang dapat berdampak signifikan pada kualitas hidup mereka. Perubahan psikologis ini dapat memengaruhi kemampuan lansia untuk berinteraksi dengan anggota kelompok lain dan menurunkan minat mereka dalam kegiatan sosial. Dalam kelompok lansia, perawat harus peka terhadap tanda-tanda masalah psikologis ini dan memberikan dukungan yang sesuai, baik melalui komunikasi terbuka maupun intervensi spesifik yang melibatkan anggota kelompok untuk mendukung satu sama lain. Selain itu, kelompok yang mendukung secara emosional dapat membantu mengurangi perasaan kesepian dan isolasi yang sering dialami lansia, meningkatkan kesejahteraan psikologis mereka(C. A. . Miller, 2023)

Dari sisi sosial, lansia yang berada dalam kelompok dapat merasakan dampak yang signifikan dari dinamika sosial mereka. Perubahan dalam kehidupan sosial, seperti pensiun, kehilangan pasangan hidup, atau menurunnya kapasitas untuk berinteraksi dengan dunia luar, dapat menyebabkan perasaan kesepian dan terisolasi. Dalam kelompok lansia, interaksi sosial yang aktif bisa menjadi salah satu faktor utama dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Perawat perlu mengidentifikasi lansia yang mungkin mengalami kesulitan beradaptasi dengan kehidupan sosial kelompok dan menciptakan kegiatan yang mendorong keterlibatan, seperti diskusi kelompok, kegiatan rekreasi, atau program berbasis minat. Kegiatan sosial yang mendukung dapat membantu lansia mempertahankan hubungan interpersonal yang bermakna, yang pada gilirannya meningkatkan rasa percaya diri dan kepuasan hidup mereka.(C. Miller, 2020)

Dalam aspek spiritual, lansia sering kali menghadapi pertanyaan-pertanyaan tentang makna hidup dan tujuan mereka, terutama setelah mengalami berbagai perubahan dalam hidup. Kebutuhan spiritual dapat mencakup pencarian makna dalam hidup, hubungan dengan kekuatan yang lebih tinggi, atau peningkatan kedamaian batin. Dalam kelompok lansia, perawat dapat memfasilitasi kegiatan

yang mendukung kebutuhan spiritual ini, seperti meditasi, doa bersama, atau diskusi tentang nilai-nilai kehidupan. Memberikan ruang untuk eksplorasi spiritual ini tidak hanya membantu lansia merasakan kedamaian batin tetapi juga meningkatkan kesejahteraan emosional dan psikologis mereka. Mengakui pentingnya spiritualitas dalam kehidupan lansia dapat memperkaya pengalaman mereka dalam kelompok dan memberikan rasa tujuan yang lebih dalam.(C. Miller, 2020)

Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan lansia dalam kelompok memerlukan pendekatan yang holistik. Semua perubahan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual ini saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Perawat yang bekerja dengan kelompok lansia harus mengintegrasikan pemahaman tentang faktor-faktor ini untuk merancang program perawatan yang menyeluruh. Dengan demikian, pendekatan berbasis kelompok yang mempertimbangkan kebutuhan holistik lansia dapat meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Keterlibatan sosial, dukungan emosional, pengelolaan kondisi fisik, dan perhatian terhadap kebutuhan spiritual lansia adalah aspek yang perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa setiap individu dalam kelompok mendapat perhatian yang seimbang dan memadai.(Touhy & Jett, 2020)

2. Melakukan Pengkajian Kelompok untuk Menentukan Kebutuhan Kesehatan Lansia dalam Konteks Kelompok

Pengkajian kesehatan lansia dalam konteks kelompok memiliki tujuan untuk memahami kebutuhan kesehatan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual lansia secara kolektif, dengan mempertimbangkan dinamika kelompok. Pengkajian ini berbeda dengan pengkajian individual, karena melibatkan interaksi antar anggota kelompok yang dapat saling mempengaruhi kondisi kesehatan masing-masing. Oleh karena itu, pengkajian kelompok memerlukan pendekatan yang lebih holistik dan terintegrasi, di mana setiap individu dalam kelompok dianalisis dalam konteks hubungan mereka dengan anggota lainnya. Dalam kelompok lansia, perawat tidak hanya mengamati kebutuhan masing-masing individu, tetapi juga memperhatikan bagaimana interaksi sosial, dukungan emosional, dan dinamika kelompok dapat mempengaruhi kesejahteraan setiap lansia. Ada enam area dalam mengidentifikasi area yaitu aspek fisik terdiri dari mobilitas, penglihatan/pendengaran, kemampuan kontrol inkontinensia, selanjutnya aspek psikologis meliputi perasaan kesepian, kecemasan, depresi, dalam aspek sosialnya meliputi partisipasi sosial, keterikatan komunitas, kemudian dalam aspek lingkungan meliputi kondisi situasi lingkungan apakah berbahaya, berisiko mengancam kesehatan atau keberlangsungan kesehatannya, literasi kesehatan

apakah bisa didapatkan , dan alat bantu kesehatan yang menunjang kesehatannya(Cheraghi et al., 2023)

Salah satu langkah awal dalam pengkajian kelompok adalah identifikasi kondisi kesehatan fisik yang ada pada setiap anggota kelompok. Ini mencakup penyakit kronis yang sering dialami lansia, seperti diabetes, hipertensi, arthritis, dan gangguan jantung. Di samping itu, pengkajian fisik juga harus mencakup kemampuan mobilitas, status gizi, serta pengelolaan pengobatan yang mungkin dilakukan dalam kelompok. Dalam setting kelompok, perawat perlu melakukan pengukuran dan pemantauan bersama-sama untuk memastikan bahwa setiap lansia mendapatkan perhatian yang sama terkait masalah kesehatan fisiknya. Misalnya, perawat dapat melakukan pemeriksaan tekanan darah atau tingkat gula darah secara bersama-sama dalam sesi kelompok untuk memantau kondisi fisik dan mendeteksi masalah yang perlu perhatian lebih lanjut.

Selanjutnya, pengkajian psikologis dalam kelompok lansia sangat penting untuk mendeteksi adanya masalah kesehatan mental, seperti depresi, kecemasan, atau gangguan kognitif. Perubahan psikologis pada lansia sering kali berdampak pada kualitas hidup mereka, mempengaruhi interaksi sosial, dan bahkan memengaruhi partisipasi dalam aktivitas kelompok. Perawat harus melakukan pengkajian untuk mengidentifikasi tingkat kecemasan, mood, atau gejala-gejala yang menunjukkan adanya gangguan kognitif seperti demensia. Dalam kelompok, interaksi sosial antar lansia bisa menjadi alat untuk memantau perubahan psikologis ini. Perawat dapat mengamati reaksi atau respons lansia terhadap kegiatan kelompok untuk menentukan apakah ada kebutuhan intervensi psikologis lebih lanjut.

Pengkajian sosial dalam kelompok lansia juga memiliki peran yang sangat besar. Lansia sering kali mengalami kesepian dan isolasi sosial, terutama ketika mereka kehilangan pasangan atau teman sebayanya. Dalam kelompok, perawat perlu mengidentifikasi tingkat keterlibatan sosial setiap anggota, memperhatikan interaksi antar anggota kelompok, dan mengidentifikasi anggota yang mungkin merasa terisolasi. Pengkajian sosial ini bisa dilakukan dengan mengamati interaksi dalam kegiatan kelompok, seperti diskusi atau aktivitas bersama, dan dengan berbicara langsung kepada lansia mengenai pengalaman sosial mereka. Dengan mengetahui seberapa banyak lansia berinteraksi dengan anggota kelompok lainnya, perawat dapat menentukan program atau kegiatan yang lebih mendorong hubungan sosial yang lebih kuat, misalnya melalui kelompok dukungan atau kegiatan bersama yang mempromosikan kolaborasi.

Aspek terakhir yang perlu dipertimbangkan dalam pengkajian kelompok adalah kebutuhan spiritual lansia. Banyak lansia yang menghadapi pertanyaan-

pertanyaan tentang makna hidup, atau merasakan kebutuhan untuk lebih mendalami aspek spiritual mereka. Dalam kelompok, pengkajian terhadap kebutuhan spiritual ini dapat dilakukan dengan memberi kesempatan bagi lansia untuk berbicara tentang keyakinan mereka atau melibatkan mereka dalam kegiatan yang mendukung spiritualitas, seperti meditasi atau diskusi agama. Perawat harus peka terhadap perasaan atau keyakinan spiritual yang mungkin belum terungkap oleh anggota kelompok lainnya. Kebutuhan spiritual yang tidak teridentifikasi dapat menghambat kesejahteraan psikologis dan emosional lansia. Oleh karena itu, penting bagi perawat untuk memberi ruang bagi lansia untuk mengeksplorasi dan mengungkapkan dimensi spiritual mereka dalam konteks kelompok.

Dengan demikian, pengkajian kelompok dalam konteks lansia membutuhkan pendekatan yang lebih mendalam dan holistik. Perawat harus mempertimbangkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual lansia secara terintegrasi dalam setting kelompok. Pengkajian yang komprehensif ini akan menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan kesehatan lansia dalam kelompok, serta memungkinkan perawat untuk merancang intervensi yang lebih tepat sasaran dan efektif dalam meningkatkan kualitas hidup lansia.

Pengkajian kesehatan lansia dalam kelompok memerlukan pendekatan yang lebih terintegrasi untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan mereka, baik fisik, psikologis, sosial, maupun spiritual. Hal ini sejalan dengan prinsip perawatan holistik yang menekankan pentingnya memperhatikan seluruh aspek kehidupan lansia dalam proses perawatan. Dalam kelompok, lansia dapat saling memberi dukungan emosional yang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup mereka. Selain itu, interaksi sosial yang terjadi dalam kelompok dapat memberikan informasi berharga tentang kondisi mental dan sosial setiap individu, yang mungkin tidak terungkap dalam perawatan individu. Dengan pengkajian yang komprehensif ini, perawat dapat merancang intervensi yang tidak hanya memperhatikan kondisi medis tetapi juga meningkatkan kesejahteraan psikososial dan spiritual lansia (Touhy & Jett, 2020)

C. Menyusun Rencana Asuhan Keperawatan untuk Kelompok Lansia

1. Rencana Asuhan Keperawatan Kelompok yang Mencakup Tujuan, Intervensi, dan Evaluasi yang Sesuai untuk Kelompok Lansia Berdasarkan Hasil Pengkajian

Menyusun rencana asuhan keperawatan untuk kelompok lansia dimulai dengan menetapkan tujuan yang jelas berdasarkan hasil pengkajian kesehatan yang telah dilakukan. Tujuan ini harus mencakup berbagai aspek kesehatan fisik,

psikologis, sosial, dan spiritual anggota kelompok. Misalnya, tujuan fisik mungkin melibatkan peningkatan mobilitas lansia dengan latihan fisik yang tepat, sedangkan tujuan psikologis bisa berfokus pada pengurangan kecemasan atau depresi melalui dukungan sosial dan kegiatan kelompok. Tujuan sosial dapat mencakup peningkatan interaksi sosial antar anggota kelompok untuk mengurangi perasaan kesepian. Dengan menetapkan tujuan yang mencakup berbagai dimensi ini, perawat dapat memastikan bahwa setiap aspek kebutuhan kesehatan lansia dipenuhi secara menyeluruh dalam perawatan kelompok.

Setelah tujuan ditetapkan, langkah berikutnya adalah merancang intervensi yang sesuai. Intervensi ini harus disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan spesifik dari kelompok lansia yang telah diidentifikasi dalam pengkajian. Misalnya, untuk lansia yang memiliki masalah mobilitas, intervensi bisa berupa program senam lansia yang dilakukan secara bersama-sama dalam kelompok, yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan otot dan fleksibilitas. Sedangkan untuk lansia yang menghadapi masalah psikologis seperti depresi atau kecemasan, intervensi dapat berupa sesi dukungan emosional dalam kelompok atau aktivitas yang dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kesejahteraan psikologis mereka. Dalam keperawatan kelompok, penting bagi perawat untuk merancang intervensi yang tidak hanya mengatasi masalah kesehatan individu tetapi juga memanfaatkan dinamika kelompok untuk meningkatkan efektivitas intervensi.

Pendekatan kolaboratif menjadi bagian penting dalam merancang rencana intervensi. Dalam konteks kelompok, lansia sering kali saling mendukung satu sama lain, dan perawat dapat memfasilitasi dinamika ini untuk meningkatkan keberhasilan intervensi. Sebagai contoh, dalam kegiatan berbagi pengalaman atau diskusi kelompok, perawat dapat mendorong lansia untuk saling berbagi strategi dalam mengelola penyakit kronis, atau cara mereka mengatasi tantangan emosional yang dihadapi. Intervensi berbasis kelompok ini tidak hanya memperkaya pengetahuan lansia tetapi juga menciptakan ikatan sosial yang kuat antar anggota kelompok, yang dapat meningkatkan rasa kebersamaan dan motivasi mereka untuk mengikuti program perawatan.

Setelah intervensi dilaksanakan, evaluasi menjadi langkah penting dalam menentukan sejauh mana rencana asuhan keperawatan tersebut berhasil. Evaluasi harus mencakup pengukuran hasil berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Misalnya, untuk tujuan fisik, evaluasi dapat mencakup pengamatan terhadap peningkatan kemampuan mobilitas lansia, seperti kemampuan berjalan atau berpartisipasi dalam senam kelompok. Untuk tujuan psikologis, evaluasi dapat melibatkan pengukuran perubahan dalam tingkat kecemasan atau depresi melalui wawancara atau skala penilaian yang terstandarisasi. Evaluasi sosial dapat

mencakup pengamatan terhadap peningkatan interaksi sosial dalam kelompok, sedangkan evaluasi spiritual dapat dilakukan dengan memberi kesempatan kepada lansia untuk berbagi perasaan mereka tentang makna hidup atau keyakinan spiritual mereka setelah mengikuti aktivitas kelompok.

Revisi dan penyesuaian rencana asuhan keperawatan juga merupakan bagian dari evaluasi yang berkelanjutan. Perawat perlu menilai apakah intervensi yang dilakukan efektif dan sesuai dengan perubahan kondisi kelompok lansia. Jika diperlukan, perawat dapat menyesuaikan rencana perawatan untuk lebih menargetkan kebutuhan yang belum terpenuhi atau yang berubah seiring waktu. Sebagai contoh, jika ternyata suatu aktivitas kelompok tidak memberikan hasil yang diinginkan, perawat bisa merancang ulang aktivitas tersebut dengan pendekatan yang lebih sesuai. Dengan melakukan evaluasi dan penyesuaian secara berkelanjutan, rencana asuhan keperawatan dapat memastikan keberlanjutan dan efektivitas dalam meningkatkan kesejahteraan lansia dalam kelompok.

Menyusun rencana asuhan keperawatan untuk kelompok lansia memerlukan pemahaman yang mendalam tentang kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual setiap anggota kelompok. Hal ini sejalan dengan pendekatan keperawatan yang berbasis pada pemenuhan kebutuhan holistik lansia. Dalam konteks kelompok, perawat perlu merancang rencana yang dapat memperkuat interaksi sosial di antara lansia sambil tetap memperhatikan kondisi medis masing-masing individu. Intervensi yang efektif dalam kelompok dapat meningkatkan kualitas hidup lansia secara keseluruhan, baik melalui kegiatan fisik yang mengaktifkan tubuh, program yang mendukung kesehatan mental, maupun dukungan sosial yang mempererat ikatan antar anggota kelompok (Touhy & Jett, 2020)

2. Merancang Program Promosi Kesehatan dan Pencegahan Penyakit untuk Kelompok Lansia

Merancang program promosi kesehatan dan pencegahan penyakit untuk kelompok lansia memerlukan pemahaman mendalam tentang kebutuhan fisik dan psikososial mereka. Lansia sering kali mengalami berbagai masalah kesehatan kronis, seperti hipertensi, diabetes, dan osteoarthritis, yang mempengaruhi kualitas hidup mereka. Oleh karena itu, program promosi kesehatan yang dirancang untuk kelompok lansia harus mencakup kegiatan yang tidak hanya meningkatkan kesadaran akan pentingnya pola hidup sehat, tetapi juga mendorong lansia untuk aktif berpartisipasi dalam program kesehatan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Contoh program yang dapat dirancang adalah senam lansia untuk meningkatkan kekuatan otot dan mobilitas, serta

edukasi gizi untuk mengelola diet yang mendukung kesehatan jantung dan mengurangi risiko diabetes.

Program pencegahan penyakit pada lansia harus dirancang dengan mempertimbangkan faktor risiko yang sering dialami oleh kelompok ini, seperti kurangnya aktivitas fisik, diet yang tidak seimbang, serta masalah kesehatan mental seperti depresi atau kecemasan. Selain itu, program ini harus mencakup langkah-langkah untuk mencegah penyakit yang lebih spesifik bagi lansia, seperti pencegahan osteoporosis melalui pemberian informasi tentang asupan kalsium yang cukup dan latihan beban yang ringan. Program ini juga dapat mencakup vaksinasi untuk mencegah penyakit infeksi yang lebih rentan dialami oleh lansia, seperti pneumonia dan flu, serta pemeriksaan kesehatan berkala untuk mendeteksi dini penyakit yang mungkin tidak menunjukkan gejala pada tahap awal.

Selain pencegahan fisik, program promosi kesehatan pada lansia juga harus memperhatikan aspek psikososial. Lansia sering kali menghadapi isolasi sosial dan penurunan status mental, yang dapat berkontribusi pada penurunan kualitas hidup mereka. Oleh karena itu, program promosi kesehatan yang efektif harus mencakup kegiatan yang mendorong interaksi sosial, seperti kelompok diskusi atau kegiatan seni yang dapat meningkatkan rasa percaya diri dan membantu lansia merasa lebih dihargai. Dukungan emosional yang diberikan dalam kelompok juga sangat penting, karena dapat membantu mengurangi perasaan kesepian, yang merupakan masalah umum pada lansia. Perawat harus merancang program yang memfasilitasi partisipasi aktif dan mendukung keterlibatan lansia dalam kegiatan sosial yang meningkatkan kesehatan mental mereka.

Untuk memastikan keberhasilan program promosi kesehatan dan pencegahan penyakit, penting bagi perawat untuk melakukan pendekatan berbasis bukti. Program ini harus disesuaikan dengan data kesehatan dan kebutuhan spesifik lansia dalam kelompok tersebut. Misalnya, pengkajian awal terhadap status kesehatan setiap anggota kelompok akan membantu perawat untuk merancang intervensi yang lebih tepat sasaran, seperti program latihan yang disesuaikan dengan kondisi fisik mereka atau pemberian informasi yang lebih fokus pada penyakit tertentu yang lebih rentan dihadapi oleh anggota kelompok. Dengan pendekatan berbasis bukti, perawat dapat memastikan bahwa setiap kegiatan yang diusulkan relevan dan bermanfaat bagi seluruh kelompok, sehingga program ini lebih efektif dalam meningkatkan kesehatan lansia secara keseluruhan.

Evaluasi dari keberhasilan program menjadi langkah krusial untuk menilai dampak dari program promosi kesehatan dan pencegahan penyakit yang telah

dilaksanakan. Perawat perlu menetapkan indikator yang jelas untuk mengukur keberhasilan, seperti peningkatan aktivitas fisik, perubahan pola makan, atau penurunan gejala depresi pada lansia. Evaluasi ini juga memberikan kesempatan bagi perawat untuk menyesuaikan program jika diperlukan, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, atau menambah kegiatan yang lebih mendukung keberhasilan jangka panjang. Dengan evaluasi yang berkelanjutan, program dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang berubah seiring waktu, memastikan bahwa program promosi kesehatan dan pencegahan penyakit tetap efektif dan relevan bagi kelompok lansia.

Pentingnya merancang program promosi kesehatan dan pencegahan penyakit yang komprehensif bagi kelompok lansia tidak dapat dipungkiri, terutama dalam upaya mengurangi dampak penyakit kronis dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Program tersebut harus berfokus pada pencegahan primer, seperti peningkatan aktivitas fisik, pengaturan pola makan, serta vaksinasi, serta pencegahan sekunder, yaitu deteksi dini penyakit yang sering terjadi pada lansia. Selain itu, program ini juga perlu memasukkan dukungan sosial dan emosional yang sangat penting untuk menjaga kesejahteraan psikologis lansia. Dengan pendekatan ini, lansia dapat merasakan manfaat tidak hanya dari segi fisik, tetapi juga dalam aspek sosial dan emosional mereka, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kesehatan secara keseluruhan (Ebersole & Hess, 2010).

D. Mengimplementasikan Intervensi Keperawatan Kelompok Lansia:

1. Mampu Melaksanakan Intervensi Keperawatan dalam Kelompok Lansia, Termasuk Kegiatan yang Mengoptimalkan Partisipasi Aktif Anggota Kelompok

Implementasi intervensi keperawatan dalam kelompok lansia adalah proses yang melibatkan berbagai kegiatan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan kesehatan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual lansia. Salah satu kunci keberhasilan intervensi ini adalah mendorong partisipasi aktif dari setiap anggota kelompok. Partisipasi ini penting karena tidak hanya meningkatkan hasil kesehatan fisik, tetapi juga memperkuat keterlibatan sosial dan meningkatkan rasa memiliki dalam kelompok. Perawat yang memimpin kelompok lansia harus menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung, di mana setiap anggota merasa dihargai dan didorong untuk berkontribusi. Misalnya, dalam kegiatan olahraga ringan, seperti senam lansia, perawat dapat mendorong setiap individu untuk berpartisipasi sesuai dengan kemampuannya, sehingga tercipta rasa kebersamaan yang positif.

Aktivitas fisik dalam kelompok lansia berfungsi sebagai intervensi penting dalam meningkatkan kesehatan fisik anggota kelompok. Perawat dapat merancang program senam bersama atau latihan peregangan yang sesuai dengan kondisi fisik lansia. Program ini bertujuan untuk memperbaiki fleksibilitas, meningkatkan sirkulasi darah, dan memperkuat otot-otot tubuh yang melemah seiring penuaan. Kegiatan fisik kelompok seperti ini juga memiliki manfaat psikologis yang besar, karena dapat mengurangi stres, kecemasan, dan depresi yang sering dialami lansia. Selain itu, kegiatan ini juga meningkatkan mobilitas dan mengurangi risiko jatuh, yang merupakan masalah umum pada lansia. Dengan mengoptimalkan partisipasi fisik dalam kelompok, lansia akan merasa lebih sehat dan bugar, serta lebih termotivasi untuk terus beraktivitas.

Selain intervensi fisik, dukungan emosional dalam kelompok sangat penting untuk menjaga kesehatan psikologis lansia. Perawat dapat melaksanakan kegiatan diskusi kelompok yang melibatkan berbagi pengalaman atau cerita hidup. Hal ini memberikan kesempatan bagi anggota kelompok untuk saling mendukung, serta mengurangi rasa kesepian dan isolasi sosial. Kegiatan ini juga dapat membantu lansia menghadapi perasaan kehilangan, kecemasan, atau stres akibat perubahan hidup yang dialami seiring bertambahnya usia. Melalui diskusi kelompok, lansia dapat merasa lebih dihargai, lebih terhubung dengan orang lain, dan mendapatkan dukungan emosional yang sangat penting untuk kesejahteraan mereka. Perawat harus memastikan bahwa diskusi tetap positif dan mendukung, sehingga semua anggota merasa aman untuk berbagi dan berpartisipasi.

Keterlibatan Sosial adalah aspek lain yang tidak kalah penting dalam intervensi kelompok lansia. Lansia yang aktif secara sosial lebih cenderung memiliki kualitas hidup yang lebih baik, karena mereka merasa terhubung dengan orang lain dan memiliki dukungan sosial yang kuat. Perawat dapat merancang kegiatan kelompok yang memfasilitasi interaksi sosial, seperti permainan kelompok, seni dan kerajinan, atau kegiatan berbasis minat yang melibatkan semua anggota. Kegiatan sosial semacam ini dapat mendorong lansia untuk berbicara, tertawa, dan berinteraksi dengan sesama, yang akan memperkuat ikatan sosial mereka dan memperbaiki kesehatan mental mereka. Interaksi sosial yang positif juga dapat menurunkan risiko depresi dan kecemasan pada lansia, yang sering terjadi akibat perasaan terisolasi (Prima & Riasmini, 2021).

Dalam rangka evaluasi dan penyesuaian, perawat harus secara teratur memantau efektivitas intervensi yang dilakukan dalam kelompok lansia. Pengamatan terhadap partisipasi lansia dalam berbagai kegiatan dan perasaan mereka setelah mengikuti kegiatan tersebut dapat memberikan gambaran

tentang keberhasilan intervensi. Jika terdapat anggota yang cenderung pasif atau kesulitan untuk berpartisipasi, perawat harus menyesuaikan kegiatan agar lebih inklusif dan sesuai dengan kemampuan setiap individu. Evaluasi yang terus-menerus juga memungkinkan perawat untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan merancang strategi baru untuk meningkatkan partisipasi aktif lansia dalam kelompok. Dengan penyesuaian yang tepat, intervensi dapat lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental lansia dalam kelompok.

Intervensi keperawatan dalam kelompok lansia harus memperhatikan kebutuhan unik setiap individu sambil mendorong partisipasi aktif dari seluruh anggota kelompok. Dalam konteks kelompok, intervensi seperti kegiatan fisik bersama, diskusi kelompok, dan kegiatan sosial dapat memfasilitasi rasa keterikatan sosial yang kuat, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan emosional dan psikologis lansia. Keberhasilan intervensi ini bergantung pada kemampuan perawat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung, inklusif, dan memotivasi, di mana setiap lansia merasa dihargai dan diberdayakan. Dengan merancang kegiatan yang sesuai dengan kemampuan dan minat lansia, perawat dapat meningkatkan kualitas hidup mereka melalui pendekatan berbasis kelompok yang menyeluruh (Touhy & Jett, 2020)

2. Mampu Memberikan Dukungan Fisik, Psikologis, dan Sosial kepada Lansia dalam Kelompok untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Mereka

Keberhasilan implementasi intervensi keperawatan kelompok lansia sangat bergantung pada kemampuan perawat untuk memberikan dukungan yang holistik, mencakup aspek fisik, psikologis, dan sosial. Dukungan fisik merupakan salah satu elemen utama dalam perawatan lansia, mengingat penurunan fungsi tubuh yang terjadi seiring bertambahnya usia. Dalam kelompok, perawat dapat melaksanakan kegiatan fisik seperti senam atau latihan peregangan yang bertujuan untuk meningkatkan mobilitas, fleksibilitas, dan kekuatan otot lansia. Aktivitas fisik yang disesuaikan dengan kemampuan individu dalam kelompok tidak hanya memperbaiki kondisi fisik tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri dan mengurangi risiko gangguan kesehatan seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung. Dukungan fisik yang terencana dan terstruktur dapat memperbaiki kualitas hidup lansia, mencegah penurunan fungsi tubuh, dan meningkatkan kebugaran secara keseluruhan.

Selain dukungan fisik, dukungan psikologis juga sangat penting dalam kelompok lansia, terutama untuk mengatasi masalah kesehatan mental yang sering dialami oleh lansia, seperti depresi, kecemasan, atau demensia. Dalam konteks kelompok, perawat dapat mengadakan kegiatan yang memfasilitasi

ekspresi emosi dan perasaan, seperti sesi diskusi atau kegiatan berbagi pengalaman. Aktivitas ini dapat memberikan lansia ruang untuk berbicara tentang perasaan mereka, mengurangi perasaan kesepian, serta meningkatkan rasa dihargai dan diterima dalam kelompok. Dukungan psikologis juga dapat diberikan melalui pendekatan yang lebih personal, seperti memberikan perhatian khusus kepada anggota kelompok yang tampak tertekan atau cemas. Perawat dapat memfasilitasi percakapan dengan lansia tersebut untuk memberikan dukungan emosional yang mereka butuhkan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesehatan mental dan kualitas hidup mereka.

Dukungan sosial dalam kelompok lansia sangat berperan dalam menciptakan rasa kebersamaan dan meningkatkan kualitas hidup lansia. Banyak lansia yang mengalami isolasi sosial, yang berkontribusi pada penurunan kesejahteraan psikologis mereka. Melalui kelompok, lansia memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan sesama, berbagi pengalaman hidup, serta membangun hubungan sosial yang positif. Dalam kelompok, perawat dapat mengorganisir kegiatan yang mendorong interaksi, seperti permainan sosial, diskusi kelompok, atau aktivitas bersama lainnya. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan keterikatan sosial, tetapi juga memperkuat rasa memiliki dan dukungan antar sesama anggota kelompok. Dengan membangun hubungan sosial yang kuat, lansia merasa lebih dihargai dan tidak terisolasi, yang secara langsung meningkatkan kesehatan emosional dan sosial mereka.

Dalam mengimplementasikan dukungan fisik, psikologis, dan sosial ini, perawat harus mempertimbangkan kebutuhan individual setiap anggota kelompok. Meskipun kegiatan dilakukan secara kelompok, perawat harus peka terhadap kondisi fisik dan psikologis setiap lansia. Misalnya, lansia yang memiliki masalah mobilitas atau gangguan kognitif mungkin memerlukan pendekatan yang lebih khusus dalam kegiatan fisik atau psikologis. Perawat perlu menyesuaikan intensitas latihan fisik atau menawarkan dukungan psikologis yang lebih intensif kepada mereka yang menunjukkan tanda-tanda stres atau depresi. Penyesuaian semacam ini penting untuk memastikan bahwa semua lansia mendapatkan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka, dan tidak ada yang tertinggal dalam proses perawatan.

Untuk memastikan bahwa intervensi ini berkelanjutan dan efektif, perawat harus melakukan evaluasi secara berkala terhadap keberhasilan dukungan fisik, psikologis, dan sosial yang diberikan. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui pengamatan langsung, wawancara dengan anggota kelompok, atau menggunakan skala penilaian yang sesuai untuk mengukur tingkat partisipasi, kebahagiaan, dan kesejahteraan lansia. Berdasarkan hasil evaluasi, perawat dapat

menyesuaikan program perawatan untuk meningkatkan efektivitasnya. Dengan pendekatan yang adaptif dan responsif, perawat dapat memastikan bahwa intervensi yang diberikan terus mendukung peningkatan kualitas hidup lansia dalam kelompok secara optimal.

Dukungan fisik, psikologis, dan sosial yang diberikan dalam konteks kelompok sangat penting dalam menjaga kesejahteraan lansia. Intervensi yang melibatkan kegiatan kelompok memungkinkan lansia untuk mendapatkan manfaat tidak hanya dari perawatan individu, tetapi juga dari interaksi sosial yang memperkaya pengalaman mereka (Jin & Chen, 2025). Dukungan sosial yang diberikan oleh kelompok memungkinkan lansia untuk merasa diterima, mengurangi perasaan kesepian, dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam berbagai kegiatan. Oleh karena itu, penting bagi perawat untuk merancang dan melaksanakan intervensi yang memperhatikan seluruh aspek kesehatan lansia, dari fisik hingga psikologis dan sosial, guna memastikan bahwa mereka memiliki kualitas hidup yang baik. Dukungan ini tidak hanya berfokus pada penyakit, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan (Touhy & Jett, 2020).

E. Mengevaluasi Efektivitas Asuhan Keperawatan Kelompok Lansia

1. Mengevaluasi keberhasilan intervensi yang dilakukan dalam kelompok lansia, dengan menggunakan indikator-indikator yang relevan (misalnya: peningkatan mobilitas, penurunan tingkat kecemasan).

Evaluasi efektivitas asuhan keperawatan kelompok lansia adalah langkah krusial untuk memastikan bahwa intervensi yang dilakukan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan fisik dan mental lansia. Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan intervensi adalah peningkatan mobilitas. Dalam konteks kelompok lansia, perawat perlu memantau perubahan dalam kemampuan fisik anggota kelompok, seperti peningkatan jarak berjalan, kemampuan untuk berdiri atau duduk tanpa bantuan, dan berpartisipasi dalam aktivitas fisik kelompok. Program latihan atau senam bersama yang diterapkan dalam kelompok dapat membantu memperbaiki kekuatan otot, keseimbangan, dan fleksibilitas lansia. Dengan memantau perkembangan ini, perawat dapat menentukan apakah intervensi fisik yang dilakukan berhasil meningkatkan mobilitas lansia dan apakah kegiatan yang dirancang efektif dalam mencegah penurunan kemampuan fisik.

Selain peningkatan mobilitas, penurunan tingkat kecemasan adalah indikator penting dalam mengevaluasi efektivitas intervensi keperawatan pada kelompok lansia, terutama karena banyak lansia yang mengalami masalah kecemasan akibat penurunan kesehatan atau isolasi sosial. Untuk mengukur

penurunan kecemasan, perawat dapat menggunakan alat ukur psikologis standar, seperti skala kecemasan Geriatric Anxiety Scale (GAS), atau melalui wawancara dan pengamatan terhadap perubahan perilaku lansia. Misalnya, perubahan dalam frekuensi lansia berbicara tentang kekhawatiran atau ketakutan, serta peningkatan partisipasi dalam kegiatan kelompok yang sebelumnya mereka hindari, dapat menjadi indikasi penurunan kecemasan. Program yang melibatkan interaksi sosial dan dukungan emosional dalam kelompok dapat membantu mengurangi rasa cemas, memberikan rasa aman, dan meningkatkan kesejahteraan psikologis lansia secara keseluruhan.

Untuk menilai keberhasilan intervensi dalam kelompok lansia, perawat juga harus memperhatikan perubahan dalam kualitas hidup secara keseluruhan. Kualitas hidup adalah konsep multidimensi yang melibatkan aspek fisik, emosional, sosial, dan spiritual. Perawat dapat menggunakan berbagai alat ukur kualitas hidup yang telah distandarisasi, seperti WHOQOL-BREF (*World Health Organization Quality of Life Assessment*) untuk mengukur sejauh mana intervensi dalam kelompok lansia telah berhasil meningkatkan kesejahteraan mereka dalam aspek-aspek tersebut. Peningkatan partisipasi lansia dalam kegiatan kelompok, pengurangan gejala stres atau depresi, serta peningkatan interaksi sosial adalah indikator penting dari peningkatan kualitas hidup. Melalui evaluasi ini, perawat dapat menilai sejauh mana program perawatan kelompok telah memenuhi tujuan awal yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan lansia.

Pengamatan langsung juga merupakan metode evaluasi yang efektif dalam mengukur keberhasilan intervensi. Perawat harus terlibat secara aktif dalam kegiatan kelompok dan mengamati interaksi lansia selama kegiatan tersebut. Misalnya, perawat dapat memperhatikan apakah lansia yang sebelumnya lebih pasif kini mulai lebih aktif berpartisipasi dalam percakapan atau kegiatan fisik. Pengamatan terhadap perubahan dalam ekspresi wajah, bahasa tubuh, atau respons terhadap pertanyaan kelompok dapat memberikan petunjuk penting mengenai kesejahteraan emosional dan psikologis lansia. Selain itu, pengamatan dapat digunakan untuk menilai apakah lansia merasa dihargai dan diterima dalam kelompok, yang merupakan faktor penting dalam mengurangi isolasi sosial dan meningkatkan rasa percaya diri mereka.

Evaluasi yang komprehensif harus melibatkan feedback dari lansia itu sendiri. Selain menggunakan alat ukur dan pengamatan langsung, penting bagi perawat untuk meminta pendapat lansia tentang program yang telah dilaksanakan. Dengan melakukan wawancara atau diskusi dengan anggota kelompok, perawat dapat mengetahui bagaimana lansia menilai intervensi yang telah dilakukan, apakah mereka merasa lebih baik, lebih terlibat, atau lebih sehat.

Melibatkan lansia dalam proses evaluasi memberikan mereka perasaan kontrol atas perawatan mereka, yang merupakan faktor penting dalam mendukung otonomi dan keterlibatan mereka. Dengan mendapatkan feedback langsung dari lansia, perawat dapat menyesuaikan dan mengoptimalkan program perawatan untuk lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan kelompok tersebut.

Evaluasi efektivitas intervensi dalam kelompok lansia harus dilakukan secara menyeluruh dengan menggunakan berbagai indikator yang mencakup aspek fisik, psikologis, dan sosial. Keberhasilan program kesehatan, seperti peningkatan mobilitas atau pengurangan kecemasan, sangat bergantung pada keterlibatan aktif anggota kelompok dan penyesuaian intervensi yang dilakukan. Melalui evaluasi yang berkelanjutan dan umpan balik langsung dari lansia, perawat dapat memastikan bahwa intervensi yang diberikan benar-benar memenuhi kebutuhan kelompok lansia dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Dalam hal ini, peran perawat sebagai fasilitator sangat penting untuk memantau dan menyesuaikan pendekatan yang diterapkan, sehingga intervensi tetap relevan dan efektif (Touhy & Jett, 2020)

2. Mampu Mengidentifikasi Perubahan Fisik, Psikologis, dan Sosial yang Dialami oleh Lansia dalam Kelompok dan Menilai Dampak Asuhan Keperawatan

Evaluasi efektivitas asuhan keperawatan kelompok lansia memerlukan pemahaman mendalam tentang perubahan fisik, psikologis, dan sosial yang dialami lansia seiring bertambahnya usia. Perubahan fisik pada lansia, seperti penurunan fungsi otot, penurunan mobilitas, atau masalah kesehatan kronis, adalah hal yang umum terjadi. Oleh karena itu, perawat perlu secara rutin memantau perubahan ini dalam kelompok, baik melalui pengukuran langsung seperti tes mobilitas, kekuatan otot, atau pengamatan terhadap kemampuan lansia dalam beraktivitas sehari-hari. Program intervensi fisik yang telah dilakukan, seperti senam lansia atau latihan pernapasan, harus dievaluasi dampaknya terhadap peningkatan kemampuan fisik anggota kelompok. Dengan mengidentifikasi perubahan fisik ini, perawat dapat menentukan apakah intervensi yang diterapkan berhasil meningkatkan atau memelihara fungsi fisik lansia.

Di samping perubahan fisik, perubahan psikologis yang dialami lansia dalam kelompok juga sangat penting untuk dievaluasi. Lansia sering kali mengalami gangguan psikologis seperti depresi, kecemasan, atau penurunan kognitif yang dapat memengaruhi kualitas hidup mereka. Evaluasi terhadap perubahan psikologis ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat ukur standar, seperti skala depresi atau kecemasan, serta pengamatan terhadap perilaku dan respons

lansia selama kegiatan kelompok. Misalnya, penurunan kecemasan atau peningkatan suasana hati dapat teramati dari peningkatan keterlibatan dalam diskusi atau kegiatan sosial. Perawat harus dapat mengidentifikasi lansia yang mungkin membutuhkan intervensi psikologis tambahan dan memastikan bahwa dukungan emosional yang diberikan dalam kelompok cukup efektif untuk membantu mereka mengatasi perasaan kesepian atau stres.

Perubahan sosial dalam kelompok lansia juga merupakan indikator penting dalam mengevaluasi dampak asuhan keperawatan. Lansia yang aktif secara sosial cenderung memiliki kualitas hidup yang lebih baik, karena interaksi sosial yang positif dapat mengurangi perasaan kesepian dan meningkatkan dukungan emosional. Dalam kelompok, perawat harus memperhatikan perubahan dalam dinamika sosial antar anggota kelompok, seperti peningkatan interaksi, berbagi pengalaman, atau keterlibatan dalam aktivitas kelompok. Perawat dapat mengukur peningkatan keterlibatan sosial dengan mengamati seberapa aktif lansia berpartisipasi dalam diskusi, bermain permainan kelompok, atau terlibat dalam kegiatan rekreasi bersama. Jika lansia yang sebelumnya terisolasi mulai menunjukkan peningkatan dalam interaksi sosial, ini menjadi indikator positif bahwa program keperawatan sosial yang diterapkan efektif.

Untuk menilai dampak asuhan keperawatan secara keseluruhan, perawat harus menggabungkan pengamatan fisik, psikologis, dan sosial lansia dalam kelompok untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas intervensi. Hal ini melibatkan pengumpulan data tentang perubahan kesejahteraan fisik (misalnya, peningkatan mobilitas), kesehatan mental (misalnya, penurunan gejala kecemasan), dan interaksi sosial (misalnya, peningkatan keterlibatan dalam kegiatan kelompok). Evaluasi yang menyeluruh akan memberikan informasi yang lebih akurat tentang apakah tujuan asuhan keperawatan telah tercapai. Dengan mengidentifikasi perubahan tersebut, perawat dapat menentukan apakah intervensi yang dilakukan sudah sesuai dengan kebutuhan kelompok lansia dan memberikan hasil yang diharapkan.

Terakhir, evaluasi yang dilakukan harus mengarah pada penyesuaian intervensi yang diperlukan untuk meningkatkan hasil perawatan. Jika perubahan yang diinginkan tidak tercapai atau ada anggota kelompok yang menunjukkan penurunan dalam kondisi fisik, psikologis, atau sosial, perawat perlu melakukan evaluasi mendalam dan merancang intervensi tambahan yang lebih sesuai. Ini dapat melibatkan modifikasi program latihan fisik, memberikan lebih banyak dukungan psikologis kepada anggota yang membutuhkan, atau meningkatkan kegiatan sosial dalam kelompok. Evaluasi berkelanjutan memungkinkan perawat untuk memastikan bahwa asuhan keperawatan tetap relevan dan efektif, serta

memberikan perawatan yang terbaik untuk lansia dalam kelompok, sesuai dengan perubahan kondisi mereka.

Evaluasi dampak asuhan keperawatan dalam kelompok lansia harus memperhatikan perubahan fisik, psikologis, dan sosial yang dialami oleh anggota kelompok secara menyeluruh. Dengan menggunakan indikator yang relevan seperti peningkatan mobilitas, penurunan kecemasan, dan peningkatan keterlibatan sosial, perawat dapat menilai keberhasilan program intervensi. Pendekatan holistik ini memungkinkan perawat untuk merancang rencana perawatan yang lebih responsif terhadap perubahan yang terjadi pada lansia, serta menyesuaikan intervensi agar lebih sesuai dengan kebutuhan kelompok. Evaluasi berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa intervensi yang dilakukan terus memberikan manfaat yang optimal bagi lansia (Touhy & Jett, 2020)

F. Mengidentifikasi Tantangan dalam Keperawatan Kelompok Lansia dan Solusi yang Tepat

1. Mampu Mengidentifikasi Tantangan yang Sering Muncul dalam Perawatan Kelompok Lansia, Seperti Perbedaan Kondisi Fisik Antar Anggota Kelompok atau Masalah Komunikasi dalam Kelompok

Perawatan kelompok lansia sering kali menghadapi tantangan besar yang berkaitan dengan perbedaan kondisi fisik antar anggota kelompok. Lansia dalam satu kelompok dapat memiliki rentang kondisi kesehatan yang sangat beragam, mulai dari mereka yang relatif sehat hingga yang menghadapi gangguan mobilitas atau penyakit kronis. Misalnya, anggota kelompok yang menderita osteoarthritis atau gangguan jantung mungkin mengalami kesulitan dalam mengikuti aktivitas fisik bersama, seperti senam lansia atau latihan beban yang disarankan untuk meningkatkan fleksibilitas dan kekuatan tubuh. Ketidakseimbangan kondisi fisik ini dapat menyebabkan perasaan tidak nyaman di antara anggota yang lebih sehat, serta keterbatasan dalam partisipasi aktif. Oleh karena itu, tantangan ini memerlukan perhatian khusus dari perawat untuk memastikan bahwa semua anggota kelompok merasa dapat berpartisipasi dalam kegiatan dengan cara yang sesuai dengan kemampuan fisik mereka.

Untuk mengatasi tantangan ini, penyesuaian kegiatan menjadi sangat penting. Perawat perlu merancang program yang dapat disesuaikan dengan tingkat kesehatan fisik anggota kelompok. Misalnya, senam atau latihan peregangan bisa dilakukan dengan variasi intensitas, sehingga anggota yang memiliki keterbatasan fisik tetap dapat mengikuti aktivitas tanpa merasa terbebani. Perawat juga dapat memberikan alternatif kegiatan yang lebih ringan,

seperti latihan pernapasan atau meditasi, yang tetap bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan fisik dan psikologis lansia. Kunci utama di sini adalah fleksibilitas dalam pendekatan perawatan dan keterlibatan semua anggota kelompok dengan mempertimbangkan batasan fisik mereka.

Selain perbedaan kondisi fisik, masalah komunikasi juga menjadi tantangan utama dalam perawatan kelompok lansia. Lansia sering kali menghadapi masalah pendengaran atau gangguan kognitif seperti demensia, yang dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk berkomunikasi dengan baik dalam kelompok. Gangguan komunikasi ini dapat menciptakan hambatan dalam interaksi sosial, serta membuat beberapa anggota merasa terisolasi atau kesulitan untuk mengikuti diskusi kelompok. Masalah komunikasi ini juga dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam pelaksanaan instruksi atau kegiatan kelompok, sehingga menurunkan efektivitas perawatan yang diberikan. Dalam hal ini, perawat perlu mengidentifikasi lansia yang mungkin memiliki kesulitan komunikasi dan memberikan dukungan tambahan, seperti berbicara lebih jelas, menggunakan alat bantu dengar jika diperlukan, atau memfasilitasi percakapan dengan cara yang lebih sederhana.

Untuk mengatasi masalah komunikasi, strategi komunikasi yang efektif harus diterapkan. Perawat dapat menggunakan teknik komunikasi yang lebih jelas dan lebih lambat, serta mendengarkan dengan penuh perhatian ketika lansia berbicara. Selain itu, menggunakan media visual, seperti gambar atau tulisan besar, dapat membantu lansia yang mengalami gangguan pendengaran atau kognitif untuk lebih memahami instruksi atau informasi yang diberikan. Perawat juga bisa memanfaatkan teknologi, seperti alat bantu dengar atau perangkat komunikasi digital, yang dapat meningkatkan kemampuan lansia dalam berinteraksi dengan anggota kelompok lainnya. Pendekatan ini akan memastikan bahwa setiap anggota kelompok memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan merasa dihargai dalam setiap kegiatan.

Perbedaan dalam status sosial dan budaya juga dapat mempengaruhi dinamika komunikasi dan interaksi dalam kelompok lansia. Anggota kelompok lansia sering kali datang dari latar belakang yang berbeda, dengan nilai-nilai budaya dan sosial yang bervariasi. Hal ini dapat menyebabkan ketegangan atau kesulitan dalam berinteraksi satu sama lain, terutama jika ada perbedaan dalam cara berpikir atau menyikapi perawatan kesehatan. Dalam situasi seperti ini, perawat harus memiliki kemampuan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan mengurangi potensi konflik yang bisa muncul karena perbedaan tersebut. Menghargai keberagaman, memahami perspektif budaya yang berbeda, dan

memberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman pribadi dapat memperkaya interaksi dalam kelompok dan memperkuat rasa kebersamaan.

Tantangan dalam perawatan kelompok lansia juga dapat muncul dari keterbatasan sumber daya, baik itu waktu, fasilitas, atau dukungan dari anggota keluarga. Seringkali, perawat harus mengelola berbagai anggota kelompok dengan kondisi yang sangat berbeda, sementara sumber daya yang tersedia terbatas. Dalam hal ini, manajemen sumber daya yang efisien menjadi sangat penting. Perawat harus mampu merencanakan dan mengatur kegiatan kelompok dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada, seperti waktu atau tenaga yang terbatas, namun tetap memberikan perhatian yang optimal kepada setiap lansia. Dengan perencanaan yang matang dan penggunaan sumber daya secara efektif, perawat dapat memastikan bahwa semua anggota kelompok menerima perawatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, meskipun ada tantangan dalam pengelolaan sumber daya.

Perawatan kelompok lansia memang sering menghadapi berbagai tantangan, baik yang berkaitan dengan kondisi fisik yang bervariasi, masalah komunikasi, atau perbedaan sosial budaya di antara anggota kelompok. Dalam menghadapi tantangan tersebut, penting bagi perawat untuk mengembangkan keterampilan dalam membuat penyesuaian yang diperlukan untuk mendukung partisipasi aktif setiap lansia. Dengan merancang program yang fleksibel dan mengadopsi strategi komunikasi yang sesuai, perawat dapat mengurangi hambatan yang mungkin muncul dalam kelompok. Selain itu, pendekatan berbasis keberagaman sosial dan budaya sangat penting untuk memastikan bahwa setiap anggota merasa diterima dan dihargai dalam kelompok, sehingga meningkatkan efektivitas intervensi keperawatan (Touhy & Jett, 2020)

2. Merumuskan Solusi Praktis Dan Strategi Untuk Mengatasi Tantangan Asuhan Keperawatan Lansia Dalam Konteks Kelompok

Mengatasi tantangan dalam perawatan kelompok lansia memerlukan pendekatan yang kreatif dan fleksibel, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu dalam kelompok yang beragam. Salah satu tantangan utama dalam keperawatan kelompok adalah perbedaan kondisi fisik antar anggota kelompok. Lansia yang memiliki kemampuan fisik yang lebih terbatas mungkin kesulitan untuk mengikuti aktivitas yang dirancang untuk kelompok secara keseluruhan. Untuk mengatasi tantangan ini, perawat perlu merancang kegiatan yang dapat disesuaikan dengan kemampuan fisik masing-masing lansia. Misalnya, senam lansia dapat dilakukan dengan berbagai tingkat intensitas, memungkinkan lansia dengan keterbatasan fisik untuk berpartisipasi pada tingkat yang sesuai dengan kemampuan mereka. Selain itu, alternatif aktivitas fisik yang lebih ringan, seperti

latihan pernapasan atau terapi fisik, juga dapat disertakan untuk memastikan bahwa semua anggota kelompok mendapatkan manfaat dari program tersebut.

Masalah komunikasi juga sering kali menjadi tantangan dalam perawatan kelompok lansia, terutama ketika anggota kelompok memiliki gangguan pendengaran atau gangguan kognitif seperti demensia. Untuk mengatasi masalah ini, perawat dapat menggunakan strategi komunikasi yang lebih inklusif. Salah satunya adalah dengan berbicara lebih jelas dan perlahan, serta menggunakan bahasa tubuh dan isyarat visual untuk membantu lansia yang kesulitan mendengar atau memahami instruksi verbal. Penggunaan alat bantu dengar atau teknologi pendukung juga dapat diintegrasikan dalam perawatan kelompok untuk memastikan bahwa semua anggota kelompok dapat mendengar dan berpartisipasi dengan lebih baik. Selain itu, perawat bisa memperkenalkan sesi komunikasi non-verbal, seperti kegiatan seni atau kerajinan tangan, yang dapat menjadi cara efektif untuk meningkatkan interaksi sosial dalam kelompok.

Tantangan lain yang sering muncul adalah isolasi sosial, terutama bagi lansia yang tidak memiliki banyak keluarga atau teman dekat. Dalam kelompok lansia, perawat dapat merumuskan strategi untuk membangun hubungan sosial yang kuat antara anggota kelompok. Salah satu solusi praktis adalah dengan menciptakan aktivitas yang mendorong lansia untuk saling berinteraksi dan bekerja sama, seperti permainan kelompok, diskusi berbasis minat, atau kegiatan berbagi pengalaman hidup. Dengan memberikan ruang bagi lansia untuk berbicara tentang kehidupan mereka, perawat dapat membantu mereka merasa lebih terhubung satu sama lain dan mengurangi perasaan kesepian. Selain itu, kegiatan yang melibatkan keluarga atau teman dekat juga bisa diperkenalkan untuk memperkuat jaringan dukungan sosial lansia.

Perbedaan dalam latar belakang sosial dan budaya di antara anggota kelompok juga dapat menciptakan ketegangan atau hambatan dalam interaksi. Lansia yang berasal dari latar belakang yang berbeda mungkin memiliki persepsi atau nilai-nilai yang berbeda tentang perawatan kesehatan, gaya hidup, atau cara berinteraksi dengan orang lain. Solusi untuk mengatasi tantangan ini adalah dengan memfasilitasi dialog terbuka tentang keberagaman budaya dalam kelompok dan menciptakan lingkungan yang inklusif. Perawat dapat mengadakan diskusi kelompok yang membahas topik-topik yang relevan dengan kehidupan sehari-hari lansia, di mana mereka dapat berbagi pandangan dan pengalaman tanpa merasa dihakimi. Ini juga dapat memperkaya interaksi sosial dalam kelompok dan meningkatkan rasa saling menghormati antar anggota.

Dalam mengimplementasikan solusi-solusi ini, perawat perlu memantau dan mengevaluasi secara terus-menerus untuk memastikan bahwa strategi yang

diterapkan efektif. Evaluasi dilakukan melalui observasi langsung terhadap keterlibatan lansia dalam kegiatan kelompok dan melalui umpan balik dari anggota kelompok tentang perasaan mereka terhadap kegiatan yang dilakukan. Jika diperlukan, perawat dapat melakukan penyesuaian terhadap program perawatan kelompok untuk lebih sesuai dengan kebutuhan lansia. Dengan menggunakan pendekatan berbasis evaluasi, perawat dapat memastikan bahwa solusi yang diberikan terus relevan dan mampu mengatasi tantangan yang ada dalam kelompok, sehingga mencapai tujuan meningkatkan kualitas hidup lansia.

G. Latihan Soal

Soal Pilihan Ganda

1. Apa yang dimaksud dengan perawatan kelompok lansia?
 - A. Perawatan yang diberikan hanya untuk satu orang lansia pada satu waktu
 - B. Perawatan yang melibatkan beberapa lansia dengan pendekatan yang sama dalam satu kelompok
 - C. Perawatan yang dilakukan oleh keluarga di rumah
 - D. Perawatan yang hanya fokus pada kesehatan fisik lansia
 - E. Perawatan yang diberikan oleh satu tenaga medis untuk setiap anggota keluargaA
2. APA perbedaan utama antara perawatan individu dan kelompok dalam konteks keperawatan lansia?
 - A. Perawatan kelompok lebih berfokus pada kebutuhan fisik lansia
 - B. Perawatan individu hanya mencakup masalah psikologis
 - C. Perawatan kelompok melibatkan interaksi sosial antar anggota kelompok
 - D. Perawatan individu melibatkan interaksi sosial lebih banyak
 - E. Perawatan kelompok hanya dilakukan di rumah sakit
3. Dalam merencanakan asuhan keperawatan kelompok lansia, intervensi yang paling tepat untuk menangani masalah kesehatan lansia adalah:
 - A. Program yang hanya fokus pada perawatan medis
 - B. Pengelolaan penyakit kronis secara individu
 - C. Program promosi kesehatan yang mengajak seluruh anggota kelompok berpartisipasi
 - D. Pengobatan yang diberikan secara rutin tanpa evaluasi
 - E. Penggunaan teknologi untuk memantau kesehatan tanpa interaksi social

4. Apa yang menjadi tantangan utama dalam mengimplementasikan asuhan keperawatan kelompok lansia?
 - A. Mengabaikan kebutuhan spiritual lansia
 - B. Tidak ada cukup tenaga kesehatan untuk mendampingi kelompok
 - C. Dinamika kelompok yang tidak mendukung kerjasama antar anggota
 - D. Terlalu banyak intervensi medis yang diterapkan
 - E. Keterbatasan sumber daya dalam perawatan fisik
5. Salah satu tujuan utama dalam merencanakan asuhan keperawatan untuk kelompok lansia adalah:
 - A. Meningkatkan pengobatan medis secara pribadi
 - B. Menciptakan interaksi sosial yang minimal antar anggota kelompok
 - C. Meningkatkan kualitas hidup lansia dengan pendekatan yang terintegrasi
 - D. Mengurangi jumlah kegiatan fisik dalam kelompok
 - E. Menghindari program pencegahan kesehatan

Soal Essay

1. Jelaskan perbedaan antara perawatan individu dan perawatan kelompok lansia. Berikan contoh situasi di mana perawatan kelompok lebih efektif daripada perawatan individu dalam konteks keperawatan lansia.?
2. Bagaimana Anda dapat mengevaluasi kebutuhan kesehatan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual lansia dalam kelompok? Sebutkan faktor-faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam penilaian tersebut?
3. Dalam merencanakan asuhan keperawatan kelompok lansia, apa saja hal yang perlu dipertimbangkan dalam merancang intervensi? Jelaskan bagaimana rencana tersebut dapat mencakup pencegahan, promosi kesehatan, dan pengelolaan penyakit kronis?
4. Mengapa evaluasi penting dalam keperawatan kelompok lansia? Jelaskan cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengevaluasi hasil intervensi dalam kelompok lansia, serta indikator-indikator yang perlu diperhatikan dalam proses evaluasi.
5. Identifikasi tantangan yang dapat muncul dalam mengelola keperawatan kelompok lansia dan berikan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Bagaimana cara Anda memastikan bahwa semua lansia dalam kelompok mendapatkan perhatian yang setara dan sesuai kebutuhan?

Kunci Jawaban soal pilihan Ganda

1. B
2. C
3. C
4. C
5. C

Jawaban esay

1. Perawatan kelompok lansia memiliki keunikan dibandingkan dengan perawatan individu. Dalam perawatan individu, perhatian diberikan hanya kepada satu pasien dengan pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi medisnya. Sementara itu, perawatan kelompok melibatkan beberapa lansia dalam satu setting, dengan perhatian terhadap dinamika kelompok yang dapat memengaruhi interaksi sosial, kesejahteraan emosional, dan pengelolaan kesehatan lansia secara bersama-sama. Contohnya, pada lansia dengan demensia, perawatan kelompok dapat lebih efektif dalam mengurangi kesepian dan meningkatkan keterlibatan sosial, karena interaksi antar sesama lansia dapat memberikan dukungan emosional yang saling menguatkan.
2. Dalam mengevaluasi kebutuhan kesehatan lansia dalam kelompok, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Kebutuhan fisik, seperti kondisi medis yang ada dan mobilitas fisik lansia, perlu dinilai melalui pemeriksaan medis dan riwayat kesehatan. Selain itu, kebutuhan psikologis juga penting, mengingat banyak lansia yang menghadapi kecemasan atau depresi, yang mempengaruhi kualitas hidup mereka. Kebutuhan sosial, seperti dukungan dari keluarga dan teman, serta kebutuhan spiritual, yang mencakup praktik keagamaan atau nilai-nilai yang dianggap penting oleh lansia, juga harus diperhitungkan. Faktor-faktor seperti latar belakang sosial-ekonomi, kondisi lingkungan, serta pengalaman hidup lansia memengaruhi kesejahteraan mereka dalam kelompok. Penilaian yang menyeluruh akan membantu merancang intervensi yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan mereka.
3. Merencanakan asuhan keperawatan untuk kelompok lansia memerlukan pendekatan yang menyeluruh. Penting untuk merancang intervensi yang mencakup pencegahan, promosi kesehatan, dan pengelolaan penyakit kronis. Pencegahan, misalnya, bisa melibatkan vaksinasi, program latihan fisik untuk mengurangi risiko jatuh, serta edukasi tentang pola makan sehat. Promosi kesehatan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan lansia tentang gaya hidup sehat, seperti pentingnya menjaga kebugaran fisik, serta kesehatan mental dan sosial. Selain itu, pengelolaan penyakit kronis, seperti diabetes atau

hipertensi, harus diperhatikan dengan menyediakan program pengelolaan yang melibatkan pemantauan rutin, edukasi mengenai pengobatan, dan perhatian terhadap perubahan kondisi yang mungkin terjadi. Setiap rencana intervensi harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing lansia dalam kelompok, dengan mempertimbangkan kebutuhan medis dan sosial mereka.

4. Evaluasi sangat penting dalam perawatan kelompok lansia untuk menilai apakah intervensi yang diterapkan memberikan hasil yang diinginkan. Evaluasi ini meliputi perubahan kondisi fisik, psikologis, dan sosial lansia setelah intervensi. Beberapa indikator yang dapat digunakan dalam evaluasi adalah perubahan dalam mobilitas fisik, tingkat kecemasan atau depresi, dan tingkat partisipasi sosial dalam kegiatan kelompok. Selain itu, hasil intervensi dapat diukur dengan survei atau wawancara untuk mengetahui seberapa besar peningkatan kualitas hidup dan kepuasan lansia terhadap perawatan yang diberikan. Evaluasi ini juga membantu dalam merencanakan perbaikan atau penyesuaian program jika diperlukan.
5. Tantangan dalam mengelola keperawatan kelompok lansia sering kali terkait dengan perbedaan kebutuhan individu di dalam kelompok yang sama. Setiap lansia mungkin memiliki kebutuhan yang berbeda, baik dalam hal perawatan fisik maupun emosional. Dinamika sosial dalam kelompok juga dapat memengaruhi efektivitas perawatan, di mana interaksi antar anggota kelompok bisa menjadi hambatan atau, sebaliknya, menjadi sumber dukungan yang positif. Keterbatasan sumber daya, baik dari segi tenaga kesehatan maupun fasilitas, juga sering menjadi tantangan dalam memberikan perawatan yang optimal. Untuk mengatasi tantangan ini, penting untuk melakukan penilaian yang cermat terhadap kebutuhan masing-masing individu dalam kelompok, serta menyediakan strategi komunikasi dan pengelolaan yang efektif untuk memastikan setiap lansia mendapat perhatian yang adil. Pembagian kelompok berdasarkan kebutuhan spesifik dan pendampingan individual bagi lansia yang memerlukan perhatian lebih adalah solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan ini.

H. Rangkuman Materi

Buku ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang perawatan lansia dalam konteks kelompok, dimulai dengan konsep dasar perawatan kelompok yang membedakan antara perawatan individu dan kelompok. Dalam Bab 1, dibahas mengenai prinsip-prinsip dasar keperawatan kelompok lansia, yang melibatkan pendekatan holistik dan interaksi sosial dalam kelompok untuk meningkatkan kesejahteraan lansia secara keseluruhan. Bab 2 melanjutkan dengan mengevaluasi

kebutuhan kesehatan lansia dalam kelompok, termasuk kebutuhan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan mereka. Penilaian ini menjadi dasar penting dalam merancang rencana asuhan yang tepat.

Selanjutnya, dalam Bab 3, mahasiswa diajarkan cara menyusun rencana asuhan keperawatan yang melibatkan intervensi berbasis bukti, dengan pendekatan kelompok untuk menangani masalah kesehatan lansia, seperti pencegahan penyakit dan pengelolaan penyakit kronis. Bab 4 mengajarkan implementasi asuhan keperawatan kelompok, yang melibatkan penerapan intervensi sesuai dengan dinamika kelompok dan kebutuhan individu. Evaluasi terhadap hasil intervensi dilakukan dalam Bab 5, yang mengajarkan bagaimana menggunakan indikator yang tepat untuk menilai perubahan kondisi fisik, psikologis, dan sosial lansia serta efektivitas intervensi yang telah dilakukan.

Akhirnya, Bab 6 membahas tantangan yang dapat muncul dalam perawatan kelompok lansia, seperti perbedaan kebutuhan individu, dinamika sosial, dan keterbatasan sumber daya. Buku ini memberikan solusi praktis untuk mengatasi masalah tersebut, dengan penekanan pada strategi komunikasi yang efektif dan pembagian perhatian yang setara di dalam kelompok. Secara keseluruhan, buku ini memberikan panduan menyeluruh yang menggabungkan teori dan praktik, membantu mahasiswa dan tenaga kesehatan untuk memberikan perawatan kelompok yang efektif, serta meningkatkan kualitas hidup lansia melalui pendekatan yang terintegrasi.

I. Glosarium

Asuhan Keperawatan Lansia

Proses pemberian perawatan yang terencana dan terintegrasi, yang meliputi penilaian, diagnosis, intervensi, dan evaluasi terhadap kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual lansia.

Keperawatan Kelompok

Model perawatan yang melibatkan beberapa individu dalam satu kelompok untuk mendapatkan perawatan dan dukungan sosial secara bersamaan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan fisik dan emosional mereka.

Dinamika Kelompok

Proses interaksi yang terjadi di dalam kelompok, yang mempengaruhi hubungan antar anggota kelompok, serta pengaruh sosial yang ada dalam kelompok tersebut.

Pendekatan Holistik

Pendekatan yang memperhatikan semua aspek kehidupan individu, termasuk fisik, psikologis, sosial, dan spiritual dalam memberikan perawatan.

Kebutuhan Kesehatan Lansia

Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam perawatan lansia, meliputi kebutuhan fisik (seperti perawatan penyakit kronis), psikologis (seperti dukungan emosional), sosial (seperti interaksi sosial dan dukungan), serta spiritual (seperti keyakinan dan praktik keagamaan).

Intervensi Keperawatan

Langkah-langkah yang diambil oleh tenaga kesehatan untuk mengatasi masalah kesehatan yang dihadapi pasien, baik berupa pengobatan, terapi, pencegahan, maupun promosi kesehatan.

Rencana Asuhan Keperawatan

Dokumen yang merinci langkah-langkah perawatan yang akan diberikan kepada pasien, berdasarkan evaluasi kebutuhan kesehatan pasien, dan disesuaikan dengan kondisi medis serta keadaan sosial pasien.

Pencegahan Penyakit

Tindakan yang dilakukan untuk mencegah timbulnya penyakit atau komplikasi kesehatan lebih lanjut, seperti vaksinasi, perubahan gaya hidup, dan pendidikan kesehatan.

Promosi Kesehatan

Usaha untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang gaya hidup sehat serta mengubah perilaku untuk mencegah penyakit dan meningkatkan kualitas hidup.

Pengelolaan Penyakit Kronis

Pendekatan dalam mengelola penyakit yang berlangsung lama atau tidak dapat sembuh sepenuhnya, seperti diabetes, hipertensi, atau arthritis, dengan fokus pada pencegahan komplikasi dan peningkatan kualitas hidup pasien.

Evaluasi Keperawatan

Proses untuk menilai efektivitas intervensi keperawatan yang telah diberikan, dengan menggunakan indikator untuk mengukur perubahan kondisi fisik, psikologis, dan sosial pasien.

Indikator Kesehatan

Alat ukur yang digunakan untuk menilai kondisi kesehatan lansia, seperti tingkat mobilitas, tekanan darah, tingkat kecemasan, atau partisipasi dalam kegiatan sosial.

Tantangan dalam Keperawatan Lansia

Masalah atau hambatan yang sering dihadapi dalam perawatan lansia, termasuk perbedaan kebutuhan antara anggota kelompok, keterbatasan sumber daya, dan masalah dalam komunikasi antar anggota kelompok.

Solusi Keperawatan

Strategi atau langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi tantangan dalam perawatan kelompok lansia, termasuk pengelolaan interaksi sosial, pembagian perhatian yang adil, dan penggunaan teknologi dalam pengelolaan perawatan.

Kelompok Lansia

Sekelompok individu yang berusia lanjut, yang diperlakukan sebagai unit dalam perawatan untuk mendapatkan manfaat dari interaksi sosial serta dukungan dari sesama anggota kelompok.

Dukungan Sosial

Sistem yang memberikan dukungan emosional, fisik, dan sosial kepada lansia, termasuk keluarga, teman, atau anggota kelompok, yang dapat mempengaruhi kesejahteraan mereka secara keseluruhan.

Kesejahteraan Sosial

Kondisi di mana lansia memiliki dukungan sosial yang memadai, merasa diterima dalam komunitas, dan terlibat dalam interaksi sosial yang positif.

Kesejahteraan Psikologis

Kesehatan mental yang baik, yang melibatkan perasaan bahagia, rasa percaya diri, serta kemampuan untuk mengatasi stres dan masalah emosional.

Kesejahteraan Spiritual

Kondisi di mana lansia merasa terhubung dengan keyakinan atau praktik keagamaan mereka, yang dapat memberikan kedamaian batin dan makna dalam kehidupan mereka.

Interaksi Sosial Lansia

Proses komunikasi dan hubungan yang dibangun oleh lansia dengan orang lain, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun kelompok sebaya, yang mempengaruhi kualitas hidup mereka.

PROFIL PENULIS



Heri Triwibowo, SKM., SKep., Ns., M.Kes, Lahir di Magetan, 24 Juli 1976. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga tahun 2000 dan S1 Keperawatan UNIPDU Jombang tahun 2007. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 UNS dan lulus tahun 2014. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2003 AKPER Bina Sehat PPNI, STIKes Bina Sehat sampai berubah jadi Universitas Bina Sehat PPNI Mojokerto. Saat ini penulis bekerja di Universitas Bina Sehat PPNI Mojokerto mengampu mata kuliah Promkes, Keluarga, Gerontik, Antropologi, Komunitas. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: heriubspgni@gmail.com



Lola Illona Elfani Kausar, S.Kep., Ns., M.Kep.
Assalamualaikum wr wb. Penulis memiliki kepakaran dibidang Ilmu Keperawatan Komunitas, Keluarga dan Gerontik. Penulis lulusan Magister Keperawatan Konsentrasi Komunitas, Keluarga, Gerontik Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia pada tahun 2020. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen di Program Studi Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat tepatnya di departemen Keperawatan Komunitas, Keluarga dan Gerontik (KKG) sejak 2016 hingga sekarang. Penelitian-penelitian penulis sebelumnya lebih banyak terkait dengan komunitas agregat dewasa dan keperawatan keluarga. Namun, saat ini penulis sedang mengembangkan kemampuan dalam meneliti dan menulis buku terkait lanjut usia atau keperawatan gerontik. Tulisan ini penulis harapkan menjadi langkah awal dalam mengasah lagi pengetahuan penulis terkait keperawatan gerontik sehingga penulis dapat terus memberikan kontribusi terhadap perkembangan keperawatan gerontik khususnya. Penulis juga berharap tulisan ini dapat memperkaya pengetahuan kita terkait konsep lanjut usia serta memberikan kontribusi positif terhadap ilmu keperawatan. Wassalamualaikum wr wb
Email Penulis: lola.kausar@ulm.ac.id

PROFIL PENULIS



Ns Deni Metri, S.Kep., M. Kes. Penulis menyelesaikan Pendidikan S 1 di Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Andalas, kemudian melanjutkan Pendidikan Program Pasca sarjana S2 di Universitas Mitra Lampung tahun 2016. Riwayat pekerjaan, Dari tahun 1997 s. d 1998, sebagai pengajar di Akper Panca Bhakti Lampung. Tahun 1998 - 2014 di pelayanan Kesehatan. Tahun 2014 sampai dengan saat ini penulis adalah dosen tetap Poltekkes Tanjungkarang Program Studi Keperawatan Kotabumi. Mata kuliah yang diampu adalah Keperawatan dasar, Keperawatan gerontik, Keperawatan anak, Etika Keperawatan.

Penulis adalah anggota Asosiasi Dosen Indonesia (ADI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) propinsi Lampung. Selain melakukan penelitian, penulis juga aktif dalam penerbitan buku antara lain Buku Ajar keperawatan Gerontik untuk D III Keperawatan, Konsep Dasar Perawatan Lansia, Penyakit Umum pada lansia dan manajemennya, Latihan Soal Etik Edisi Etikolegal, Keperawatan Dasar: Kebutuhan Dasar Manusia menurut Handerson & asuhan keperawatan pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan pendekatan SDKI, SLKI dan SIKI PPNI. Buku Ajar Keperawatan Anak, Asuhan Keperawatan Akut pada Anak, Asuhan Keperawatan anak dengan Penyakit Kronis. Semua yang sudah dilakukan penulis, dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara. Penulis dapat dihubungi melalui E-mail denimetri88@gmail.com.



Penulis lahir di Trenggalek 04 Maret 1976. Jenjang akademik penulis dimulai di Akademi Keperawatan Kosgoro Mojokerto lulus tahun 1998, dan melanjutkan pendidikan S1 Keperawatan sekaligus pendidikan profesi Ners di program Studi Ilmu Keperawatan PSIK Unari Surabaya lulus tahun 2007. Dan melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Sebelas Maret Surakarta lulus tahun 2011. Sejak tahun 1999 penulis menjadi staf dosen Keperawatan di Akademi Keperawatan Kosgoro Mojokerto. Penulis pernah menjabat sebagai Pembantu Direktur III tahun 2010. Pada tahun 2013 penulis berpindah kerja di STIKES Dian Husada Mojokerto dan pada

tahun 2014 penulis mendapat tugas tambahan sebagai Ketua LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) sampai sekarang ini. Dengan tugas tambahan tersebut penulis aktif melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat baik yang dinai internal Perguruan Tinggi maupun eksternal Perguruan Tinggi. Aktif mempublikasikan artikel penelitian pengabdian masyarakat di jurnal Nasional terakreditasi maupun International terindex. Penulis juga aktif bergabung dalam relawan BSMI (Bulan Sabit Merah Indonesia) Mojokerto serta menjadi pengurus Ikatan Perawat Gerontik Indonesia (IPEGRI) Jawa Timur.

PROFIL PENULIS



Ns. Dely Maria P, M.Kep., Sp.Kep.Kom, lahir di Pontianak. Penulis bertempat tinggal di Bekasi. Menyelesaikan pendidikan D-III Keperawatan di Poltekes Cirebon (tahun 2000) kemudian melanjutkan ke jenjang S1 di STIK Sint Carolus (2004) dan Spesialis Keperawatan Komunitas di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia (2015). Penulis memulai karir sebagai dosen tetap di Akper Yatna Yuana Lebak Rangkasbitung tahun 2004-2006, Akademi Kesehatan Yayasan Rumah Sakit Jakarta (2007 – Juni 2021). Saat ini aktif di Program Studi Pendidikan Profesi Ners Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia.

Penulis merupakan pengurus PP IPEGERI (2024 – sekarang). Berkontribusi di dunia keperawatan dengan aktif sebagai penulis buku keperawatan.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: delymaria.panggabean@uki.ac.id

Motto: "Proses tidak mengingkari hasil"



Daning Widi Istianti, S.Kep., Ns., MSN. Lahir di Yogyakarta, 14 November 1989. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Keperawatan dan Ners, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bethesda Yakkum tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada St. Paul University Manila dan lulus tahun 2019. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2015 bekerja sebagai staff di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bethesda Yakkum dan mendapatkan beasiswa pendidikan melanjutkan S2. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen tetap dan mengampu mata kuliah Keperawatan Gerontik. Keperawatan Keluarga dan Keperawatan Komunitas, juga mata kuliah lain

pada program studi Sarjana Keperawatan. Penulis juga berperan sebagai fasilitator dalam pelatihan Caregiver yang dilaksanakan oleh Be Health TC yang telah terakreditasi oleh Kementerian Kesehatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, berpartisipasi aktif dalam kegiatan ilmiah, termasuk menjadi pengurus dalam organisasi Ikatan Perawat Gerontik Indonesia (IPEGERI) DIY. Penulis mendapatkan Hibah dari Kemenristek-Brin dengan fokus pada kelompok lansia dan keluarga dengan lansia. Hibah juga diperoleh dari institusi untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan roadmap. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: daning@stikesbethesda.ac.id

Motto: "You can't avoid getting old, but you can choose to stay productive and live with dignity".

PROFIL PENULIS



Ali Syahbana Lahir di Banyuwangi, Pendidikan tinggi S2 pada Jember pada tahun 2018. Saat ini penulis bekerja di STIKES Banyuwangi mengampu mata kuliah keperawatan gerontik, keluarga, Komunitas Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: alistikesunej@gmail.com

Motto: " *Mind, Spirit, Soul*"

Sinopsis

Buku Ajar Keperawatan Gerontik disusun sebagai sumber belajar komprehensif bagi mahasiswa keperawatan, dosen, dan praktisi yang ingin memahami secara mendalam konsep, prinsip, serta penerapan asuhan keperawatan pada lansia. Buku ini lahir dari kebutuhan akan referensi ilmiah yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebijakan kesehatan nasional dalam menghadapi fenomena peningkatan populasi lanjut usia (aging population).

Isi buku ini membahas berbagai aspek penting dalam keperawatan gerontik secara sistematis dan holistik. Dimulai dari konsep dasar penuaan, teori proses menua, perubahan anatomi dan fisiologi pada lansia, hingga aspek psikologis, sosial, dan spiritual yang menyertai proses penuaan. Setiap bab dirancang untuk membantu mahasiswa memahami hubungan antara teori dan praktik klinik, serta menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan reflektif dalam memberikan asuhan keperawatan yang berfokus pada kesejahteraan lansia.

Selain menguraikan berbagai masalah kesehatan yang umum dialami lansia seperti gangguan mobilitas, nutrisi, kognitif, dan penyakit degeneratif, buku ini juga menekankan pentingnya pendekatan interprofesional, komunikasi terapeutik, etika keperawatan, serta penghormatan terhadap nilai dan martabat lansia. Penulis juga menambahkan pembahasan mengenai intervensi keperawatan berbasis bukti (evidence-based practice), promosi kesehatan lansia, serta upaya pencegahan komplikasi melalui pendekatan holistik dan humanistik.

Buku ini disusun dengan mengacu pada kurikulum pendidikan tinggi keperawatan yang berlaku, dilengkapi dengan hasil penelitian terkini, pedoman dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), dan rekomendasi dari World Health Organization (WHO). Dengan penyajian yang komunikatif, ilustrasi yang mendukung, serta latihan kasus dan refleksi klinik, buku ini tidak hanya menjadi bacaan ilmiah, tetapi juga menjadi panduan praktis dalam penerapan asuhan keperawatan gerontik di berbagai tatanan pelayanan kesehatan.

Secara keseluruhan, Buku Ajar Keperawatan Gerontik diharapkan dapat memperkuat kompetensi mahasiswa dalam memberikan asuhan keperawatan yang aman, efektif, dan bermartabat kepada lansia. Buku ini menjadi kontribusi penting dalam mencetak perawat profesional yang mampu menjawab tantangan pelayanan kesehatan lansia di era modern, serta berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup lansia di Indonesia dan dunia.

Buku Ajar Keperawatan Gerontik disusun sebagai sumber belajar komprehensif bagi mahasiswa keperawatan, dosen, dan praktisi yang ingin memahami secara mendalam konsep, prinsip, serta penerapan asuhan keperawatan pada lansia. Buku ini lahir dari kebutuhan akan referensi ilmiah yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebijakan kesehatan nasional dalam menghadapi fenomena peningkatan populasi lanjut usia (aging population).

Isi buku ini membahas berbagai aspek penting dalam keperawatan gerontik secara sistematis dan holistik. Dimulai dari konsep dasar penuaan, teori proses menua, perubahan anatomi dan fisiologi pada lansia, hingga aspek psikologis, sosial, dan spiritual yang menyertai proses penuaan. Setiap bab dirancang untuk membantu mahasiswa memahami hubungan antara teori dan praktik klinik, serta menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan reflektif dalam memberikan asuhan keperawatan yang berfokus pada kesejahteraan lansia.

Selain menguraikan berbagai masalah kesehatan yang umum dialami lansia seperti gangguan mobilitas, nutrisi, kognitif, dan penyakit degeneratif, buku ini juga menekankan pentingnya pendekatan interprofesional, komunikasi terapeutik, etika keperawatan, serta penghormatan terhadap nilai dan martabat lansia. Penulis juga menambahkan pembahasan mengenai intervensi keperawatan berbasis bukti (evidence-based practice), promosi kesehatan lansia, serta upaya pencegahan komplikasi melalui pendekatan holistik dan humanistik.

Buku ini disusun dengan mengacu pada kurikulum pendidikan tinggi keperawatan yang berlaku, dilengkapi dengan hasil penelitian terkini, pedoman dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), dan rekomendasi dari World Health Organization (WHO). Dengan penyajian yang komunikatif, ilustrasi yang mendukung, serta latihan kasus dan refleksi klinik, buku ini tidak hanya menjadi bacaan ilmiah, tetapi juga menjadi panduan praktis dalam penerapan asuhan keperawatan gerontik di berbagai tatanan pelayanan kesehatan.

Secara keseluruhan, Buku Ajar Keperawatan Gerontik diharapkan dapat memperkuat kompetensi mahasiswa dalam memberikan asuhan keperawatan yang aman, efektif, dan bermartabat kepada lansia. Buku ini menjadi kontribusi penting dalam mencetak perawat profesional yang mampu menjawab tantangan pelayanan kesehatan lansia di era modern, serta berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup lansia di Indonesia dan dunia.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7426-28-4



9

786347

426284

